

정책연구 2024-09

신기술 분야 정부 가이드라인의 실효성 제고 방안

- 바이오헬스 사례를 중심으로 -

Measures to improve the effectiveness of government guidelines
in the field of new technologies

김석관·김종립·진설아·모미령·배용호

내 부 저 자

연구책임자 | 김석관 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 | 김종립 | 과학기술정책연구원 부연구위원
모미령 | 과학기술정책연구원 연구원
진설아 | 과학기술정책연구원 연구원
배용호 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

기 여 자

유정민 | (현) 부경대학교 행정복지학부 교수
(전) 과학기술정책연구원 부연구위원

정책연구 2024-09

신기술 분야 정부 가이드라인의 실효성 제고 방안
: 바이오헬스 분야를 중심으로

2024년 12월 31일 인쇄
2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-973-2 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 필요성	2
제2절 연구의 목적	3
1. 연구의 목적	3
2. 연구의 범위와 방법	3

제2장 가이드라인의 법적 지위와 현황	4
----------------------------	---

제1절 가이드라인의 법적 지위	4
1. 가이드라인의 다른 이름, 행정규칙	4
2. 법령보충적 행정규칙의 등장	6
3. 행정규칙의 법적 지위에 대한 논란	7
4. 가이드라인의 법적 지위	8
제2절 주요 부처의 가이드라인 현황	10
1. 주요 부처의 가이드라인 전수조사	10
2. 식약처의 가이드라인 관리 현황	13
3. 보건복지부의 가이드라인 관리 현황	20

제3장 [사례1] 보건의료 데이터 활용 가이드라인 22

제1절 가이드라인의 개요	22
1. 필요성 및 목적	22
2. 주요 내용	22
제2절 가이드라인의 개정 이력	24
제3절 가이드라인을 둘러싼 주요 이슈	27
1. 가이드라인의 법적 구속력의 한계	27
2. 관련 법과의 부정합성	28
3. 데이터심의회위원회의 전문성과 공정성	30
4. 정보주체의 권리 보호 관련 내용 축소	31
5. 종합: 가이드라인의 실효성 부족	32
제4절 해외 가이드라인과의 비교	34
1. 미국	34
2. 일본	36
3. 영국	37
제5절 소결: 좋은 가이드라인의 조건에 대한 시사점	41

제4장 [사례2] 비대면진료 가이드라인 42

제1절 우리나라의 비대면진료 추진 과정	42
1. 코로나19 팬데믹으로 전격적 비대면진료 실시	42
2. 코로나19 엔데믹 이후 비대면진료 시범사업 추진	45
3. 비대면진료 시범사업의 성과와 한계	48
제2절 비대면진료 관련 쟁점 사항	49
1. 원격의료 시범사업 추진과정에서 나타난 주요 한계	49
2. 원격의료 도입을 위한 의료법 개정 논의의 주요 쟁점	52
제3절 국내외 주요 가이드라인 비교	58
1. 대한내과의사회 비대면진료 시범사업 가이드라인	58
2. 한국원격의료학회 비대면진료 가이드라인	60

3. WHO의 원격의료 안내서	62
4. 미국 의사협회의 원격의료 가이드라인	63
5. 일본 후생성의 온라인진료 가이드라인	65
6. IDB의 원격의료 가이드라인	68
제4절 비대면진료 시범사업 지침에 대한 시사점	70
1. 관련 법 정비: 법적 추진 근거 마련 및 법적 미비점 보완	70
2. 시범사업 지침의 내용 보완: 포괄적 범위의 지침 내용	71

제5장 [사례3] 유전자검사 가이드라인 74

제1절 DTC 유전자검사 가이드라인 연구의 필요성	74
제2절 DTC 유전자검사 가이드라인 현황	75
제3절 주요 이슈	82
1. 의료기관과 비의료기관 간 규제의 비대칭성	82
2. 생명윤리법상 DTC 유전자검사 항목에 대한 대통령령과 보건복지부장관령의 충돌	83
3. 미성년자 대상 DTC 유전자검사 가이드라인의 부재	87
제4절 가이드라인 개선방향	89
1. 규제의 일관성과 통합성 확보	89
2. 윤리적 고려와 미성년자 등 소비자 보호의 강화	90

제6장 [사례4] 디지털 치료기기 가이드라인 92

제1절 사례의 개요	92
1. 디지털 치료기기의 정의 및 분류 기준	92
2. 디지털 치료기기 관련 정책 추진 현황	94
3. 디지털 치료기기 관련 주요 가이드라인	95
제2절 주요 가이드라인	97
1. 디지털치료기기 허가·심사 가이드라인	97
2. 디지털 치료기기의 건강보험 등재 가이드라인	98

제3절 디지털 치료기기 가이드라인의 성과와 한계	100
1. 주요 성과	100
2. 한계	100
제4절 소결: 이슈와 시사점	102
1. 가이드라인의 법적 구속력 이슈	102
2. 가이드라인의 중복 규제와 복잡성 증가	102
제7장 가이드라인의 적절한 활용 방안	104
제1절 전문가 서면 자문 결과	104
1. 전문가 서면 자문 개요	104
2. 가이드라인의 법적 지위에 대한 전문가 의견	106
3. 가이드라인의 실효성 제고 방안	110
4. 가이드라인의 관리 방안	110
제2절 가이드라인의 적절한 활용을 위한 제언	111
1. 가이드라인에 대한 기대와 법적 현실	111
2. 좋은 가이드라인의 조건	113
3. 가이드라인의 적절한 활용을 위한 제언	115
참고문헌	117

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Need for the Study	1
2. Purpose of the Study	3
Chapter 2. Legal Status and Current Status of the Guidelines	4
1. Legal Status of the Guidelines	4
2. Current Status of Guidelines in Major Ministries	10
Chapter 3. [Case 1] Healthcare Data Utilization Guidelines	22
1. Overview of the Guidelines	22
2. Revision History of the Guidelines	24
3. Major issues surrounding the guidelines	27
4. Comparison with Overseas Guidelines	34
5. Conclusion: Implications for what makes a good guideline	41
Chapter 4. [Case 2] Guidelines for Non-Face-to-Face Care	42
1. Process of promoting non-face-to-face medical treatment in Korea	42
2. Issues related to non-face-to-face medical treatment	49
3. Comparison of major domestic and international guidelines	58
4. Implications for guidelines for on-line medical treatment pilot projects	70
Chapter 5. [Case 3] Genetic Testing Guidelines	74
1. Need for research on DTC genetic test guidelines	74
2. Current Status of DTC Genetic Testing Guidelines	75

3. Major Issues	82
4. Directions for improving guidelines	89
Chapter 6. [Case 4] Digital Therapeutic Device Guidelines	92
1. Overview of the Case	92
2 Key Guidelines	97
3 Achievements and Limitations of Digital Therapeutic Device Guidelines	100
4 Conclusion: Issues and Implications	102
Chapter 7. Appropriate Use of Guidelines	104
1. Results of the written expert consultation	104
2. Suggestions for Appropriate Use of Guidelines	111
References	117

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 법규명령과 행정규칙의 차이	5
〈표 2-2〉 행정규칙의 유형별 분포	7
〈표 2-3〉 3개 부처의 법령 현황	10
〈표 2-4〉 3개 부처의 행정규칙과 가이드라인 현황	11
〈표 2-5〉 식약처 홈페이지의 “법령정보” 게시판 하위 구조	14
〈표 2-6〉 임상시험 허가 신청서 작성에 관한 가이드라인	16
〈표 2-7〉 식약처 가이드라인의 분야별 분포	18
〈표 2-8〉 보건복지부의 가이드라인 현황	20
〈표 2-9〉 복지부와 식약처의 가이드라인 관리 비교	21
〈표 3-1〉 보건의료 데이터 활용 가이드라인 주요 개정 내용	26
〈표 3-2〉 보건의료 데이터 활용 관련 주요 국가의 법제도 현황	40
〈표 4-1〉 한시적 비대면진료 허용방안	43
〈표 4-2〉 비대면진료 시범사업 추진방안의 주요 내용	46
〈표 4-3〉 원격의료 시범사업 주요 추진 과정	50
〈표 4-4〉 의료법 개정 주요 추진 과정	52
〈표 4-5〉 정부 의료법 개정안의 주요 내용: 2014년의 개정안을 중심으로	54
〈표 4-6〉 의료법 개정 의원 발의안의 주요 내용 검토: 21대 국회	56
〈표 4-7〉 대한내과의사회 비대면진료 시범사업 가이드라인	59
〈표 4-8〉 한국원격의료학회 비대면진료 가이드라인	61
〈표 4-9〉 WHO 원격의료 안내서가 제시하는 원격의료 실행 단계별 고려 사항	63
〈표 4-10〉 AMA의 원격의료 실행을 위한 권고안	64
〈표 4-11〉 후생노동성의 온라인진료 지침	66
〈표 4-12〉 IDB가 제시하는 원격의료 규정이 담아야 할 주요 내용	69
〈표 4-13〉 비대면진료 시범사업 지침의 주요 포괄 내용 비교	72

〈표 5-1〉 생명윤리 및 안전에 관한 법률 제50조	76
〈표 5-2〉 생명윤리법 중 DTC 유전자검사 가이드라인 관련 조항	76
〈표 5-3〉 DTC 유전자검사 가이드라인(일반 소비자용)	78
〈표 5-4〉 DTC 유전자검사 서비스를 위한 가이드라인(유전자검사기관용)	80
〈표 5-5〉 DTC 유전자검사 서비스를 위한 항목 신청 가이드라인 (유전자검사기관용)	81
〈표 5-6〉 국내 의료기관의 유전자검사 규제 현황	82
〈표 5-7〉 생명윤리법 제50조(유전자검사의 제한 등)	84
〈표 5-8〉 국내 DTC 유전자검사 허용 항목의 확대 추이	85
〈표 5-9〉 대통령령 금지 항목(2017.2.28.)과 보건복지부장관령 허용 항목 비교	86
〈표 6-1〉 디지털 치료기기 가이드라인 발간 현황	95
〈표 6-2〉 디지털 치료기기 관련 기타 가이드라인	96
〈표 6-3〉 국내 주요 디지털 치료기기 개발사 및 제품	98
〈표 7-1〉 가이드라인에 대한 전문가 서면 자문 응답자	104
〈표 7-2〉 가이드라인에 대한 전문가 서면 자문 질의서	105
〈표 7-3〉 가이드라인의 법적 지위에 대한 전문가들의 답변 요약	106
〈표 7-4〉 국민의 준수 여부는 가이드라인의 법적 지위와 무관	108
〈표 7-5〉 가이드라인에 대한 기대와 법적 현실	112
〈표 7-6〉 좋은 가이드라인의 조건 매트릭스	114

| 그 립 목 차 |

[그림 2-1] 일반적인 법률의 위임 관계	4
[그림 2-2] 법령보충적 행정규칙의 위임 관계	6
[그림 2-3] 행정규칙의 법적 지위에 관한 쟁점	8
[그림 2-4] 가이드라인의 법적 지위	9
[그림 2-5] 가이드라인의 법적 위치	14
[그림 2-6] 임상시험 계획의 승인에 관한 법률 - 행정규칙 - 가이드라인 사례 ...	16
[그림 2-7] 식약처 가이드라인의 제/개정 점검표와 제/개정 이력	19
[그림 3-1] 보건의료 데이터 가이드라인에서 제시하는 개인정보 가명처리 단계 ...	23
[그림 3-2] 의료 데이터 수집 및 획득 시 장애요인	33
[그림 4-1] 비대면진료와 원격의료의 개념 비교	45
[그림 6-1] 디지털 치료기기 대상 여부 판단 기준 및 절차	92
[그림 6-2] 디지털 치료기기 건강보험 등재절차	99

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 필요성

- 신기술의 산업화를 위해서는 시장을 규율하기 위한 제도가 먼저 필요하지만 기술 변화가 가속화되면서 국회의 입법 절차만으로는 대응하기 어려운 상황이 늘어남
- 신기술 발전에 대응하고 기업들에게 신사업 규제의 불확실성을 제거해주기 위해 ‘가이드라인’ 형태의 규칙 제정이 확대되고 있음
 - 가이드라인은 ① 신기술 발전 속도에 신속하게 대처할 수 있고, ② 지속적인 수정 보완을 통해 신기술 경로의 불확실성에 유연하게 대처할 수 있음
- 가이드라인이 많아지면서 법적 구속력을 비롯한 여러 문제들이 나타나고 있으나 가이드라인을 다룬 정책연구는 아직 전무함

□ 연구의 목적

- 주요 부처를 중심으로 바이오헬스 분야의 가이드라인 활용 현황을 분석해서 가이드라인이 지닌 장점과 가능성, 문제와 한계를 진단하고 가이드라인이 신기술의 규제와 진흥을 위한 적절한 수단이 되기 위한 개선 방안 모색

□ 연구의 범위와 방법

- 범위: 식약처, 복지부, 과기부의 바이오헬스 분야 가이드라인을 연구 범위로 설정하고, 문서의 제목이 ‘가이드라인’으로 된 문서가 연구 대상
- 방법: 3개 부처의 가이드라인 전수 조사, 바이오헬스 분야의 대표적인 신기술 관련 가이드라인 4가지 사례 분석, 법률 전문가 대상 서면 자문

2. 가이드라인의 법적 지위

- 가이드라인은 엄밀하게 규정된 법적, 행정적 용어가 아니며, 각 부처들은 가이드라인을 다음 세 가지 중 하나의 의미로 사용
 - ① 고시/훈령/예규 등 기존 행정규칙 중 일부가 ‘가이드라인’의 제목을 가진 경우
 - ② 법령과 행정규칙의 내용을 쉽게 풀어 쓴 법령해설서(공무원지침서와 민원인안내서)를 ‘가이드라인’이라는 이름으로 관리
 - ③ 행정규칙이 아닌 일반 문서로 취급되는 경우
- 가이드라인의 법적 지위는 행정규칙과 일반 문서가 혼재된 상태
 - 법제처의 법령정보센터 내 행정규칙 게시판에 있는 고시, 훈령, 예규 중 문서 제목에 가이드라인이 들어간 경우는 행정규칙으로 볼 수 있고, 나머지는 법령해설서 등을 포함한 일반 문서

[그림 1] 가이드라인의 법적 지위



자료: 연구진 작성

3. 가이드라인 현황

□ 3개 부처 전수조사 결과

- 국가법령정보센터와 3개 부처의 홈페이지에서 행정규칙과 가이드라인을 조사.
 - 과기부는 행정규칙 중 2건의 문서만 가이드라인으로 확인됨
 - 복지부는 법령정보(행정규칙) 게시판에서 12건, 보도자료에서 24건, 공지사항에서 25건의 가이드라인이 각각 확인되며 중복을 제거하면 모두 23건 확인됨
 - 식약처는 “자료실” - “안내서/지침” 게시판에 980건의 가이드라인이 올라와 있음. 공무원 지침서 게시판에 13건, 민원인 안내서 게시판에 967건.

<표 1> 3개 부처의 행정규칙과 가이드라인 현황

출처	구분	식약처		복지부		과기부	
		전체	위임/집행	전체	위임/집행	전체	위임/집행
법령정보센터	고시	245	239	335	330	432	377
	훈령	165	19	96	36	384	102
	예규	68	34	493	36	73	13
	지침			3	1	7	1
	기타			5	3	94	11
	소계	478	292	932	406	990	504
부처 홈페이지 “법령정보”	고시	1,009		5,529		1,127	
	훈령	181		346		439	
	예규	159		254		38	
	지침			468			
	기타			3			
	소계	1,349		6,660 (가이드라인 12)		1,662 (가이드라인 2)	
홈페이지 기타 영역	공무원 지침서	399 (가이드라인 13)		보도자료에 가이드라인 24건			
	민원인 안내서	1,481 (가이드라인 967)		공지사항에 가이드라인 25건			

자료: 법령정보센터 및 각 부처 홈페이지 검색 결과, 2024년 6월 기준

□ 식약처의 가이드라인 현황

- 식약처가 제공한 2023.12.31. 기준 가이드라인 전체 목록 총 779개를 제품과 평가요소별로 분류한 뒤, 평가요소들은 다시 묶어서 가치사슬 단계로 분류함
 - 제품 분야와 가치사슬을 함께 고려한 경우, 의료기기의 허가 단계가 248건으로 가장 많았고, 그 다음 의약품 임상 단계가 81개

〈표 2〉 식약처 가이드라인의 분야별 분포

분야	연구	비임상	임상	종합평가	허가	제조	판매	합계	그룹
의약품	12	29	81	5	17	13	16	173	의약 276
바이오의약품	16	9	6	25	5	6	12	79	
마약		3		1			2	6	
한약	4	1	3		2		1	11	
의약외품			2	2	2		1	7	
의료기기	20	13	44	14	248	13	16	368	기기 392
체외진단			9	2	13			24	
건강기능성식품	1	2	33			1	2	39	식품 63
식품		11			2	2	6	21	
음식점							3	3	
화장품	6	30	7		1		4	48	48
총합계	59	98	185	49	290	35	63	779	779

주: 식약처가 제공한 2023.12.31. 기준 가이드라인 목록을 평가요소 기준으로 분류한 후 이를 단계별로 묶음. 각 단계에 해당하는 평가요소나 주제는 다음과 같다.

- 연구=규격, 명명법, 시험평가법, 연구, 용어, 품질
- 비임상=비임상시험, 안전성, 위해성
- 임상=검사, 기능성, 동등성시험, 성능평가, 유효성, 임상시험, 효력시험
- 종합평가=임상&비임상, 평가
- 허가=기술문서, 허가심사
- 제조=제조, GMP
- 판매=수출입, 용기포장, 용량, 위생, 재고관리, 판매후관리, 표시광고

□ 보건복지부의 가이드라인 현황

- 보건복지부 홈페이지 검색 결과 법령정보(행정규칙) 게시판에서 12건, 보도자료에서 24건, 공지사항에서 25건의 가이드라인을 확인
- 모두 합하면 61건이지만, 3개의 게시판에 중복 게시되거나 업데이트 버전이 함께 남아 있는 등 중복 문서가 많아서 중복을 제거하면 모두 23건

<표 3> 보건복지부의 가이드라인 현황

번호	게시된 곳	가이드라인 명
1	고시	요양병원 시설기준 세부가이드라인
2	고시, 보도자료	의료기관 개인정보보호 가이드라인
3	지침	DTC 유전자검사 가이드라인(일반 소비자용)
4	지침	비의료 건강관리서비스 가이드라인 및 사례집
5	지침	신종 코로나바이러스감염증 유행대비 집단시설·다중이용시설 대응지침
6	지침	어린이집 영상정보처리기기(CCTV) 설치 운영 가이드라인
7	지침, 공고	진료정보 교류를 위한 전자의무기록시스템 연계 가이드라인
8	지침, 공고, 보도자료	제대혈은행 표준업무 홍보 약관 가이드라인
9	공고, 보도자료	간호인력 야간근무 가이드라인
10	공고, 보도자료	보건의료데이터 활용 가이드라인
11	공고, 보도자료	응급구조사 현장 및 이송업무, 응급환자중증도에 따른 병원간 이송 가이드라인
12	공고	사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인
13	공고	유전체검사관련 가이드라인
14	공고	자살예방을 위한 언론보도 가이드라인
15	공고	한시적 비대면 진료 중개 플랫폼 가이드라인
16	보도자료	노인장기요양기관 건강관리가이드라인
17	보도자료	불필요한 방사선 검사 줄이기 위한 영상진단 가이드라인
18	보도자료	수혈가이드라인
19	보도자료	심폐소생술 가이드라인
20	보도자료	우리나라 간세포암종 진료 가이드라인
21	보도자료	첨단재생의료 임상연구 가이드라인
22	보도자료	트라우마 예방을 위한 재난보도 가이드라인
23	보도자료	흡연 예방 미디어 가이드라인

자료: 보건복지부 홈페이지에서 검색 후 연구진 정리

□ 식약처와 보건복지부의 가이드라인 관리 현황

- 가이드라인을 많이 활용하는 식약처는 체계적으로 관리하고 있으나, 가이드라인이 많지 않은 복지부는 가이드라인에 대한 별다른 관리 체계가 없음

〈표 4〉 복지부와 식약처의 가이드라인 관리 비교

비교 항목	식약처	복지부
문서 형태	공무원지침서, 민원안내서	고시, 지침, 공고, 보도자료
홈페이지 게시 방법	법령정보 코너	법령정보와 공지사항 코너
법적 효력	가이드라인의 법적 효력이 없음을 명시	고시나 지침은 법적 효력이 있음
관리체계	• 자체 등록번호 부여, • 가이드라인의 제정/개정/폐기 이력 공개 • 가이드라인 제정/개정/폐기의 자체 기준과 절차 보유 • 가이드라인 제/개정 점검표	별도의 관리 체계 없음
가이드라인의 법적 위치	법령과 행정규칙에 대한 해설서	언급 없음

자료: 연구진 작성

4. 가이드라인에 대한 전문가 서면 자문 결과

- 가이드라인의 법적 지위에 대한 정확한 이해를 얻고자 법률 전문가들(주로 행정법을 전공한 교수들과 연구기관 소속의 연구자들)에게 자문을 의뢰
 - 정확한 의견 개진과 신속한 의견 수렴을 위해 서면 자문 방식을 사용 15명의 법률 전문가들에게 e-mail로 서면 질의서를 보내서 13명으로부터 회신

□ 가이드라인의 법적 지위에 대한 전문가 의견

- 가이드라인은 법령보충적 행정규칙이 아니다.
 - 행정규칙이 법령보충적 행정규칙이 되기 위해서는 ① 상위법령의 위임이 있어야 하고, ② 상위법령의 내용을 보충·구체화하는 것이어야 하며, ③ 상위법령의

위임의 범위를 벗어나지 않아야 하고, ④ 상위법령도 구체적으로 범위를 정하여 위임하는 등 위임입법의 한계를 지켜야 함

- 법령이 가이드라인에 그 보충권한을 위임한 경우는 사실상 없기 때문에 ①번 조건부터 충족하기가 어려워서, 가이드라인은 법령보충적 행정규칙이 아님

○ 가이드라인은 행정규칙도 아니다.

- 행정규칙은 행정조직 내부의 관계를 규율하는 일반·추상적 규범으로 정의되며, 상급행정기관이 하급행정기관에 대하여 사무처리기준과 절차를 정하는 것이므로 행정규칙의 수범자는 행정기관
- 이에 비해 가이드라인은 기본적으로 행정기관 내부가 대상이 아니고 일반 국민들을 대상으로 하며, 대부분 특정한 사안에 대한 행정청의 입장을 설명하거나 행정 행위와 관련된 정보를 제공함으로써 국민들의 행위를 일정한 방향으로 유도하고자 하는 지도, 권고, 조언을 그 내용으로 함
- 따라서 가이드라인은 행정절차법 제2조 제3호에 나오는 행정지도로 보거나, 법령이나 정책에 대한 해설서나 안내서로 보는 것이 타당

○ 가이드라인은 행정규칙이 아니어야 한다.

- 가이드라인과 행정규칙을 개념적, 기능적으로 명확히 분리하는 것이 기존 법체계의 단계적 질서를 유지하고 국민의 혼란을 최소화할 수 있음
- 가이드라인의 기능은 현행 법률, 법규명령, 행정규칙 등 법규정들을 국민들의 해석과 적용이 용이하도록 평이한 내용으로 설명하고 안내하는 기능에 국한하는 것이 적절하고, 가이드라인 자체를 법제도상 또는 법체계상 또다른 하나의 입법형태나 형식으로 만드는 것은 불필요
- 기술 변화로 인해 보다 “탄력적인 입법방식”이 필요하다면 현행 법령보충적 행정규칙의 입법 방식을 통해서도 해결할 수 있을 것

□ 가이드라인의 실효성 제고 방안

- 가이드라인의 실효성을 제고하기 위해 법적 구속력을 추가하는 방안, 즉 가이드라인을 위반하는 경우에 대한 제재 조항을 추가하는 것은 불가능
 - 법 위반에 대한 법적 제재 조치는 죄형법정주의에 따라 오직 법률로만 정할 수 있고, 만일 가이드라인에 제재 조항을 넣는다면 그 자체로 위헌이 될 수 밖에 없으며, 행정부가 자의로 제재 조항을 넣는 것은 오랜 시간을 거쳐 형성된 민주적 삼권분립의 원칙을 훼손하는 중대한 의미도 있다는 것이 전문가들의 의견
- 더 나아가 가이드라인의 법적 구속력이 없다는 점이 그 본질적인 특성이므로 장점
 - 가이드라인은 법령의 내용을 국민이 알기 쉽게 설명하거나 그 법령을 준수하는 방법을 안내해주는 역할을 하는데, 여러 대안(방법, 해설) 중 하나에 불과하고, 국민은 여러 다양한 방법 중 하나를 택해서 법령을 준수할 수 있어야 하므로 특정 가이드라인의 준수 여부에 대해 제재 조항을 넣어서는 안 됨
 - 또한 기술 발전에 따라 어제의 가이드라인으로 권고한 사항을 내일 바꿔야 할 수도 있음. 가이드라인이 제재 조항을 가지지 않고 법적인 구속력이 없는 것은 가이드라인의 약점이 아니고 강점이자 본질에 해당

□ 가이드라인의 관리 방안

- ① 해당 분야의 전문가의 참여를 통해 해당 분야의 행정목적 달성의 측면에서 '합리성·타당성'을 확보하기 위해 노력
- ② 법률전문가 자문 등을 통해 법적인 측면에서 '합헌성·합법성'을 확인
- ③ 급변하는 상황변화에 대처해야 하므로 '현재의 정확성'이 담보되어야 함. 기술 진보 및 사실관계의 변화 등을 즉시 반영 반영할 수 있도록 온라인 형태로 수시 업그레이드되어 제공될 필요성이 있고, 어떤 형태이든 반드시 '기준 시점' 및 '추후 변경될 수 있다'는 주의 문구 등이 필요

5. 가이드라인의 적절한 활용을 위한 제언

□ 가이드라인에 대한 기대와 법적 현실

- 가이드라인의 제공자와 수요자들이 기대하는 가이드라인의 용도와 지향점은 아래 표와 같이 크게 4가지로 정리될 수 있음
- 법률 전문가들의 판단에 따르면 위 표의 첫 두 가지 지향점은 바람직하고 달성 가능하지만, 나머지 두 가지 지향점은 심각한 문제가 될 수 있음

〈표 5〉 가이드라인에 대한 기대와 법적 현실

가이드라인 제공자와 수요자들이 기대하는 가이드라인의 용도와 지향점	법률 전문가들의 판단
• 구체성: 법령의 내용과 준수 방법 등을 알기 쉽게 구체적으로 설명	• (Good) 가이드라인이 행정지도나 법령 해설서의 역할을 하는 경우로 가이드라인의 바람직한 활용 사례
• 일관성과 정합성: 상위 법령의 내용과 취지를 고수하고, 타 법률과도 충돌하지 않아야 함	• (Good) 가이드라인이 기본적으로 갖추어야 하는 요건
• 선도성: 법령이 제정되지 못한 영역에서 사업 활동 등 국민의 행위를 규율	• (Bad) 비록 한시적이라도 입법부의 법률 제정 권한을 침해할 수 있고, 가이드라인 미준수 행위를 제재할 수도 없음
• 실효성: 국민들이 일정한 방향으로 행동하도록 안내하고, 다른 방향의 행위를 막아 줌	• (Bad) 상위 법령에 제재 조항이 있고 가이드라인이 그것을 구체적으로 설명한 것에 불과하다면 문제가 없지만, 가이드라인만으로 미준수 행위를 제재하려고 한다면 문제

자료: 연구진 작성

□ 좋은 가이드라인의 조건 매트릭스

- 첫째, 가이드라인과 행위자들의 이해관계 정렬: 해당 가이드라인을 준수하지 않는 것이 행위자에게 득이 되는 상황이 없는 것
- 둘째, 상위 법령을 통한 제재와 규율이 가능한 경우: 가이드라인의 방향과 행위자들의 이해관계의 방향이 다른 경우, 가이드라인의 상위 법령이 있고 그 법령에 제재 조항이 있다면 그 가이드라인을 위반하는 주체를 제재할 수 있음.
- 위의 두 가지 조건을 조합하면 4가지 경우의 수가 생기는데, 이 중에서 ①~③번은 가이드라인이 잘 작동할 수 있지만, ④번은 작동하기 어려움

<표 6> 좋은 가이드라인의 조건 매트릭스

가이드라인의 방향 = 행위자들의 이해관계	① 가이드라인과 행위자들의 이해관계가 일치하면서 상위 법령을 통한 제재도 가능	② 가이드라인과 행위자들의 이해관계가 일치하지만 상위 법령을 통한 제재는 어려운 경우
가이드라인의 방향 ≠ 행위자들의 이해관계	③ 가이드라인과 행위자들의 이해관계는 다르지만, 상위 법령을 통한 제재는 가능한 경우	④ 가이드라인과 행위자들의 이해관계도 다르고, 상위 법령을 통한 제재도 어려운 경우
	상위 법령을 통한 제재 가능	상위 법령을 통한 제재 어려움

자료: 연구진 작성

- 그런데 ④번 상황은 신기술 분야에서 시장을 규율하는 제도들이 확립되기 전에 제품 시장이 먼저 열릴 때 자주 발생함. 아직 관련 제도가 생기기 전이어서 상위 법령이 없고, 가이드라인이 한시적으로 법령의 역할을 담당하는 경우
 - 법률 전문가들의 판단을 따르면 ④번은 가이드라인을 부적절하게 활용하는 것

□ 가이드라인의 적절한 활용을 위한 제언

- 첫째, 가이드라인은 행정규칙이 아니고 법적 구속력이 없는 행정지도나 법령 해설서로 보는 것이 타당하므로, 가이드라인의 역할에 대한 기대치를 낮추고, 가이드라인이 작동할 수 있는 환경에서만 활용하는 것이 필요
 - ① 가이드라인과 행위자들의 이해관계가 일치해서 가이드라인의 준수를 기대할 수 있는 경우이거나 ② 상위 법령을 통해 가이드라인을 지키지 않는 행위자를 제재할 수 있는 경우에 한해 가이드라인을 활용하는 것이 적절
- 둘째, 이렇게 가이드라인의 용도를 좁힐 경우, 신기술 분야의 연구개발과 제품 판매를 규율할 법령이 제정되지 않은 상태에서 한시적으로 가이드라인을 활용하는 관행은 지양되어야 함
 - 대신 국회에 <신기술 산업의 육성을 위한 입법 지원기구>를 설치하고 신기술 관련 입법을 신속하게 진행할 필요가 있음

Summary

Measures to improve the effectiveness of government guidelines in the field of new technologies

- **Project Leader: Seok-Kwan Kim**
- **Participants: Jonglip Kim · Seol-A Jin · Meeryung Mo · Youngho Bae**

☐ Background and necessity of the research

In order to commercialize new technologies, a system to regulate the market is first needed, but as technological change accelerates, there are more and more situations where it is difficult to respond to them through the legislative process of the National Assembly alone. The establishment of rules in the form of 'guidelines' is expanding to respond to the development of new technologies and to remove the uncertainty of new business regulations for companies. The guidelines can (1) quickly respond to the pace of new technology development and (2) flexibly respond to the uncertainty of new technology pathways through continuous modification and supplementation. As the number of guidelines increases, various issues, including legal binding power, are emerging, but there is no policy research on guidelines yet.

☐ Purpose of the study

The study analyzes the current status of the use of guidelines in the biohealth sector, focusing on major ministries, to diagnose the advantages, possibilities, problems, and limitations of the guidelines, and to seek ways to improve the guidelines to make them an appropriate means for regulating and promoting new technologies.

☐ Expert opinions on the legal status of the guidelines

- ☐ The guidelines are not administrative rules that supplement laws and regulations.

For an administrative rule to become a supplementary administrative rule, it must be ① delegated by a higher-level law, ② supplement or specify the content of the higher-level law, ③ not exceed the scope of the delegation of the higher-level law, and ④ the higher-level law must also specify the scope of the delegation, and the delegation must comply with the limits of delegated legislation. Since there is virtually no case in which a law delegates its supplementary authority to the guidelines, it is difficult to meet the conditions of ①, and the guidelines are not administrative rules that supplement laws.

- ☐ The guidelines are not administrative rules.

Administrative rules are defined as general and abstract norms that govern the relationships within administrative organizations, and since the superior administrative agency sets the standards and procedures for the subordinate administrative agency, the administrative agency is the subject of administrative rules. In comparison, guidelines are not intended for internal use within administrative agencies, but are intended for the general public, and most of them are intended to guide the public in a certain direction by explaining the position of the administrative agency on a specific issue or providing information related to administrative acts. They are usually composed of instructions, recommendations, and advice. Therefore, the Guidelines should be viewed as administrative guidance under Article 2(3) of the Administrative Procedure Act, or as a commentary or guide to laws or policies.

- ☐ Guidelines should not be administrative rules.

A clear conceptual and functional separation of guidelines and administrative rules will maintain the existing legal system's step-by-step order and minimize confusion among the public. It is appropriate to limit the function of the guidelines to explaining and guiding the current laws, legal regulations, administrative rules,

etc. in plain language so that the people can interpret and apply them easily, and it is unnecessary to make the guidelines themselves into another legislative form or format in the legal system or legal system. If technological changes require a more “flexible legislative approach,” it can be addressed through the current legislative approach of supplementary administrative rules.

☐ Expert opinions on Measures to enhance the effectiveness of the guidelines

It is not possible to add a provision on sanctions for violations of the guidelines, i.e. to add legal binding power to enhance the effectiveness of the guidelines. Legal sanctions for violations of the law can only be determined by law in accordance with the principle of legality, and if the guidelines include sanctions, it will be unconstitutional. The administration's arbitrary inclusion of sanctions also has the serious implication of undermining the principle of democratic separation of powers, which has been formed over a long period of time.

Furthermore, the fact that the guidelines are not legally binding is their essential characteristic and advantage. Guidelines are intended to explain the content of laws in a way that is easy for the public to understand or to provide guidance on how to comply with the laws. They are just one of many alternatives (methods, explanations), and the public should be able to choose one of many different methods to comply with the laws. Therefore, there should be no sanctions for compliance with specific guidelines. In addition, as technology advances, the recommendations made in yesterday's guidelines may need to be changed tomorrow. The fact that the guidelines do not have a sanction clause and are not legally binding is not a weakness of the guidelines, but rather a strength and an essential part of their nature.

☐ Expert opinions on Management of the Guidelines

- ① Efforts are made to ensure 'reasonableness and validity' in terms of achieving administrative purposes in the relevant field through the participation of experts in the relevant field.

- ② Check the constitutionality and legality from a legal perspective through consultation with legal experts.
- ③ 'Current accuracy' must be guaranteed as we need to deal with rapidly changing situations. There is a need to provide online upgrades from time to time so that technological advancements and changes in facts can be reflected immediately, and any form must include a note stating that the information is the “reference point” and “subject to change in the future.”

□ Expectations for the Guidelines and Legal Reality

The uses and goals of the Guidelines as expected by the providers and consumers of the Guidelines can be summarized into four major categories as shown in the table below. According to the legal experts' judgment, the first two goals in the table above are desirable and achievable, but the remaining two goals may be serious problems.

<Table 1> Expectations for Guidelines and Legal Reality

Expectations of guideline providers and users on purpose and goals of guidelines	Judgment of legal experts
• Specificity: Easy-to-understand and specific explanation of the content of laws and how to comply with them, etc.	• (Good) Examples of desirable use of guidelines in cases where guidelines serve as administrative guidance or a commentary on laws and regulations
• Consistency and coherence: Adhere to the content and intent of the higher-level laws and regulations and not conflict with other laws.	• (Good) Requirements that guidelines should basically meet.
• Leading: Regulate the conduct of people, such as business activities, in areas where laws have not been enacted.	• (Bad) (Bad) Even if it is temporary, it may infringe on the legislative authority of the legislature and may not sanction non-compliance with the guidelines.
• Effectiveness: Guide the public to act in a certain direction and prevent them from acting in a different direction.	• (Bad) If there is a sanction clause in the higher-level law and the guidelines merely explain it in detail, there is no problem, but if the guidelines alone are used to sanction non-compliance, there is a problem.

☐ Conditions for good guidelines matrix

First, align the interests of the guidelines and the actors: There is no situation in which non-compliance with the guidelines is beneficial to the actor. Second, if sanctions and regulations are possible through higher-level laws: If the direction of the guidelines and the interests of the actors are different, and there is a higher-level law for the guidelines and there are sanctions in that law, the entity that violates the guidelines can be sanctioned. Combining these two conditions results in four cases, of which cases ① to ③ can be handled well by the guidelines, but case ④ is difficult to handle.

<Table 2> Conditions for good guidelines Matrix

Direction of guidelines = Interests of actors	① Guidelines and interests of actors are aligned, and sanctions through higher laws are possible.	② Guidelines and interests of actors are aligned, but sanctions through higher laws are difficult.
Direction of guidelines ≠ Interests of actors	③ Guidelines and interests of actors are different, but sanctions through higher laws are possible.	④ Guidelines and interests of actors are different, and sanctions through higher laws are difficult.
	Sanctions through higher laws possible	Sanctions through higher laws difficult

However, situation ④ often occurs when the product market opens before the establishment of the systems that govern the market in the field of new technologies. This is the case when there is no higher-level law because the relevant system has not yet been established, and the guidelines serve as a temporary substitute for the law. According to the legal experts' judgment, ④ is an inappropriate use of the guidelines.

☐ Suggestions for the proper use of the guidelines

First, since the guidelines are not administrative rules and are more appropriately viewed as administrative guidance or a commentary on laws and regulations that are not legally binding, it is necessary to lower expectations for

the role of the guidelines and use them only in an environment where they can function. It is appropriate to use the guidelines only when (1) the interests of the guidelines and the actors are aligned so that compliance with the guidelines can be expected, or (2) the guidelines can be used to sanction actors who do not comply with the guidelines through higher-level laws. Second, if the guidelines are to be used in this way, the practice of using the guidelines for a limited period of time should be avoided, as no laws have been enacted to regulate research and development and product sales in the field of new technologies. Instead, it is necessary to establish a legislative support organization for the development of new technology industries in the National Assembly and to promptly proceed with legislation related to new technologies.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 연구의 배경

신기술은 새로운 사업 기회를 창출하고 새로운 산업을 형성함으로써 국가 경제를 성장시키고 새로운 일자리를 공급하는 역할을 한다. 그런데 새로운 시장과 산업이 형성되기 위해서는 시장에서 각 주체들의 행위를 규율하는 제도가 먼저 확립되어야 한다. 예를 들어 제품 허가나 시장 진입에 관한 제도가 적절히 구축되어 있지 않으면 기업들은 제도적 불확실성 때문에 신사업을 시작하기 어렵다. 국가가 새로운 제품과 서비스의 허가와 유통, 기업간 경쟁 등에 관한 규칙을 정하고 그에 따라 기업들이 안정적으로 시장에 진입할 수 있어야 비로소 신기술은 산업으로 개화하기 시작한다.

이렇게 신기술이 새로운 산업을 형성하거나 기존 산업에 중요한 영향을 미치는 시기에는 기업만큼이나 국가도 기민하게 움직여야 한다. 너무 느슨하거나 너무 강하지 않은 규제를 너무 빠르거나 너무 늦지 않게 적기에 확립해주어야 한다. 기업에게는 강한 규제보다 규제의 공백 상태가 더 큰 위협이 될 수 있다. 우리나라는 기업이 ‘할 수 있는 것’을 국가가 정해주는 포지티브 규제 시스템이어서 더더욱 국가의 역할이 중요하다.

이때 새로운 시장의 규칙을 정하는 입법 기능은 이제까지 헌법이 정한 삼권분립의 원칙에 따라 국회가 맡아서 수행해왔다. 그런데 인공지능, 바이오, 양자 등 다양한 분야에서 기술 변화가 가속화되면서 국회의 전통적인 입법 절차만으로는 신기술의 빠른 변화에 대응하기 어려운 상황이 계속 늘어나고 있다. 기술은 빠르게 변할 뿐 아니라 그 내용도 일반인이 이해하기 어려워서 국회에서 그 세세한 내용을 다 이해하고 관련 규칙을 법으로 정하기 어려운 경우가 많다. 또한 새로운 기술에 의해 새로운 산업이 형성될 때는 새로운 제품과 서비스의 표준이 정해지지 않은 유동적인 시간이 오래 지속되기도 한다. 이 경우 표준이 정해질 때까지 규정을 계속 수정하면서 유연하게 대응하는 것이 필요한데, 이 역시 국회의 입법 절차와 잘 맞지 않는다.

이러한 배경에서 각국 정부는 신기술 발전에 대응하고 기업들에게 신사업 규제의 불확실성을 제거해주기 위해 ‘가이드라인’ 형태의 규칙 제정을 확대하고 있다. 가이드라인은 ① 신기술 발전 속도에 신속하게 대처할 수 있고, ② 지속적인 수정 보완을 통해 신기술 발전 경로의 불확실성에 유연하게 대처할 수 있다는 장점이 있기 때문에 신산업과 관련된 규제에 적합한 측면이 있다.

그러나 가이드라인이 쌓이면서 가이드라인이 지닌 한계도 드러나기 시작했다. 가장 흔한 문제는 가이드라인의 법적 지위와 법적 구속력에 관한 문제이다. 가이드라인은 국민들에게 의무를 부과할 수 있는 법률이 아니기 때문에 대부분의 경우 자율적 준수의 대상이고 행위를 강제할 수는 없다. 그래서 가이드라인을 준수하지 않는 기업에게 불이익을 줄 수도 없다. 법률의 위임을 받아 가이드라인에 법적 구속력을 부여할 수도 있는데, 이 경우 가이드라인의 법적 구속력이 너무 커도 문제가 된다. 강한 법적 강제력을 입법부에서의 논의 과정 없이 행정부가 만드는 것은 적절하지 않기 때문이다. 이는 가이드라인의 내용 뿐 아니라 제정 절차도 중요하다는 점을 시사한다. 입법부가 국민의 뜻을 수렴해서 법을 제정하듯이 행정부도 최대한 민의를 수렴하는 과정이 필요하다. 그 외에 가이드라인의 남발과 관리 문제도 지적된다. 법률과 달리 행정부가 임의로 만들 수 있기 때문에 총량의 제한이 없고 제정, 개정, 폐기에 대한 규칙도 없으며, 범부처 차원의 통합 관리도 잘 되지 않고 있다.

2. 연구의 필요성

다양한 신기술의 등장과 함께 정부가 가이드라인을 규칙 제정의 수단으로 활용하는 경우가 더 많아지고 있는 반면 문제도 많이 나타나고 있다. 따라서 정부의 규제 수단으로서의 가이드라인에 대해 한번 검토해볼 시기가 되었다. 그러나 아직까지 가이드라인을 본격적으로 다룬 정책연구는 매우 드물다. 가이드라인의 다른 이름이라고 볼 수 있는 행정규칙의 법적 지위에 관한 법학 연구들은 조금 있지만, 법학 이외의 전공이나 정책연구기관에서 가이드라인 자체를 연구 주제로 삼은 경우는 거의 전무하다고 볼 수 있다.

제2절 연구의 목적

1. 연구의 목적

본 연구의 목적은 주요 부처를 중심으로 바이오헬스 분야의 가이드라인 활용 현황을 분석해서 가이드라인이 지닌 장점과 가능성, 문제와 한계를 진단하고 가이드라인이 신기술의 규제와 진흥을 위한 적절한 수단이 되기 위한 개선 방안 모색하는 것이다.

이를 위해 다음과 같은 연구질문을 다루고자 한다.

- 가이드라인의 법적 지위는 무엇인가? 행정규칙의 일종으로 보아도 무방한가?
- 행정규칙의 법적 지위와 관련해서 현재 학술적, 실무적 쟁점은 무엇인가?
- 주요 부처들은 가이드라인을 어떻게 활용하고 관리하고 있는가?
- 가이드라인의 활용과 관리 과정에서 어떤 문제가 나타나고 있는가?
- 가이드라인의 실효성을 높이는 방안은 무엇인가?

2. 연구의 범위와 방법

식약처, 복지부, 과기부의 바이오헬스 분야 가이드라인을 주요 연구 범위로 설정하고, 문서의 제목이 '가이드라인'으로 된 문서를 연구 대상으로 한다. 가이드라인을 행정규칙의 일종으로 관리하기도 하기 때문에 행정규칙에 대한 논의도 참고하고자 한다.

우선 3개 부처의 가이드라인을 전수 조사해서 부처별 특징이나 관리 상황을 알아보고, 바이오헬스 분야의 가장 대표적인 신기술 관련 가이드라인 4가지 사례를 분석해서 현재의 가이드라인들이 안고 있는 문제들과, 좋은 가이드라인의 조건이 무엇인지 찾아보려고 한다. 본 연구의 결론은 좋은 가이드라인의 조건을 제시하고 그것을 얻기 위한 정책 대안으로 구성된다.

| 제2장 | 가이드라인의 법적 지위와 현황

제1절 가이드라인의 법적 지위

1. 가이드라인의 다른 이름, 행정규칙

가이드라인은 우리나라의 법 체계 속에 있는 공식적인 용어가 아니다. 정확하게 일치하지는 않지만 가이드라인과 가장 가까운 것은 행정규칙이다. 따라서 가이드라인의 법적 지위를 파악하려면 우선 행정규칙에 대한 법률적 논의를 살펴볼 필요가 있다.

[그림 2-1] 일반적인 법률의 위임 관계

일반적인 법률의 위임 구조		헌법의 근거 조항
법령	법률(국회) ↓ 위임	헌법 제40조: 입법권은 국회에 속한다
	시행령(대통령령) ↓ 위임	헌법 제75조: 대통령은 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항과 법률을 집행하기 위하여 필요한 사항에 관하여 대통령령을 발할 수 있다
	시행규칙(총리령, 부령)	헌법 제95조: 국무총리 또는 행정각부의 장은 소관 사무에 관하여 법률이나 대통령령의 위임 또는 직권으로 총리령 또는 부령을 발할 수 있다.
행정 규칙	고시, 훈령, 예규 등	

자료: 연구진 작성

황희운(2014)은 행정규칙을 다음과 같이 정의했다. “일반적으로 행정규칙이란, 상급행정기관이 하급행정기관에 대하여 그 조직이나 업무 처리의 절차·기준 등에 관하

여 발령하는 일반적·추상적 규율을 말한다. 즉, 행정기관이 헌법상 근거를 요하지 아니하고, 그 고유권한으로써 일반국민의 권리·의무와 직접 관계가 없는 ‘비법규사항’을 규정하는 것으로, 행정조직 내부에서만 효력을 가질 뿐 대외적 구속력을 가지지 않는 규칙을 가리킨다. 이처럼 ‘비법규성’은 행정규칙 개념의 필수요소로써, ‘법규성’의 유무에 따라 법규명령과 행정규칙을 구별하는 것이 전통적 입장이다.”(황희윤, 2014; p.233)

정의에서 잘 나타나듯이 행정규칙은 원래 행정조직 내부에서의 조직 관리와 행정 활동을 규율하기 위해 만들어진 자체 규정으로, 법률 - 시행령 - 시행규칙으로 이어지는 우리나라의 법령 체계 바깥에 있었다(그림 2-1). 법학에서는 국민의 권리와 의무에 관한 사항을 규정하고 국민에 대한 법적 구속력을 가지는 법령을 “법규명령”이라고 한다. 법규명령은 국민을 대리하는 입법기관인 국회가 제정하거나 국회가 행정부에 위임해서 제정하기 때문에 민주적 정당성이 있다. 이에 비해 국민의 권리와 의무에 관한 내용 없이 오직 행정조직 내부의 업무를 위해 만들어진 행정규칙은 법규명령이 아니기 때문에 민주적 정당성은 불필요하다(표 2-1).

〈표 2-1〉 법규명령과 행정규칙의 차이

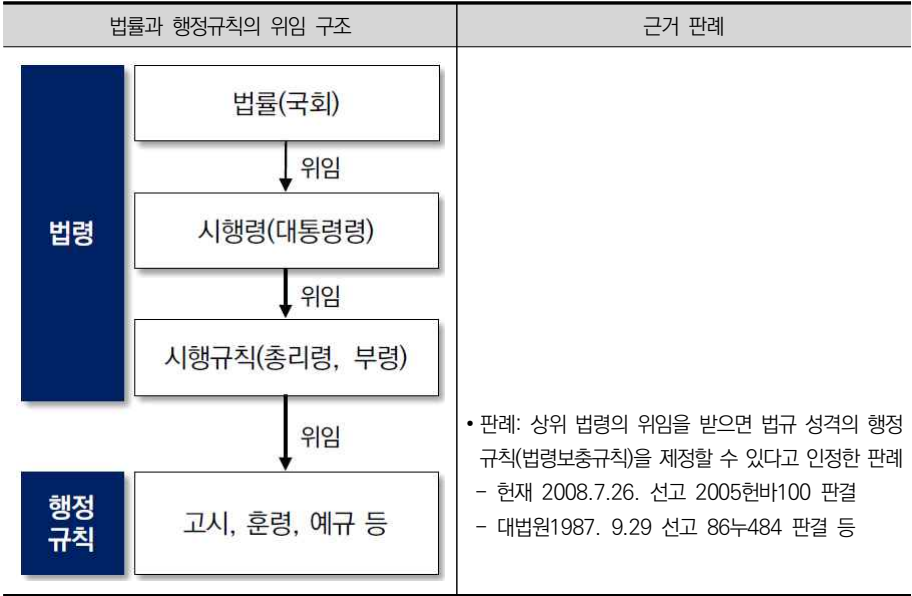
구분	법규명령	행정규칙
정의	행정기관이 헌법에 근거하여 국민의 권리·의무에 관한 사항(법규사항)을 규정하는 명령	행정조직 내부에서 그 조직과 활동을 규율하기 위해서 발하는 일반적·추상적인 명령
일반국민의 권리 /의무와 관련성	직접 관련되는 사항을 규정	직접 관계가 없는 사항을 규정
법적 구속력	대국민적 구속력을 가짐	행정조직 내부에서만 효력, 대외적 구속력은 없음
법적 구속력2	외부법	내부법
예시	대통령령, 총리령, 부령 등	고시, 훈령, 예규 등
헌법적 근거	헌법에 따라 입법권을 가진 주체가 제정	헌법에서 입법권이 부여되지 않아도 가능

자료: 황희윤(2014) 등에서 법규명령과 행정규칙의 차이를 설명한 것을 연구진이 요약함.

2. 법령보충적 행정규칙의 등장

그런데 최근에 와서 법령의 위임을 받아 법적 구속력을 갖게 된 행정규칙, 즉 “법령보충적 행정규칙”이 많이 만들어지고 있고, 정부의 행정 활동이 여기에 의존하는 비중도 커지고 있다. 원래 행정규칙은 법적 구속력이 없지만, 이들 법령보충적 행정규칙은 상위 법령(시행규칙 등)에 위임 조항을 삽입하는 방식으로 구속력을 갖게 되었다(그림 2-2). 이렇게 되면 행정규칙도 법규명령의 성격을 가지기 때문에 법규명령과 행정규칙 사이의 경계가 모호해진다. 그리고 이렇게 행정규칙 중 일부가 성격이 바뀐 것은 헌법에 근거가 있지 않고 판례에 따른 것이다. 즉, 상위 법령의 위임을 받으면 법규 성격의 행정규칙(법령보충적 행정규칙)을 제정할 수 있다고 인정한 판례가 여러 번 있었고, 그 결과 행정규칙의 용도가 확대되었다. 정리하면, 행정규칙은 원래의 취지대로 행정조직 내부만 규율하는 일반 행정규칙과 상위 법령의 위임을 받아 국민의 권리와 의무에 관한 사항을 규율하는 법령보충적 행정규칙으로 구분될 수 있다.

[그림 2-2] 법령보충적 행정규칙의 위임 관계



자료: 연구진 작성

국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/>)의 행정규칙 검색 기능에서 ‘현행행정규칙’ 메뉴에 가면 행정규칙을 위임행정규칙, 집행행정규칙, 행정내부규칙, 처분적 고시 등, 기타로 구분한 통계를 볼 수 있다. 이 중에서 처음 두 가지가 법령보충적 행정규칙에 해당한다. 2024.11.12.일 현재, 총 20,478개의 행정규칙이 있고, 그중 56.5%에 해당하는 11,558개는 법령보충적 행정규칙이 된다(표 2-2).

<표 2-2> 행정규칙의 유형별 분포

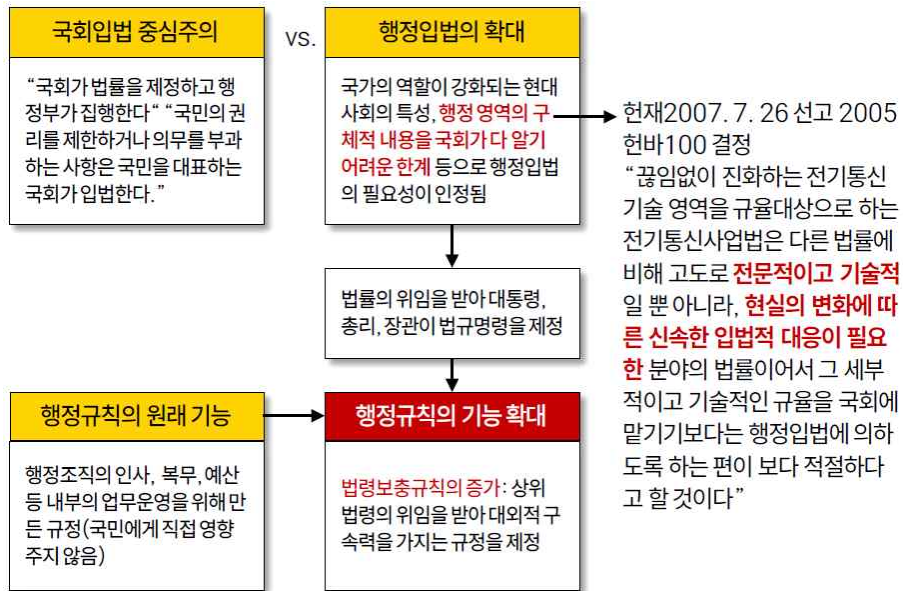
구분		등록 행정규칙
위임 행정규칙	상위 법령에서 위임한 사항을 훈령, 예규, 고시 등의 형식으로 정하고 있는 행정규칙	9,903 (48.4%)
집행 행정규칙	상위 법령의 시행에 필요한 세부사항을 훈령, 예규, 고시 등으로 정하고 있는 행정규칙	1,655 (8.1%)
행정 내부규칙	행정기관의 인사, 복무, 조직, 예산, 기록관리, 정보공개 등 행정기관의 내부적인 업무운영에 필요한 사항을 정하고 있는 행정규칙	7,604
처분적 고시 등	인허가 등 행정처분에 관한 사항, 일회적 행정 업무 처리에 관한 사항 등을 고시, 공고 등의 형식으로 정하고 있는 행정규칙	2,111
기타		15
합계		20,478

자료: 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/>)에서 행정규칙 → 현행행정규칙 항목, 2024.11.12.기준.

3. 행정규칙의 법적 지위에 대한 논란

법령보충적 행정규칙이 증가하는 현상은 전반적으로 행정입법이 확대되고 있는 추세에 일부로 이해할 수 있다. 현대 사회는 산업 경쟁력 제고, 복지 국가 건설 등 국가가 적극적으로 개입해야 하는 영역들이 많지만, 행정영역의 구체적인 내용을 국가가 다 알기 어려운 한계가 있다. 현재의 결정문에도 나오듯이, 특히 “기술 영역을 규율대상으로 하는 경우, 전문적이고 기술적인 내용도 문제이지만, 현실의 변화에 따른 신속한 입법적 대응이 필요”하다(그림 2-3). 이러한 환경 변화는 모두 행정입법 수요를 늘리고 있고, 행정입법의 구체적인 방식도 시행령과 시행규칙을 확대하는 것에서 법령보충적 행정규칙을 늘리는 것으로 옮겨가고 있다.

[그림 2-3] 행정규칙의 법적 지위에 관한 쟁점



자료: 연구진 작성

정부의 기능 확대 등 여러 요인으로 인해 법령보충적 행정규칙의 증가는 필연적일 수 있지만, 이 방식은 국회를 거치지 않은 입법 행위라서 민주적, 절차적 정당성이 상대적으로 취약하다는 문제가 남는다. 따라서 이 문제를 보완하기 위해서는 입법과정에서 이해관계자의 의견을 폭넓게 수렴하는 것이 필요하고, 전체 행정규칙에 대해 사전 심사, 사후 평가, 일몰제 도입 등 관리감독을 강화할 필요가 있다.

4. 가이드라인의 법적 지위

한국에서 가이드라인은 엄밀하게 규정된 법적, 행정적 용어가 아니다. 이번 연구에서 식약처, 복지부, 과기정통부의 홈페이지를 모두 조사해본 결과 각 부처들은 가이드라인을 다음 세 가지 중 하나의 의미로 사용하고 있다는 것이 확인되었다.

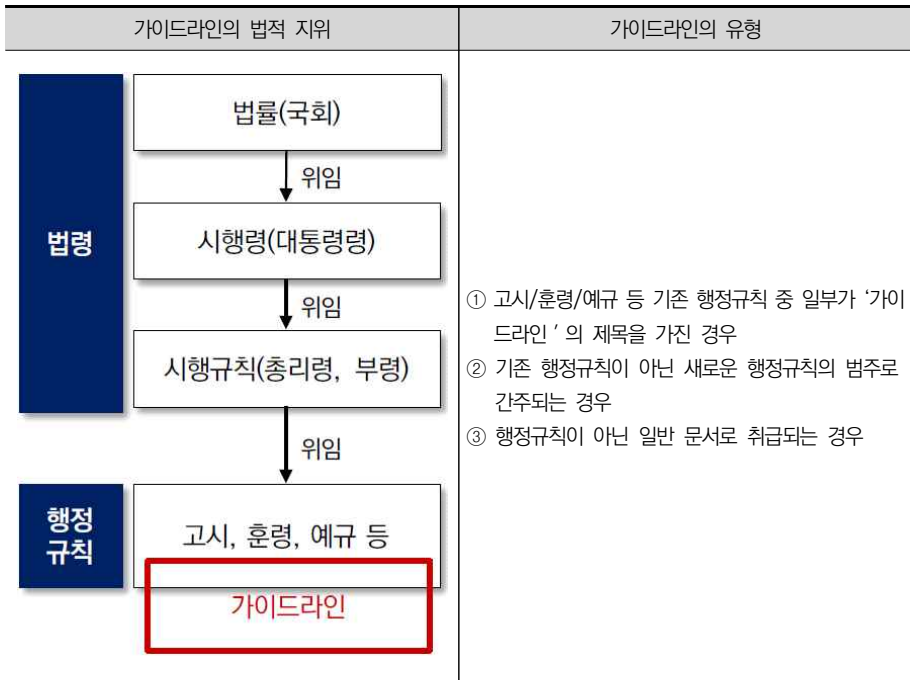
- ① 고시/훈령/예규 등 기존 행정규칙 중 일부가 ‘가이드라인’의 제목을 가진 경우

② 기존 행정규칙이 아닌 새로운 행정규칙의 범주로 간주되는 경우

③ 행정규칙이 아닌 일반 문서로 취급되는 경우

이 세 가지 경우를 하나로 묶어서 그림으로 그려보면 대략 [그림 2-4]의 붉은 색 실선 부분으로 표시할 수 있다. 즉, 가이드라인 중 일부는 행정규칙이고, 나머지는 아닌 것이다. 따라서 가이드라인의 법적 지위는 둘 중에 하나로 좁혀진다. 하나는 고시, 훈령, 예규 등과 같은 행정규칙이고, 다른 하나는 행정규칙이 아닌 임의 문서이다. 본 연구에서는 이 세 종류의 문서를 모두 다루고자 한다.

[그림 2-4] 가이드라인의 법적 지위



자료: 연구진 작성

제2절 주요 부처의 가이드라인 현황

1. 주요 부처의 가이드라인 전수조사

본 연구에서는 바이오헬스 분야의 가이드라인에 일차적인 관심이 있으므로 바이오 헬스 분야의 연구개발과 사업화를 지원하는 3개 부처, 즉 식품의약품안전처, 보건복지부, 과학기술정보통신부를 조사 대상으로 삼고, 이 3개 부처가 발간한 가이드라인을 전수 조사했다. 가이드라인 이전에 먼저 부처별 법령 수를 보면, 법률 - 시행령 - 시행규칙을 모두 더한 수 기준으로 복지부가 316개로 가장 많았고, 과기부가 191개, 식약처 81개였다. 흥미로운 점은 보통은 법률의 수가 가장 적고 시행령, 시행규칙 순으로 법령의 수가 늘어나는 것이 상례이지만, 과기부는 시행규칙의 수가 법률이나 시행령의 수보다 작았다.

<표 2-3> 3개 부처의 법령 현황

법령정보센터	식약처		복지부		과기부	
	전분야	바이오헬스	전분야	바이오헬스	전분야	바이오헬스
법률	24	23	97	54	68	4
시행령	27	25	103	57	76	4
시행규칙	30	26	116	71	47	1
합계	81	74	316	182	191	9

자료: 법령정보센터 검색 결과

각 부처 소관 법령, 행정규칙, 가이드라인을 확인할 수 있는 곳은 법제처가 운영하는 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/>)와 각 부처 홈페이지이다. 2024년 6월에 국가법령정보센터와 3개 부처의 홈페이지를 조사해서 3개 부처의 행정규칙과 가이드라인 현황을 조사해보았다. 그 결과가 <표 2-4>에 정리되어 있다.

<표 2-4> 3개 부처의 행정규칙과 가이드라인 현황

출처	구분	식약처		복지부		과기부	
		전체	위임/집행	전체	위임/집행	전체	위임/집행
법령정보센터	고시	245	239	335	330	432	377
	훈령	165	19	96	36	384	102
	예규	68	34	493	36	73	13
	지침			3	1	7	1
	기타			5	3	94	11
	소계	478	292	932	406	990	504
부처 홈페이지 “법령정보”	고시	1,009		5,529		1,127	
	훈령	181		346		439	
	예규	159		254		38	
	지침			468			
	기타			3			
	소계	1,349		6,660 (가이드라인 12)		1,662 (가이드라인 2)	
홈페이지 기타 영역	공무원 지침서	399 (가이드라인 13)		보도자료에 가이드라인 24건			
	민원인 안내서	1,481 (가이드라인 967)		공지사항에 가이드라인 25건			
	각 부처의 특징 요약	가이드라인형: 행정규칙이 아닌 가이드라인이 많고, 많은 업무를 여기에 의존		행정규칙형: 행정규칙 수가 매우 많고, 많은 업무를 여기에 의존		법규형: 행정규칙 수가 상대적으로 적고, 많은 업무를 법령으로 해결	

자료: 법령정보센터 및 각 부처 홈페이지 검색 결과, 2024년 6월 기준

가. 행정규칙 현황

행정규칙 현황을 보면 우선 국가법령정보센터의 수치와 각 부처 홈페이지의 수치가 크게 다른 점이 눈에 들어온다. 과기부는 홈페이지의 행정규칙이 1,662건인 반면 국가법령정보센터에는 990개만 등록되어 있었다. 복지부는 각각 6,660개와 932개로 차이가 매우 컸고, 식약처는 1,349개와 478개로 역시 차이가 컸다. 이러한 차이가 발생한 이유로 우선 각 부처 홈페이지에는 업데이트된 행정규칙의 과거 버전이 함께 남아 있어서 하나의 행정규칙이 중복 집계된 결과로 추정된다. 그러나 그럼에도 수치의 차이가 너무 크게 나타나고 있다. 아마도 각 부처 홈페이지의 자료가 더 정확하고,

국가법령정보센터에 등록된 정보는 여러 이유로 부처가 미처 등록하지 못해서 누락된 행정규칙들이 많아서 적게 나타난 것으로 추정된다. 국가법령정보센터와 홈페이지 중 어느 쪽이 더 정확한 정보를 담고 있는지 확인하려면 양쪽에서 리스트를 다운로드 받은 뒤 업데이트가 있을 경우 과거 버전을 다 지운 뒤에 다시 양쪽의 리스트를 비교하면 될 것이다. 그러나 이 연구의 주된 관심이 아니어서 시도하지 않았다.

국가법령정보센터에 등록된 각 부처의 행정규칙은 과기부 990개, 복지부 932개, 식약처 478개로 나타났다. 이 중에서 법령보충적 행정규칙으로 분류되는 위임행정규칙과 집행행정규칙은 과기부 504개, 복지부 406개, 식약처 292개였다. 세 부처 모두 전체 행정규칙 중 법령보충적 행정규칙의 비율이 50% 내외에 달한다는 것을 확인할 수 있다. 그리고 과기부는 특이하게도 시행규칙은 법률이나 시행령보다 적었지만 행정규칙은 세 부처 중 가장 많았다. 그러나 부처 홈페이지 기준으로는 복지부가 압도적으로 많은 행정규칙을 가지고 있었다.

나. 가이드라인 현황

행정규칙의 수가 국가법령정보센터보다 부처 홈페이지에 더 많고 부처 홈페이지에는 행정규칙 외에도 다양한 종류의 문서들이 공개되고 있어서 각 부처의 가이드라인 현황은 부처 홈페이지 기준으로 조사하였다. 각 부처의 홈페이지에서 “법령정보” 게시판에 우선 검색한 후 공지사항, 보도자료, 자료실 등 다른 게시판도 검색해서 문서 제목에 “가이드라인”이 포함된 문서를 모두 찾았다. 이렇게 조사한 결과는 다음과 같다.

과기부는 행정규칙 중 2건의 문서만 가이드라인으로 확인되었다.

복지부는 법령정보(행정규칙) 게시판에서 12건의 가이드라인이 나왔고, 보도자료에서 24건, 공지사항에서 25건의 가이드라인이 각각 나왔다. 모두 합하면 61건이지만, 3개의 게시판에 중복 게시되거나 업데이트 버전이 함께 남아 있는 등 중복 문서가 많아서 중복을 제거하면 모두 23건이 나왔다.

식약처는 법령정보(행정규칙) 게시판에는 가이드라인이 전혀 없었다. 대신 “자료실” 메뉴 아래에 있는 “안내서/지침” 게시판에 980건의 가이드라인이 올라와 있었다. 공무원 지침서 게시판에 13건, 민원인 안내서 게시판에 967건이 있었다.

이상 각 부처의 가이드라인에 대한 기초 통계 결과로부터 다음과 같은 결론을 도출할 수 있다.

첫째, 가이드라인에 대해 별도의 정의를 내리거나 따로 관리하는 부처는 없었다.

둘째, 가이드라인이라는 말을 사용하는 방식이 부처마다 달랐다. 과기부와 복지부는 가이드라인이라는 단어에 특별한 행정적 의미를 부여하지는 않은 것 같다. 이에 비해 식약처는 공무원지침서와 민원인안내서에만 가이드라인이라는 표현을 사용했다.

셋째, 앞서 우리 법규 체계에서 가이드라인에 가장 근접한 것이 행정규칙이라고 했지만, 어느 부처도 가이드라인을 행정규칙으로 정의하거나 둘을 동일시하지 않았다. 결론적으로, 가이드라인은 “법적 지위가 없거나 관리되지 않는 문서”였다.

이하에서는 식약처와 복지부의 가이드라인 관리 현황을 자세히 살펴보겠다. 과기부는 가이드라인이 두 건 밖에 없어서 추가 설명에서는 제외했다.

2. 식약처의 가이드라인 관리 현황

식약처는 정부 부처 중 가이드라인을 가장 많이 활용하는 부처로, 가이드라인의 활용 뿐 아니라 관리체계도 모범적으로 구축하고 있어서 타 부처들이 참고할 만한 내용이 많다. 그래서 식약처의 가이드라인을 조금 더 자세히 분석해보자.

가. 가이드라인의 법적 위치

식약처는 공무원지침서와 민원인안내서 중 일부를 가이드라인이라는 이름으로 발간하고 있다. 특히 민원인안내서 1,481건 중 967건이 가이드라인이라는 점에서 식약처는 가이드라인을 민원인안내서와 거의 동일시한다고 볼 수 있다. 그런데, 홈페이지 상에서 이 공무원지침서와 민원인안내서는 “법령정보”로 분류되어 있다. 식약처 홈페이지의 법령정보 게시판은 다시 7개의 하위 게시판으로 구분된다. 법령의 위계구조를 고려하면 <표 2-5>와 같이 배치할 수 있다. 이 배치를 보면 가이드라인이 주로 포함된 민원인안내서는 법, 시행령, 시행규칙의 법규명령도 아니고, 고시, 훈령, 예규 같은 행정규칙도 아니다.

<표 2-5> 식약처 홈페이지의 “법령정보” 게시판 하위 구조

층위	“법령정보” 게시판		
법령	• 법, 시행령, 시행규칙	• 법률 제/개정 현황	• 입법/행정예고
행정규칙	• 고시, 훈령, 예규	• 제/개정 고시 등	
기타	• 공무원지침서, 민원인안내서		• 식의약법령정보 모바일서버
홈페이지 캡처	정보공개 / 국민소통 / 알림 / 법령/자료		
	법령정보	• 법, 시행령, 시행규칙 • 공무원지침서/민원인안내서	• 고시훈령예규 • 식의약법령정보 모바일서버
	자료실	• 안내서/지침	• 학술 토론회

자료: 식약처 홈페이지 구조를 표로 배치

[그림 2-5] 가이드라인의 법적 위치

가이드라인의 법적 위치		가이드라인 안내문
법규	법률	이 안내서는 ‘항암제 임상시험’에 대하여 알기 쉽게 설명하거나 식품의약품안전처의 입장을 기술한 것입니다. 본 안내서는 대외적으로 법적 효력을 가지는 것이 아니므로 본문의 기술방식(‘~하여야 한다’ 등)에도 불구하고 민원인 여러분께서 반드시 준수하여야 하는 사항이 아님을 알려드립니다. 또한, 본 안내서는 2024년 10월 현재의 과학적·기술적 사실 및 유효한 법규를 토대로 작성되었으므로 이후 최신 개정 법규 내용 및 구체적인 사실관계 등에 따라 달리 적용될 수 있음을 알려드립니다. ※ “민원인 안내서”란 대내외적으로 법령 또는 고시·훈령·예규 등을 알기 쉽게 풀어서 설명하거나 특정한 사안에 대하여 식품의약품안전처의 입장을 기술하는 것(식품의약품안전처 지침서등의 관리에 관한 규정 제2조)
	시행령(대통령령)	
	시행규칙(총리령, 부령)	
↓ 위임 사항이 명시적 위임 사실 강조		
행정규칙 I	고시, 훈령, 예규, 지침 등 (법적 구속력 有)	
↓ 위임 사항이 암묵적		
행정규칙 II	공무원지침서 민원인안내서(가이드라인) (법적 구속력 無)	

자료: 연구진 작성

자료: 식약처, “항암제 임상시험 가이드라인”, p.2

가이드라인의 법적 위치는 모든 가이드라인의 두 번째 쪽에 실려 있는 안내문에 보다 명확히 드러난다. 이 안내문에는 ““민원인 안내서”란 대내외적으로 법령 또는

고시·훈령·예규 등을 알기 쉽게 풀어서 설명하거나 특정한 사안에 대하여 식품의약품안전처의 입장을 기술하는 것”이라는 설명과 함께 “본 안내서는 대외적으로 법적 효력을 가지는 것이 아니므로”라는 문구가 포함되어 있다. 이 문장들을 종합하면, “가이드라인은 법적 구속력이 있는 법령보충적 행정규칙(고시·훈령·예규 등)에 대한 해설서이며 법적 구속력은 없는 부처의 임의 문서”라고 정리할 수 있다. 기존의 법령과 행정규칙의 위임 관계 속에 가이드라인을 넣는다면 [그림 2-5]의 왼쪽과 같이 정리될 수 있다.

나. 임상시험 허가 신청서 작성에 관한 가이드라인 사례

[그림 2-5]에 묘사된 법령 - 행정규칙 - 가이드라인으로 이어지는 위계 구조가 실제 어떻게 구현되는지 사례를 통해 살펴보자. 임상시험 계획의 승인 업무는 식약처의 주요 업무 중 하나이다. 이 업무가 어떤 법률 조항에 근거한 것이고, 어떤 경로를 거쳐 최종 가이드라인까지 연결되는지 [그림 2-6]에 정리해 보았다.

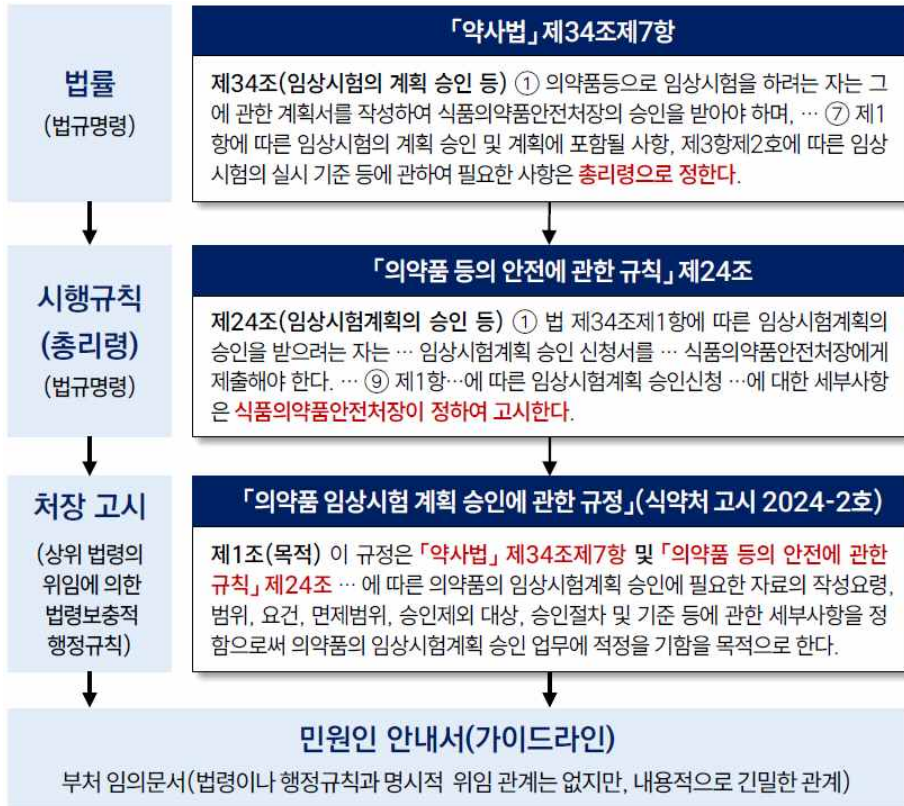
우선 「약사법」 제34조 7항에 임상시험 계획서의 승인 절차가 규정되어 있고, 구체적인 내용은 총리령에 위임되어 있다.

그 다음 총리령(시행규칙)인 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제24조에서 약사법이 위임한 사항을 받아서 절차를 조금 더 자세히 규정한 후, 더 상세한 부분은 행정규칙인 식약처장 고시에 위임한다.

이렇게 시행규칙의 위임을 받은 행정규칙은 법적 구속력을 지니는 법령보충적 행정규칙이 된다. 처장 고시에서는 고시의 근거가 되는 상위 법들이 언급되고 상세한 절차를 제시한다.

마지막으로 가이드라인은 처장 고시의 내용을 각 질환별로 자세히 풀어서 설명해준다. 임상시험에 관한 일반적인 내용과 각 질환별 내용을 포함해서 50쪽이 넘는 가이드라인 71개가 제작되어 있다(표 2-6).

[그림 2-6] 임상시험 계획의 승인에 관한 법률 - 행정규칙 - 가이드라인 사례



자료: 연구진 작성

<표 2-6> 임상시험 허가 신청서 작성에 관한 가이드라인

임상시험 허가 신청서 작성 가이드라인	
1. 의약품 임상시험 결과보고서의 구성과 내용 가이드라인	36. 의약품 임상시험 통계 가이드라인
2. 의약품 임상시험 결과보고서의 구성과 내용 가이드라인 질의응답집	37. 임상시험 전자동의 가이드라인
3. 의약품 임상시험 대조군 설정 가이드라인[민원인 안내서]	38. 임상약리시험가이드라인
4. 의약품 임상시험 위험도 기반 모니터링 가이드라인	39. 신생아 및 미숙아 대상 임상시험 가이드라인
5. 임상시험 정보 등록·공개 가이드라인(민원인 안내서)	40. 소아대상 임상시험 가이드라인
6. 임상시험 비대면실태조사 가이드라인(민원인안내서)	41. 소아용의약품 임상시험 가이드라인-항암제
7. 독립적인 자료 모니터링 위원회 설립 및 운영을 위한 가이드라인	42. 희귀질환 등 소집단 임상시험 가이드라인
8. 임상시험 전자자료 처리 및 관리를 위한 가이드라인	43. 고령자 대상 임상시험 가이드라인

임상시험 허가 신청서 작성 가이드라인

- | | |
|--|-----------------------------|
| 9. 임상시험 피해자 보상에 대한 규약 및 절차 마련을 위한 가이드라인 | 44. 항생제 임상시험 가이드라인 |
| 10. 임상시험 및 대상자보호프로그램(HRPP) 운영 가이드라인 | 45. 폐결핵 치료제 임상시험 평가 가이드라인 |
| 11. 임상시험용의약품의 치료목적 사용을 위한 가이드라인 | 46. 만성 C형 간염치료제 임상시험 가이드라인 |
| 12. 임상시험용의약품 GMP 평가 가이드라인 | 47. 항암제 임상시험 가이드라인[민원인 안내서] |
| 13. 임상시험 대상자 동의·설명서작성 가이드라인 | 48. 항암제 가교자료 면제를 위한 가이드라인 |
| 14. 다지역임상시험의 계획 및 설계에 관한 일반원칙 가이드라인 | 49. 위염 치료제 임상시험 가이드라인 |
| 15. 임상시험에서 유전체 시료 수집및자료 관리에 대한 가이드라인 | 50. 소화성궤양치료제 임상시험 가이드라인 |
| 16. 의약품 임상시험 시 성별 고려사항 가이드라인 | 51. 위식도역류질환치료제임상시험 가이드라인 |
| 17. 임상시험용의약품의 품질 가이드라인(민원인안내서) | 52. 궤양성대장염치료제임상시험 가이드라인 |
| 18. 항생제 임상용량 설정시약동학·약력학활용 가이드라인 | 53. 고혈압치료제 임상시험 가이드라인 |
| 19. 항생제: 복잡성 요로감염 임상시험 가이드라인 | 54. 고지혈증치료제임상시험 가이드라인 |
| 20. 항생제: 급성 세균성 피부 및 피부 구조 감염 임상시험 가이드라인 | 55. 체중조절약 임상시험 가이드라인 |
| 21. 항생제: 지역사회 획득 세균성 폐렴 임상시험 가이드라인 | 56. 경구 혈당강하제 임상시험 가이드라인 |
| 22. 경증중증증코로나19 항바이러스 치료제 임상시험 가이드라인 | 57. 골관절염치료제 임상시험 가이드라인 |
| 23. 폐경후여성 골다공증 예방 및 치료제 임상시험 가이드라인 | 58. 진통제 임상시험 가이드라인 |
| 24. 주의력결핍 과잉행동장애 치료제 임상시험 가이드라인 | 59. 알레르기비염치료제임상시험 가이드라인 |
| 25. 제네릭의약품임상시험자 자료집 작성 방법 가이드라인 | 60. 안구건조증 치료제 임상시험 가이드라인 |
| 26. 암 치료용 백신 임상시험 계획 평가 가이드라인 | 61. 호르몬대체요법제 임상시험 가이드라인 |
| 27. 간장애환자를 대상으로 하는 임상시험 가이드라인 | 62. 우울증 치료제 임상시험 가이드라인 |
| 28. 약물동태학: 반복투여 조직분포시험 가이드라인 | 63. 범불안장애치료제 임상시험 가이드라인 |
| 29. 의약품 개발 시 집단 약동학활용을 위한 가이드라인 | 64. 알츠하이머형 치료제 임상시험 가이드라인 |
| 30. 과민성 장 증후군 치료제 임상시험 가이드라인 | 65. 정신분열병치료제 임상시험 가이드라인 |
| 31. 만성 기능성 변비 치료제 임상시험 가이드라인 | 66. 간질치료제 임상시험 가이드라인 |
| 32. 류마티스관절염치료제 임상평가지침[가이드라인] | 67. 스테로이드성 피임제 임상시험 가이드라인 |
| 33. 항생제: 원내 감염 세균성 폐렴/ 인공호흡기 관련 세균성 폐렴
임상시험 가이드라인 | 68. 발모제 임상시험 가이드라인 |
| 34. 임상 약물유전체학: 초기 임상시험에서 활용/허가사항 기재 가이드라인 | 69. 차아미백제 임상시험 가이드라인 |
| 35. 임상시험의 전반적인 고려사항[가이드라인] | 70. 복합제임상시험 가이드라인 |
| | 71. 신장에 환자 대상 임상시험 가이드라인 |

자료: 식약처 홈페이지를 검색해서 연구진이 정리

다. 식약처 가이드라인의 분야별 분포

식약처가 제공한 2023.12.31. 기준 가이드라인 전체 목록에는 총 779개의 가이드라인 명칭이 들어 있다. 이 목록을 제품과 평가요소별로 분류한 뒤, 평가요소들은 다시 묶어서 연구개발에서 생산과 마케팅에 이르는 가치사슬 단계로 묶어 보았다. 그 결과 <표 2-7>과 같은 분포가 나왔다.

제품 분야별로는 의료기기 392건, 의약품 276건, 식품 63건, 화장품 48건 순으로 나타났다. 개발 단계별로는 허가와 임상 단계가 각각 290건과 185건으로 가장 많이 나와서 이 두 영역이 식약처의 주 업무 영역에 해당함을 보여주었다. 그 다음은 단계들 모두 비슷비슷한 수치가 나왔다. 비임상 98건, 판매 63건, 연구 59건, 종합평가 49건, 제조 35건이었다. 제품 분야와 가치사슬을 함께 고려한 경우, 의료기기의 허가 단계가 248건으로 가장 많았고, 그 다음 의약품 임상 단계가 81개로 나타났다. 역시 의료기기의 허가과 의약품의 임상시험 허가가 식약처의 가장 중요한 업무임을 방증해주는 결과이다.

<표 2-7> 식약처 가이드라인의 분야별 분포

분야	연구	비임상	임상	종합평가	허가	제조	판매	합계	그룹
의약품	12	29	81	5	17	13	16	173	의약 276
바이오의약품	16	9	6	25	5	6	12	79	
마약		3		1			2	6	
한약	4	1	3		2		1	11	
의약외품			2	2	2		1	7	기기 392
의료기기	20	13	44	14	248	13	16	368	
체외진단			9	2	13			24	
건강기능성식품	1	2	33			1	2	39	식품 63
식품		11			2	2	6	21	
음식점							3	3	
화장품	6	30	7		1		4	48	48
총합계	59	98	185	49	290	35	63	779	779

주: 식약처가 제공한 2023.12.31. 기준 가이드라인 목록을 평가요소 기준으로 분류한 후 이를 단계별로 묶음. 각 단계에 해당하는 평가요소나 주제는 다음과 같다.

- 연구=규격, 명명법, 시험평가법, 연구, 용어, 품질
- 비임상=비임상시험, 안전성, 위해성
- 임상=검사, 기능성, 동등성시험, 성능평가, 유효성, 임상시험, 효력시험
- 종합평가=임상&비임상, 평가
- 허가=기술문서, 허가심사
- 제조=제조, GMP
- 판매=수출입, 용기포장, 용량, 위생, 재고관리, 판매후관리, 표시광고

라. 식약처의 가이드라인 관리

마지막으로 식약처의 가이드라인 관리 체계를 살펴보자. 첫째, 모든 가이드라인은 해당 가이드라인을 제정하거나 개정할 타당성을 먼저 점검한 후 작업이 이루어진다. 가이드라인 담당자는 “지침, 안내서 재개정 점검표”를 활용해서 가이드라인의 제작이나 업데이트 필요성을 확인한 뒤, 그 점검표 결과를 가이드라인 첫 페이지에 수록한다. 둘째, 가이드라인 두 번째 페이지에는 [그림 2-5]에서 언급한 안내문이 수록된다. 이 안내문에는 ① 가이드라인이 법적 구속력을 가지는 행정규칙의 해설서에 해당한다는 것, ② 가이드라인 자체는 법적 구속력이 없다는 것, ③ 현 시점의 과학기술 지식에 기반해서 작성되었고 과학기술 지식이 변화되면 그에 따라 수정한 개정판이 나올 것을 명시하고 있다. 셋째, 모든 가이드라인에 자체 등록 번호를 부여하고 제/개정 이력표를 함께 수록한다.

[그림 2-7] 식약처 가이드라인의 제/개정 점검표와 제/개정 이력

지침·안내서 재개정 점검표				
영향	항암제 임상시험 가이드라인			
여기에 해당하는 사항에 체크하여 주시기 바랍니다.				
등록대상 여부	☐ 이미 등록된 지침·안내서 중 동일 유사한 내용의 지침·안내서가 있습니까?	☐ 예 ☒ 아니요	등록번호 안내서-0235-04	
	※ 상기 질문에 '예'라고 답하신 경우 기존의 지침·안내서의 개정을 우선적으로 고려하시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 등 지침·안내서의 개정이 필요한 경우 그 사유를 아래에 기재해 주시기 바랍니다. (사유 :)			
	☐ 법령(법시행령 시행규칙) 또는 행정규칙(고시·훈령·예규)의 내용을 단순 편집 또는 나열한 것입니까?	☐ 예 ☒ 아니요		
	☐ 단순한 사실을 대외적으로 알리는 공고의 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니요		
	☐ 1년 이내 합리적 적용 또는 유효성 지사 설명에 해당하는 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니요		
	☐ 외국 규정을 번역하거나 설명하는 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니요		
	☐ 정보제공 등 직원 교육용 자료입니까?	☐ 예 ☒ 아니요		
	※ 상기 사항 중 어느 하나라도 '예'에 해당되는 경우에 지침·안내서 등록 대상이 아닙니다. 지침·안내서 재개정 절차를 적용할 필요는 없습니다.			
	지침·안내서 구분	☐ 내부적으로 행정사무의 통일을 기하기 위하여 반례적으로 행정사무의 세부기준이나 절차를 제시하는 것입니까? (공무용문)		☐ 예(=지침서) ☒ 아니요
		☐ 법령, 고시·훈령·예규와 같은 규정 또는 식약처장이 정한 특정사항에 대하여 그 절차 등의 내용을 알기 쉽게 풀어 설명하거나 식약처의 입장을 기술하는 것입니까? (민원안내)		☒ 예(=안내서) ☐ 아니요
기타 확인 사항	☐ 상위 법령을 일일하여 새로운 규정을 신설·삭제하거나 민원인을 구속하는 내용이 있습니까?	☐ 예 ☒ 아니요		
	※ 상기 질문에 '예'라고 답하신 경우 상위법령·일탈 내용을 삭제하시고 지침·안내서 재개정 절차를 진행하시기 바랍니다.			
상기 사항에 대하여 확인하였습니다.				
2024 년 10 월 31 일				
담당자 안 미 령 확 인(부서장)				

연번	제·개정번호	승인일자	주요내용
1	B1-2006-2-001	2006.01	제정
2	B1-2015-2-017	2015.12	가이드라인 명칭변경, 법적효력 문구 통일, 앞식표준화, 연락처 현행화
3	안내서-0235-02	2019.09.30	항암제 임상시험 설계 고려사항 제공, 무진행 생존 또는 무질병 생존 평가변수 고려사항 부록 추가
4	안내서-0235-03	2023.11.30	항암제 마스터 프로토콜 임상시험 부록 추가
5	안내서-0235-04	2024.10.31	항암제 임상시험 중 환자·보고 결과 부록 추가

자료: 식약처, “항암제 임상시험 가이드라인

3. 보건복지부의 가이드라인 관리 현황

가. 보건복지부의 가이드라인 현황

보건복지부 홈페이지 검색 결과 법령정보(행정규칙) 게시판에서 12건, 보도자료에서 24건, 공지사항에서 25건의 가이드라인을 확인했다. 모두 합하면 61건이지만, 3개의 게시판에 중복 게시되거나 업데이트 버전이 함께 남아 있는 등 중복 문서가 많아서 중복을 제거하면 모두 23건이 나왔다(표 2-8).

<표 2-8> 보건복지부의 가이드라인 현황

번호	게시된 곳	가이드라인 명
1	고시	요양병원 시설기준 세부가이드라인
2	고시, 보도자료	의료기관 개인정보보호 가이드라인
3	지침	DTC 유전자검사 가이드라인(일반 소비자용)
4	지침	비의료 건강관리서비스 가이드라인 및 사례집
5	지침	신종 코로나바이러스감염증 유행대비 집단시설·다중이용시설 대응지침
6	지침	어린이집 영상정보처리기기(CCTV) 설치 운영 가이드라인
7	지침, 공고	진료정보 교류를 위한 전자의무기록시스템 연계 가이드라인
8	지침, 공고, 보도자료	제대혈은행 표준업무 홍보 약관 가이드라인
9	공고, 보도자료	간호인력 야간근무 가이드라인
10	공고, 보도자료	보건의료데이터 활용 가이드라인
11	공고, 보도자료	응급구조사 현장 및 이송업무, 응급환자중증도에 따른 병원간 이송 가이드라인
12	공고	사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인
13	공고	유전체검사관련 가이드라인
14	공고	자살예방을 위한 언론보도 가이드라인
15	공고	한시적 비대면 진료 중개 플랫폼 가이드라인
16	보도자료	노인장기요양기관 건강관리가이드라인
17	보도자료	불필요한 방사선 검사 줄이기 위한 영상진단 가이드라인
18	보도자료	수혈가이드라인
19	보도자료	심폐소생술 가이드라인
20	보도자료	우리나라 간세포암종 진료 가이드라인
21	보도자료	첨단재생의료 임상연구 가이드라인
22	보도자료	트라우마 예방을 위한 재난보도 가이드라인
23	보도자료	흡연 예방 미디어 가이드라인

자료: 보건복지부 홈페이지에서 검색 후 연구진 정리

나. 보건복지부의 가이드라인 관리 현황

식약처와 달리 보건복지부는 가이드라인이 많지 않고 복지부 업무에서 가이드라인이 주요 수단으로 활용되는 경우도 많지 않다. 그래서 복지부는 가이드라인에 대한 별다른 관리 체계가 없다. 홈페이지 ‘알림’ 밑에 공지사항이나 보도자료에 공개하거나, ‘법령’ 중 하나인 훈령/예규/고시/지침의 형태로 제시되었다. 가이드라인의 법적 구속력에 대한 설명이 없고, 제정/개정/폐기의 기준과 이력 관리도 없다.

〈표 2-9〉 복지부와 식약처의 가이드라인 관리 비교

비교 항목	식약처	복지부
문서 형태	공무원지침서, 민원안내서	고시, 지침, 공고, 보도자료
홈페이지 게시 방법	법령정보 코너	법령정보와 공지사항 코너
법적 효력	가이드라인의 법적 효력이 없음을 명시	고시나 지침은 법적 효력이 있을 수 있음
관리체계	자체 등록번호 부여, 가이드라인의 제정/개정/폐기 이력 공개 가이드라인 제정/개정/폐기의 자체 기준과 절차 보유 가이드라인 제/개정 점검표	별도의 관리 체계 없음
가이드라인의 법적 위치	법령보충적 행정규칙에 대한 해설서	언급 없음

자료: 연구진 작성

| 제3장 | [사례1] 보건의료 데이터 활용 가이드라인

제1절 가이드라인의 개요¹⁾

1. 필요성 및 목적

‘보건의료 데이터 활용 가이드라인’은 2020년 8월 데이터 산업의 발전을 위해 가명정보의 개념을 도입한 개인정보보호법(이하 보호법) 개정 이후 보건복지부가 2020년 9월에 발표한 후속조치이다. 개인정보보호위원회에서 발표한 ‘가명정보 처리 가이드라인’과 달리 보건의료 데이터 활용 가이드라인은 보호법에서 구체적으로 정하지 않은 가명화 처리 및 가명화된 정보의 결합 활용 등에 있어 보건의료 데이터의 특수성을 고려할 필요가 있었기 때문이다. 즉 보건의료 데이터는 생명이나 신체와 직결된 민감정보를 포함하기 때문에 더 세심한 관리 기준이 필요했다(이석배, 2021).

본 가이드라인은 보건의료 데이터의 분야·유형·목적별 세부 방법과 절차를 제시하여 현장의 혼란을 최소화하고, 처리 과정 전반에 걸친 절차 및 거버넌스, 안전조치, 윤리적 사항 등을 제시하여 정보 주체의 권익 보호 및 안전한 개인정보 처리를 도모하는 것을 목적으로 한다.

2. 주요 내용

보건의료 데이터 활용 가이드라인은 개인정보처리자가 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위해 정보 주체의 동의 없이 가명정보를 생성, 이용, 제공하거나 결합할 수 있음을 명시한 보호법 제28조의2~3을 보건의료 데이터 활용의 기본 원칙으로 삼고 있다. 본 가이드라인에서 별도로 정하지 않은 사항은 개인정보보호위원회의 ‘가명정보 처리 가이드라인’을 준용해야 하며, 다른 법률에 개인정보 처리 및 보호와 관련한 특별한 규정이 있는 경우에는 그 법을 따라야 한다. 또한 개인정보의 가명

1) 보건복지부·개인정보보호위원회(2024.1), 『보건의료 데이터 활용 가이드라인』을 바탕으로 작성됨

처리가 현실적으로 불가능하거나 개인 식별 위험성을 낮추지 못하는 경우에는 정보주체의 동의를 받아 활용해야 한다.

가장 최근인 2024년 1월에 발표된 ‘보건의료 데이터 활용 가이드라인’은 ①가명처리 방법, ②데이터 제공 심의 방법, ③제공 및 활용 절차, ④주요 서식, ⑤안전·보호 조치 등을 주요 내용으로 포함하고 있다(보건복지부 보도자료, 2024.1.19.).

본 가이드라인에서는 보건의료 분야의 개인정보 가명처리 단계를 [그림 3-1]과 같이 5단계로 제시하며, 각 단계에서 필요한 서류 및 검토 기준, 데이터 유형별 적절한 가명처리 방법, 필수 조치사항 등을 안내하고 있다.

[그림 3-1] 보건의료 데이터 가이드라인에서 제시하는 개인정보 가명처리 단계



자료: 보건복지부·개인정보보호위원회(2024.1), p. 11.

또한 기관 내 활용, 제3자 제공, 가명정보 결합 및 반출 등 보건의료 분야에서의 가명정보 활용 사례별 절차를 제시하고, 각 사례의 단계마다 개인 식별 위험성, 목적 적합성, 처리 적정성, 안전성 등을 검토 및 심의하는 기관보건의료데이터제공심의위원회(이하 데이터심의위원회) 구성 기준 및 운영 절차 등을 제시하였다. 가명정보 이용·제공·심의·관리 등과 관련한 갖가지 서식과 예시들도 수범자들이 참고하여 활용할 수 있도록 제공하고 있다.

가명정보는 개인정보에 속하지만 정보주체의 동의가 면제되어 비교적 활용이 용이한 만큼 일반 개인정보에 비해 추가적인 안전조치가 필요하다. 따라서 보호법과 시행령에서는 가명정보를 안전하게 관리하기 위한 기술적·관리적·물리적 안전조치 기준 및 방안을 명시하고 있다. 본 가이드라인에서도 보호법 및 시행령에 기반하여 보건의료 데이터의 안전한 관리를 위한 조치들을 안내하고 있다.

제2절 가이드라인의 개정 이력

2020년 9월 처음 발표된 ‘보건의료 데이터 활용 가이드라인’은 2024년 8월까지 총 세 번의 개정이 이루어졌다. 1차 개정본(개인정보보호위원회·보건복지부, 2021.1)은 최초의 가이드라인 발표 이후 데이터심의위원회 구성 및 운영의 부담, 가명정보 제공자와 수령자 간의 불명확성 등으로 실제 활용에 어려움이 있다는 현장의 의견을 반영하여 내용을 개정하였다(신태섭, 2021). 데이터심의위원회 구성의 용이성을 위해 보건복지부 지정 기관인 재단법인 한국보건의료정보원을 통해 외부 전문가 명단을 제공받을 수 있도록 하였으며, 데이터심의위원회의 심의 업무를 내부 기관생명윤리위원회(이하 IRB) 혹은 외부기관에 위탁할 수 있도록 하였다. 또한 동일 목적 및 유형의 가명처리 건에 대해 기관장의 재량 하에 일부 심사를 생략할 수 있도록 하여 데이터심의위원회 운영 부담을 완화하고자 했다. 그리고 가명정보 제공 시 정보 제공자와 수령자 간 권리 및 의무 관계를 명확히 할 수 있도록 표준 계약서(안)를 제시하였다.²⁾

2차 개정본(보건복지부·개인정보보호위원회, 2022.12)의 주요 개정 내용은 의료영상정보의 분류체계 단일화 및 가명처리 방법의 변경, 데이터심의위원회 운영기준 개선 등이다. 먼저 체내영상, 체외영상, 단층촬영 및 3D 이미지 정보로 구분되었던 의료영상정보를 ‘영상정보’로 단일화하여 가명처리 공통기준을 제시했다. 가명처리 방법 또한 개인 식별자 및 신체 가장자리를 일률적으로 삭제하는 대신 개인 식별가능성을 차단하기 위해 특정 영역 삭제 및 모자이크 등의 방법을 취하도록 했다. 가명처리 방법의 적정성은 데이터심의위원회의 판단을 통해 결정하도록 함으로써 의료 현장의 자율성과 가명정보 활용도를 제고하고자 했다.

1차 개정 이후 2차 개정에서도 의료 현장의 데이터 활용을 촉진하고자 데이터심의위원회 구성 및 운영 기준을 정비하였다. 위원 수 5인 이상 15인 이하 구성에서 15인 이하의 상한을 삭제하였고, 외부위원 또한 과반수 참여에서 정보보호 분야 전문가 1인, 정보주체의 이익을 대변할 수 있는 외부위원 1인을 포함하는 2인 이상으로 변경

2) 보건복지부(2021.1.28.), 「보건의료 데이터 활용 가이드라인 주요 개정내용」, https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10501010000&bid=0003&tag=&act=view&list_no=363309(검색일: 2024.8.26.)

되었다. 또한 데이터심의위원회의 심의 기록에 대해서도 속기록 및 녹취파일을 보관하는 대신 회의록을 작성하여 보관하는 것으로 변경되었으며, 정보공개 내용 또한 간소화되었다. 이 외에 당시 개인정보보호위원회의 ‘가명정보의 결합 및 반출 등에 관한 고시’, ‘가명정보 처리 가이드라인’ 개정사항인 가명처리 절차, 결합전문기관 지정기준 등의 변경 내용이 본 가이드라인에도 반영되었다.³⁾

2024년 1월에 발표된 3차 개정본(보건복지부·개인정보보호위원회, 2024.1.)의 주요 개정 내용 중 하나는 기존에 가명처리를 통한 활용을 유보했던 비정형 보건의료 데이터의 가명처리 활용이 가능해지게 된 점이다. 보건의료 분야는 비정형 데이터가 다양하게 존재하고 있어 일률적인 가명처리 방법 및 기준 제시가 어렵기 때문에 개인정보처리자 스스로 데이터 유형별 가명처리 방식을 선택하여 사용하도록 하는 가명처리 원칙이 신설되었다. 2차 개정본까지 안전한 가명처리 방식이 개발되지 않은 경우로 분류되어 활용 유보 대상이었던 유전체데이터, 자유입력 데이터(문자열), 음성데이터에 대해 적절한 가명처리 방법의 예시를 수록하여 참고할 수 있도록 했다. 이로 인해 의학적 가치가 높은 의료인의 자유입력 차트 데이터, 유전자검사 파일 및 기록지 등의 가명처리를 통한 활용이 이루어질 것으로 기대하고 있다.⁴⁾

또한 가명정보 제공자의 책임소재에 대해 명확히 함으로써 보건의료 데이터 활용 과정에서 가명정보 제공자가 과도한 법적책임을 부담하지 않도록 했다. 먼저 개인정보처리자가 보호법에 따라 가명처리와 안전조치 등을 모두 준수한 경우, 의도치 않게 특정 개인을 식별할 수 있는 정보가 생성되었다는 사실만으로 처리자와 제공자를 처벌하지 않도록 했다. 2차 개정본에서는 가명정보 제공자와 제공받는 자 간 ‘계약’으로 명확한 책임관계를 정하라고 안내함으로써 각 주체의 법적 책임 기준이 다소 불명확하였으나, 3차 개정본에서는 가명정보를 제공받은 자의 안전조치 미이행으로 인한 정보 유출, 고의적인 재식별 행위에 대해서는 해당 행위자만 제재하기로 하였다.

3) 메디컬월드뉴스(2022.12.29.), 「보건복지부 ‘보건의료 데이터 활용 가이드라인’ 개정 주요 내용은?」, <https://www.medicalworldnews.co.kr/m/view.php?id=1510953359>(검색일: 2024.8.26.); 보건복지부(2022.12.28.), 「보건의료 데이터 활용 가이드라인 주요 개정내용」, https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503010100&bid=0027&act=view&list_no=374311&tag=&nPage=88(검색일: 2024.8.26.)

4) 법률신문(2024.2.3.), 「보건의료 데이터 활용 가이드라인 개정 및 시사점」, <https://www.lawtimes.co.kr/LawFirm-NewsLetter/195658>(검색일: 2024.8.27.)

데이터심의위원회 운영과 관련한 실무상 논란이 계속됨으로써 3차 개정본에서는 데이터심의위원회가 기관 내부 관리계획에 따라 구성·운영하는 검토위원회임을 명시하였고, 위원 구성 요건 또한 외부위원 포함 필수(“구성해야 함”)에서 권장사항(“구성할 수 있음”)으로 기준이 완화되었다(법률신문, 2024.2.3.). 이 외에 보호법 개정내용을 반영하여 가명정보 파기에 관한 내용을 안전한 관리 조치 중 하나로 추가하였으며, 가명정보 심의·관리·제공 과정에 활용할 수 있는 서식들을 참고자료로 수록하였다.

〈표 3-1〉 보건의료 데이터 활용 가이드라인 주요 개정 내용

개정본 발표시기		주요 개정 내용
최초 발간	2020.9	-
1차 개정	2021.1	• 데이터심의위원회 구성 및 운영 간소화 - 외부 전문가 명단 제공 - 데이터심의위원회 심의 업무 외부 위탁 가능, 일부 심사 생략 가능한 영역 등 안내 • 가명정보 제공활용 시, 정보 제공자와 수령자 간 권리의무 관계를 명확히 할 수 있도록 표준 계약서(안) 제시
2차 개정	2022.12	• 의료영상정보 분류체계 단일화 - (기존) 체내영상, 체외영상, 단층촬영·3D이미지 정보 → (개선) 영상정보 • 데이터심의위원회 구성 기준 완화 - (위원 수) (기존) 5인 이상 15인 이하 → (개선) 5인 이상(상한 삭제) - (외부위원 비중) (기존) 과반 이상 → (개선) 2인 이상
3차 개정	2024.1	• 비정형데이터의 가명처리 범위를 확대, 적정 처리방법 제시 - (기존) 가명처리 및 활용 유보 → (개선) 개인정보처리자가 데이터 유형별 적절한 가명처리 방법을 선택하도록 원칙 신설 • 가명정보처리자의 법적 책임 명확화 - 가명정보를 제공받은 자의 위법(예. 유출, 재식별)으로 발생한 사안에 대해서는 해당 행위자만 제재(제공자는 면책) • 데이터심의위원회 구성 및 운영 간소화 - 데이터심의위원회는 기관 내부 관리계획에 따라 운영됨을 명시 - 외부위원 포함 요건이 필수에서 권장사항으로 완화

자료: 각 개정본 내용을 바탕으로 연구진 정리

제3절 가이드라인을 둘러싼 주요 이슈

1. 가이드라인의 법적 구속력의 한계

보건의료 데이터 활용 가이드라인의 주요 한계로서 가장 많이 언급되는 것은 가이드라인이라는 수단 자체가 가지는 법적 한계이다. 일반적으로 가이드라인이란 행정기관이 일정 행정목적 달성을 위해 필요한 기준과 절차를 정한 것으로 법적 구속력은 없는 행정지도의 일종으로 볼 수 있다. 즉 행정목적 달성을 위한 행동 유도 및 협력을 구하는 행정작용으로, 실질적 위법성의 평가기준이 될 수는 있으나 이를 따르지 않더라도 제재가 따르는 않는다(김동희, 2017; 이기호·김계현, 2020, p. 107).

보건의료 데이터 활용 가이드라인은 현행 개인정보 보호 관련 법령의 해석 및 적용과 관련한 실무적 지침 또는 행정지도를 제시한 것으로 해석할 수 있다. 그러나 보건의료 데이터 활용 가이드라인의 근거로 명시된 개인정보보호법은 가명처리와 가명정보 처리 등에 대해 구체적으로 규정하지 않았고, 이를 하위 법령에 명시적으로 위임하지도 않았다. 따라서 보건의료 데이터 활용 가이드라인의 내용은 보호법에 명시하지 않는 이상 해석과 법적 효력이 문제되는 한계가 있다(신태섭, 2021). 법률에 근거 없는 의무를 부과할 수 없기 때문에 본 가이드라인의 내용은 개인정보처리자에 대한 권고 수준으로서만 기능할 수 있다(이석배, 2021).

게다가 데이터는 산업 분야별로 규제 내용이 상이하여 관련 법문이 여러 법령에 산재해 있고, 보건의료 데이터 활용 가이드라인과 관련한 법률은 해당 가이드라인에서 근거로 제시한 보호법 외에도 존재한다. 가이드라인이 올바른 행위준칙으로 기능하기 위해서는 관련 법들과의 일관성을 갖추고 실무의 변화를 반영하기 위한 노력이 필요하다(김지희, 2022). 하지만 보건의료 데이터 활용 가이드라인의 내용은 관련된 실정법들과 충돌되는 부분이 존재할 뿐만 아니라, 법률 형식으로 규정되는 것이 바람직한 내용임에도 불구하고 가이드라인에 존재함으로써 인해 현장의 혼란을 야기한다는 지적이 계속되고 있다(김수정, 2022). 이러한 가이드라인의 법적 한계는 아래의 다른 이슈들과 밀접하게 연관되어 보건의료 데이터의 활용에 걸림돌이 되고 있다.

2. 관련 법과의 부정합성

가. 가명처리에 관한 위임 조항 부재(개인정보보호법)

개인정보보호법 제23조는 건강정보를 민감정보로 규정함으로써 정보주체의 별도의 동의를 받거나 법령에서 허용하는 경우 이외에는 그 처리를 엄격하게 제한하고 있다. 본 가이드라인에서는 보건의료 분야의 개인정보 가명처리에 대해 동 가이드라인을 적용한다고 명시했지만, 이석배(2021)는 보호법 상 민감정보인 건강정보에 대해 법령상의 위임 규정 없이 가이드라인의 내용을 근거로 정보주체의 동의 없이 가명처리가 가능하다고 해석하는 것은 무리가 있다고 지적하였다(법률신문, 2021.10.21.). 또한 이와 같이 법령에 명시된 민감정보의 가명처리에 관한 법적 근거를 명확하게 제시하지 못하는 것은 그 판단에 따른 책임도 의료기관에 일임하고 있는 것으로써, 가명처리된 보건의료 데이터에 대해 보호법의 가명처리 특례 규정과 민감정보 보호 규정 중 무엇이 우선 적용되는지에 대한 입법적 정리가 필요하다고 지적하였다.

나. 가명정보 활용 목적의 상세 정의 부재(개인정보보호법)

개인정보보호법과의 또 하나의 주요 쟁점은 가명정보 활용 목적에 관한 것이다. 보건의료 데이터 활용 가이드라인은 보호법 제28조의2에 따라 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등의 목적에 대해 정보주체의 동의 없이 가명처리 및 활용이 가능하다고 하고 있다. 언급된 세 가지 목적 중 ‘통계작성’, ‘공익적 기록보존’에 대한 용어 정의규정은 보호법에 없으며, ‘과학적 연구’는 ‘기술의 개발과 실증, 기초연구, 응용연구 및 민간 투자 연구 등 과학적 방법을 적용하는 연구’로 포괄적으로 규정되어 있다. 반면 본 가이드라인에서는 ‘통계작성’의 범위로 ‘상업적 목적의 통계 처리’를 포함하고, ‘과학적 연구’는 ‘산업적 목적의 연구’를 포함하는 것으로 정의하였다. 이와 같이 공익적 목적 이외의 활용에 대한 내용이 보호법에 명확히 규정되어 있지 않고 별도의 위임 규정도 없이 가이드라인에 규정됨으로써 해석 상의 논란이 발생할 수 있고 법적 효력도 제한될 수 있다. 신용정보보호법에 상업적 목적의 통계작성과 산업적 연구를

포함하는 내용을 명시한 금융 분야처럼, 현장의 혼란을 줄이고 분야 내 데이터 활용을 실질적으로 촉진시키기 위해서는 가명정보 활용 목적의 범위를 가이드라인이 아닌 법률에 명시할 필요성이 있음이 지적되었다(신태섭, 2021).

다. 타 법률과의 관계 혼선(의료법, 생명윤리법)

보건의료 데이터 활용 가이드라인의 가명처리 활용 원칙에서는 ‘개인정보의 처리 및 보호에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그 법을 따라야 한다’고 명시하고 있다. 따라서 과학적 연구의 목적이라도 인간대상 연구⁵⁾에 해당하는 경우에는 **생명윤리법**에 따라 연구대상자의 서면동의 혹은 서면동의 면제에 관한 IRB의 승인이 필요하다. 이와 동시에 본 가이드라인에서는 의료기관에서 진료 목적으로 수집된 의료데이터 등을 가명처리하여 연구 목적으로 이용하려는 경우, 심의 면제 사항을 명시한 **생명윤리법 시행규칙** 제13조의 ‘연구대상자 등에 대한 기존의 자료나 문서를 이용하려는 경우’로 간주하여 기관 차원에서 가명처리가 확인된 경우 IRB 심의 및 연구대상자 동의를 면제할 수 있다고 명시하였다. 이와 같은 내용은 수범자의 혼란을 야기할 수 있다(신태섭, 2021; 김지희, 2022).

또한 본 가이드라인은 ‘가명처리하여 환자식별력이 없는 진료기록(정보)’, ‘의료기관 아닌 자가 보유하는 진료기록’에 대해 보호법이 규정한 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등의 목적으로 가명처리하여 활용하는 경우는 **의료법**이 적용되지 않고 본 가이드라인이 적용된다고 해석하고 있다. 이에 대해 일부 전문가들은 본 가이드라인에서 가명정보 역시 개인정보라고 규정하고 있으며, 행정의 법률적합성 원칙⁶⁾에 따라 가명처리된 진료기록에 의료법, 생명윤리법이 적용되지 않는다는 해석은 아무런 근거가 없다고 해석하고 있다(신태섭, 2021; 이석배, 2021).

이외에도 의료 데이터에 대해 관련 법률과 본 가이드라인이 상호 다른 용어를 사용⁷⁾

5) 인간대상 연구: 연구 대상자를 직접 조작하거나 환경을 조작하여 자료를 얻는 연구, 행동 관찰 및 대면 설문조사 등으로 자료를 얻는 연구, 연구 대상자를 직접·간접적으로 식별할 수 있는 정보를 이용하는 연구(생명윤리 및 안전에 관한 법률 시행규칙 제2조)

6) 행정은 법률의 범위 내에서 이루어져야 한다.

7) 보건의료 데이터 활용 가이드라인은 ‘가명정보, 추가정보, 익명정보’ 등의 용어를 사용하는 반면, 생명윤리법은 ‘개인 식별정보’라는 용어를 별도로 정의하고 있음(신태섭, 2021)

하거나 의미 상 차이가 존재⁸⁾하는 문제, 사망자 정보를 포함하는 의료법과 살아있는 개인에 관한 정보를 대상으로 하는 보호법 간의 차이 등 업무 혼선, 현장의 혼란, 입법 사각지대를 발생시킬 수 있는 가이드라인의 내용을 법률에 명시하고 각 법률 간 상호 관계를 명확히 정비할 필요가 있음이 지적되었다(신태섭, 2021).

3. 데이터심의위원회의 전문성과 공정성

본 가이드라인은 가명처리 및 가명정보 결합의 적정성, 개인정보처리자 내에서의 가명정보 활용 및 안전성, 외부로의 가명정보 제공 여부 및 방법 등에 대해 데이터심 의위원회가 심의하도록 규정하고 있다. 거의 모든 사례가 데이터심의위원회의 판단을 필수적으로 포함하고 있으며, 안전조치에 대한 구체적인 기준을 제시하고 있음에도 불구하고 이를 근거로 한 판단은 결국 데이터심의위원회가 담당하는 등 심의위원회에 의지하고 있는 부분이 상당하다(김지희, 2022). 이러한 역할의 데이터심의위원회는 다른 분야의 일반적인 가명처리 절차와는 구분되는 보건의료 분야의 특별한 요소이다 (신태섭, 2021).

이와 같이 보건의료 데이터 활용과 관련하여 핵심적인 역할을 하는 데이터심의위원 회의의 전문성과 공정성에 대한 비판은 최초 가이드라인이 발표된 이후로 꾸준히 제기 되어 왔다. 데이터심의위원회에 대한 내용 또한 개인정보보호법 등의 법령에서 위임 규정을 두고 있지 않은 본 가이드라인의 권고사항이기 때문에 위원회 구성 및 운영에 대한 법적 강제성이 없고 위반에 따른 특별한 제재 또한 없다(이기호·김계현, 2020). 또한 각 기관 위원회의 심의과정과 수준 등을 표준화·객관화할 수 있는 기준 또한 가 이드라인에서 제시하지 않았고, 위원회의 구성 및 운영을 기관 내부에 맡겨두었기 때 문에 ‘정보주체를 대변하는 자’의 역할을 수행할 환자를 해당 기관에 우호적인 환자로 위촉하는 등 목적과 취지에 맞지 않는 운영이 발생할 수 있음이 우려되었다(신태섭, 2021). 이러한 점은 수범자 입장에서 본 가이드라인이 권고한 대로 성실히 절차를 지

8) 생명윤리법의 ‘익명화’는 ‘개인식별정보를 영구적으로 삭제하거나, 개인식별정보의 전부 또는 일부를 해당 기관의 고유식별기호로 대체하는 것’으로써, 개인정보보호법(과 보건의료 데이터 활용 가이드라인)의 ‘익명정보’와 ‘가명처 리’의 개념을 모두 포함하는 것으로 해석될 수 있음(김지희, 2022)

킨다 하더라도 개인정보 유출사고 시 면책이 될 수 있는지가 불분명하기 때문에 오히려 정보의 폐쇄성을 야기시킬 수 있다는 점도 지적되었다(김지희, 2022).

이에 대해 전문가들은 데이터심의위원회의 공정성을 높이기 위해 구성과 관련한 보다 엄격한 기준과 절차를 마련하고, 책임을 명확화하며, 심의 과정에 대한 강제성을 부여하고, 구성과 기능에 대한 의무사항을 법령으로 규율할 것 등을 제안하였다(이기호·김계현, 2020; 신태섭, 2021; 김지희, 2022; 이하영·최봉석, 2023). 하지만 위와 같은 제언들은 현재까지 가이드라인 및 법령에 반영되지 않고 있으며, 오히려 외부위원 포함 요건이 필수에서 권장사항으로 완화되는 등 데이터심의위원회의 구성 및 운영 기준은 보건의료 데이터의 활용주체인 의료기관의 운영 편의성을 높이는 방향으로 개정되고 있다.

4. 정보주체의 권리 보호 관련 내용 축소

데이터 산업의 활성화를 위해 가명정보의 개념을 도입한 2020년의 개인정보보호법 개정은 가명처리된 개인정보의 제3자 제공을 가능하게끔 하는 데에 목적이 있다. 따라서 본 가이드라인에서는 ‘보호법 제28조의2제2항에 따른 제3자 제공 시 대가를 받는 것은 금지하고 있지 않다’고 명시하고 있으며, 가명정보 보유기관(개인정보처리자)과 활용기관이 참고할 수 있도록 ‘가명정보 제공 및 활용 계약서(안)’을 제공하고 있다.

신태섭(2021)은 위와 같은 내용에 대해 본 가이드라인은 사실상 개인정보의 판매를 허용하고 있는 것과 다름이 없다고 해석하였다. 또한 본 가이드라인의 가명정보 활용 목적에는 상업적 목적의 통계처리, 산업적 연구 등이 포함되기 때문에 공익적 목적 외에도 유료 제공이 가능한 것으로 해석될 수 있으며, 3차 개정본에서는 가명정보 제공 비용 산정 기준도 새롭게 추가되었다.

이와 같이 보건의료 데이터의 유료 제공, 즉 거래가 가능함을 전제로 하고 있지만 그 안에서 정보주체의 권리에 대한 논의는 이루어지지 않는 것으로 파악된다. 신태섭(2021)은 보건의료 데이터에 관한 권리를 재산권으로 인정할 수 있는지, 그 권리의 귀속 주체가 정보주체 또는 개인정보처리자 중에 누구인지, 영리 목적에 따른 사회적·

윤리적 문제 등에 대한 논의가 필요하다고 지적하였다.

또한 3차 개정본에서는 윤리적 조치가 삭제되고 추가된 ‘정보주체의 권리보장’ 내용에서 ‘보호법 제37조에 따라 정보주체의 가명처리 정지를 요구받았을 때에는 이를 보장하여야 함’을 명시하고 있다. 다만, 이미 해당 주체의 개인정보가 가명처리된 경우에는 가명처리 정지 요구가 적용되지 않으며, 향후의 가명처리가 이루어지지 않도록 처리한다고 한다. 이는 우리나라가 비식별화가 이루어진 정보는 개인정보가 아닌 것으로 추정하는 것을 전제로 하고 있다. 즉, 비식별화 이후에는 개인정보자기결정권 보장을 위한 모든 제약조건들을 법령 해석 상 면제할 수 있도록 유도하는 것이다. 하지만 해외 주요 국가들의 가이드라인 및 법령들은 비식별화 처리를 위한 데이터 제공 단계에서의 거부권 행사, 익명화 및 그 항목에 대한 고지 등 부분적인 개인정보자기결정권 실현 수단을 제공하고 있다(심우민, 2017: 43).

그 외에도 취약 연구대상자에 대한 개인정보 보호를 강화한 연구 설계의 중요성 등을 명시한 윤리적 조치 내용은 3차 개정본에서 삭제되는 등 정보주체의 권리 보호와 관련된 내용들은 점점 축소되고 있다.

5. 종합: 가이드라인의 실효성 부족

위와 같은 비판들이 제기된 상황에서 이하영·최봉석(2023)은 보건의료 데이터 활용에 관한 현행 규제체계는 데이터3법 및 개인정보보호법 개정, 보건의료 데이터 활용 가이드라인 마련 등에도 불구하고 적절한 시스템으로 자리 잡지 못했다고 평가했다.

산업연구원이 수행한 보건의료 분야 기업들의 데이터 활용 실태조사(최은희, 2023.5) 결과를 살펴보면, 데이터 수집 및 획득에 대한 가장 큰 장애요인으로 ‘법·제도적 제약(43.3%)’이 응답되었고, 외부 데이터를 수집하거나 활용을 위탁하지 않는 이유 또한 ‘법·제도적 제약(37.5%)’과 ‘분쟁 발생 시 책임소재 불분명(25.0%)’이 가장 높게 나타났다.

기업들의 데이터 획득 경로 또한 ‘자체 수집’이 86.7%로 가장 높게 나타남에 대해, 의료 데이터는 민감한 개인정보이기 때문에 정보보호 규제가 타 분야에 비해 강하게 작용하고 있고 유출 등의 문제가 발생했을 때의 책임 문제 등 리스크를 최소화하기

위해 기업 자체적 수집 비중이 높은 것으로 해석하고 있다. 또한 기업들은 자체 수집한 데이터를 다른 기업과 거래할 의향도 크지 않은 것으로 조사되었다.

이러한 결과는 보건의료 데이터의 활용을 위해 마련한 가이드라인이 현장의 법·제도적 제약에 대한 부담을 효과적으로 줄여주고 있지 못한 것으로 해석된다.

[그림 3-2] 의료 데이터 수집 및 획득 시 장애요인



자료: 최은희(2023.5), p. 29.

전문가들은 보건의료 데이터 활용 가이드라인의 목적인 보건의료 분야 개인정보처리자 및 연구자의 법적 안정성과 정보주체의 권리 보호를 위해서는 가이드라인의 법률화가 필요하다고 제안한다(이기호·김계현, 2020; 이석배, 2021; 이하영·최봉석, 2023; 법률신문, 2021.10.21.). 가명처리 방법의 기본 원칙에 대해서는 법률에서 규정하고 그 법적 근거 하에 가이드라인은 보다 구체적이고 세부적인 절차, 요건 등을 안내함으로써 현재 지나치게 가이드라인에 의존하고 있는 가명처리 관련 사항을 법령에 명문화할 필요가 있음을 강조하였다(법률신문, 2021.10.21.).

이석배(2021)는 장기적으로 개인정보보호법은 정보주체 권리 보호에 중점을 두고 활용은 예외적인 특별법으로 가는 것이 바람직하다고 제안하였다. 이기호·김계현(2020) 또한 일본의 차세대의료기반법과 같은 특별법 형태의 입법개선을 활용하여 보건의료 분야 데이터의 특성을 반영하고 안전한 데이터 활용을 규율할 수 있는 법적 근거기반 구축을 제안하였다. 김지희(2022: 459)는 보건의료 데이터 활용과 관련한 검토 대상 법률이 국내 법제에 이미 많은 상황이므로 별도의 법률을 추가로 제정하기보다, 국내 기존 법제의 틀 안에서 통일적으로 규율될 수 있도록 위임규정을 통한 개선이 바람직하다고 제시하였다.

제4절 해외 가이드라인과의 비교

보건의료 데이터 활용을 통한 새로운 가치창출의 잠재력을 인식한 각국은 보건의료 데이터를 안전하면서도 유용하게 활용할 수 있는 기반 구축을 위해 노력하고 있다. 그 중 미국, 일본, 영국은 보건의료 데이터 활용을 위해 어떠한 제도적 대응을 하고 있는지 알아보았다.

1. 미국⁹⁾

미국은 우리나라의 개인정보보호법이나 유럽의 GDPR(General Data Protection Regulation)과 같이 분야 상관없이 통합적으로 적용되는 개인정보 보호 법제는 없으며, 산업별 법제 및 규제·지침을 통해 개인정보 보호를 규정하고 있다.

보건의료 분야의 개인정보 보호 및 비식별화와 관련된 대표 법령은 1996년에 미국 연방정부에서 의료정보 보호에 관한 기본법으로 제정한 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act, 건강보험정보 이동 및 책임에 관한 법)가 있다. HIPAA는 일상적인 의료업무 목적으로 수집되는 개인건강정보의 목적 외 활용을 원칙적으로 금지하고 있지만, 보건의료 정보(데이터)의 활용을 위해 미국 보건복지부(Department of Health and Human Services)는 HIPAA의 위임을 받아 HIPAA 프라이버시 규칙(HIPAA Privacy Rule)과 HIPAA 보안 규칙(HIPAA Security Rule)을 제정하였다. 2002년 제정된 HIPAA 프라이버시 규칙은 개인 식별이 가능한 보호 의료정보(Protected Health Information, PHI)의 이용 및 공개 방법, 범위 등에 대한 조건을 정하고 있으며, 2003년 제정된 HIPAA 보안 규칙은 전자의료정보(ePHI)가 안전하게 보관 및 송수신될 수 있도록 행정적, 물리적, 기술적 보호장치를 마련할 것을 규정하고 있다.

비식별화 대상인 보호의료정보에 대해 HIPAA는 “HIPAA가 적용되는 의료기관, 지불기관, 의료 관련기관에서 생성·수집·전송·보관되는 (1) 개인의 과거, 현재, 미래의

9) 김재선(2021)의 내용을 바탕으로 정리함

물리적·정신적 건강 상태, (2) 개인에 대한 건강보험 규정, (3) 개인에 대한 의료비 지출상황 등에 관한 정보로서 개인이 식별되는 의료정보”로 정의하고 있다.¹⁰⁾ 이에 대해 HIPAA 프라이버시 규칙은 의료기관 등이 지정된 비식별조치 방식에 따라 비식별 조치가 가능하며, 비식별 조치 이후의 비식별 의료정보(De-identified Health Information, DHI)를 사용하거나 공개할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 데이터가 충분히 안전하게 비식별화 되었는지에 대한 판단이 중요하게 작용한다.

미국 HIPAA 프라이버시 규칙 제164.514(b)항은 두 가지 방식에 의해 보건의료 데이터가 비식별화된 것으로 판단할 수 있다고 정하고 있다. 전문가 판단방식(Expert determination method)은 사안별로 전문가가 판단하도록 하는 방식이고, 세이프하버 방식(Safe harbor method)은 HIPAA 프라이버시 규칙에서 나열한 18가지 식별자(identifiers) 또는 준식별자(quasi-identifiers)가 데이터에서 제거되면 비식별화된 것으로 간주하는 방식이다(김지희, 2022: 466).

HIPAA 프라이버시 규칙의 가이드라인(Office of Civil. Rights, 2012.11.26.)에 따르면, 전문가 판단방식은 익명화 조치가 이루어진 의료정보에 대해 ‘식별 가능성 또는 방법에 관하여 통계·과학 부분에 적절한 지식과 전문성을 갖춘 사람이 다른 정보와 결합하여 개인을 식별할 수 있는 리스크가 매우 작다고 판단하여야 하며, 문서로서 이유와 결과가 기록된 경우’에 비식별 조치가 이루어졌다고 판단할 수 있다. 이 과정에서 가이드라인은 전문가들이 주관적이고 모호한 판단을 내리지 않도록 판단 기준을 제시하여 객관성 확보를 꾀하고 있다. 전문가들은 가이드라인에서 제시한 복제가능성(replicability), 데이터 소스 활용가능성(data source availability), 구별가능성(distinguishability) 등을 기준으로 식별 위험성을 판단하게 되어 있다.

미국은 이외에도 의료정보의 의미 있는 활용(meaningful use) 목적이 인정되는 경우 의료정보의 공유 및 활용을 인정하는 HITECH법(Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act), 의약품·의료기기 등 의료 제품 개발의 혁신을 촉진하고 이를 환자들에게 효율적으로 제공하기 위해 연구자들

10) U.S. Department of Health and Human Services.(1996), Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA), Public Law 104-191; 김재선(2021), pp. 127~178에서 재인용.

이 국립보건원의 임상연구 데이터를 사용할 수 있도록 하는 21세기 치료법(21st Century Cures Act) 등의 제정을 통해 보건의로 데이터가 활용될 수 있는 기반을 만들고 있다.

이와 같이 미국은 개인의료정보에 관한 단일 법제(HIPAA)를 통해 보호와 활용 기준을 비교적 명확하게 규율하고 있으며 비식별 조치 방식, 비식별 및 재식별 가능성에 대한 전문가 판단 기준, 절차 등 실무적으로 참고 가능한 구체적 내용을 가이드라인에서 규정함으로써 비교적 간소하면서도 신뢰성을 갖춘 규제 체계를 갖추고 있다는 점이 특징이다. 또한 미국은 보건의로 분야에서 정보주체에 대한 고지 의무, 옵트아웃 제도, 삭제요구권 등을 규정하여 정보주체의 권리 보호 방안을 구체화하고 있다.

2. 일본¹¹⁾

일본은 2015년 개인정보보호법을 개정하면서 비식별화된 개인정보를 ‘익명가공정보’로 정의하고, 이에 대한 기술적·관리적 조치 의무 규정과 제3자 제공에 대한 정보주체의 동의를 면제하였다(한국인터넷진흥원, 2016). 하지만 동 개정법에서 의료정보는 일반적인 개인정보와 구분하기 위해 신설된 ‘배려를 요하는 개인정보’로 분류되어 ‘일정한 경우(법령에 의거한 경우 등)’를 제외하고 해당 정보의 수집 및 제3자 제공을 위해서는 반드시 정보주체 본인의 동의를 받아야 했다.

이와 같은 개인정보보호법 하에서의 의료 정보 활용의 한계를 극복하기 위해 일본은 특별법을 제정하였다. 대규모 의료데이터 수집·활용을 위한 기반 구축을 위해 2017년 제정된 ‘차세대의료기반법(의료 분야의 연구개발에 이바지하기 위한 익명가공의료정보에 관한 법률)’이 그것이다. 이 특별법의 제정을 통해 의료기관, 약국 등이 보유하고만 있었던 의료정보가 익명가공처리 등을 포함한 일정 요건 하에서 제3자 제공(공유)이 가능해지게 되었다.

차세대의료기반법에서는 보건의로 분야의 성질과 특성을 반영한 의료정보의 개념을 정의하고 있으며, 동법의 주요 특성은 국가에게 인증된 사업자만이 의료정보의 비식

11) 김상태(2022)의 내용을 바탕으로 정리함

별화를 수행할 수 있다는 것과 의료정보 활용에 대해 옵트아웃(opt-out) 절차를 채택했다는 것이다.

의료정보의 비식별화는 차세대의료기반법에 의해 주무대신¹²⁾으로부터 인증을 받은 사업자(익명가공의료정보작성사업자)만이 수행할 수 있으며, 그 사업자는 동법 시행규칙에서 정한 기준에 따라 비식별화를 수행해야 한다. 또한 의료정보 보유자(의료정보취급사업자)가 인증된 사업자에게 의료정보를 제공할 때는 사전에 정보주체에게 통지하고 주무대신에게 신고해야 한다. 만약 본인 또는 그 유족이 거부의 의사표현을 하지 않는다면 의료정보는 비식별화를 위해 인증된 사업자에게 제공될 수 있다(옵트아웃 방식). 인증된 사업자는 의료정보를 익명가공의료정보로 가공한 후 의료기관, 연구자 등의 의료정보 활용자(익명가공의료정보취급사업자)에게 제공할 수 있다.

차세대의료기반법과 시행령 및 시행규칙을 준수하기 위해 실무자들이 참고할 수 있도록 2018년 ‘차세대의료기반법 가이드라인’¹³⁾을 발표하였고, 지속적으로 개정되고 있다. 이 가이드라인에서는 익명가공의료정보의 유형별 정의, 비식별화 및 재식별화 가능성 판단 기준, 이용목적 및 이용형태 검토 기준, 기술적 비식별화 방법, 정보주체에 대한 통지 절차, 비식별화된 정보의 제공 계약 시 필요한 사항 등을 규정하고 있다.

일본의 차세대의료기반법은 익명화를 통해 개인의 의료정보를 보호하면서 활용성을 높일 수 있도록 생태계를 정비한 법률로 평가되며, 의료 분야의 비식별정보 활용과 관련한 다양한 사업자에 대해 행정기관이 사업 권리 부여, 감독, 행정제재 등의 일정한 행위를 할 수 있는 법적 근거가 되고 있다.

3. 영국

영국은 개인정보 비식별화에 대한 일반적 원칙으로 유럽연합의 GDPR(General Data Protection Regulation)을 따르고 있다. GDPR은 가명화를 통한 개인정보의

12) 일본 내각부, 문부과학성, 후생노동성, 경제산업성의 대신을 의미

13) 内閣府 外(2024.6), 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律についてのガイドライン(次世代医療基盤法ガイドライン), <https://www8.cao.go.jp/iryou/hourei/pdf/guide/ine.pdf>(검색일: 2024.9.20.)

비식별화 조치를 조건으로 특정 목적(과학, 역사, 통계)을 위해 데이터를 수집 및 이용할 수 있도록 하고 있다. 암호화 등을 통한 기술적 가명화 조치를 요구하고 있으며, 이를 통해 개인 식별이 불가능해진 경우에는 정보주체에 대한 통지의무가 면제된다(한국인터넷진흥원, 2016).

영국의 데이터보호법(Data Protection Act)은 GDPR을 국내법으로 수용한 법률로서, 개인정보 처리에 관한 일반적인 규율을 제공한다. 2018년 개정된 데이터보호법에서도 비식별화 조치와 관련하여 별도의 수정사항 없이 GDPR에서 규정한 비식별 조치 및 익명성에 대한 개념과 기준, 가명화의 개념 등을 그대로 따르고 있다(고학수 외, 2018).

심우민(2017)은 영국의 개인정보 비식별 조치에 관한 대응을 가이드라인을 통한 대응 방식으로 분류¹⁴⁾하였는데, 이에 해당되는 대표 가이드라인은 영국의 정보보호기관 ICO(Information Commissioner's Office)에서 발표한 '익명화 실천강령(Anonymisation: managing data protection risk code of practice, 2012)'이다. 이 강령에서는 개인정보의 익명화 방식과 익명화된 데이터를 공개할 경우의 위험성 평가에 대한 내용을 담고 있다. 법적 강제력은 없는 강령이지만 강령에서 규정한 내용을 준수하는 경우 개인정보보호 재식별 관련 조사나 법 집행 과정에서 우호적인 평가를 받을 수 있도록 했다(한국인터넷진흥원, 2016). 영국의 '익명화 실천강령'은 우리나라의 '개인정보 비식별 조치 가이드라인'과 유사한 성격을 가지지만 법적 근거 측면에서 차이가 있다. 영국의 강령은 GDPR 입법이유 26 및 본문 제27조에 명시적인 위임근거를 가지는 것으로서 규범적 근거가 명확하다고 볼 수 있지만, 우리나라의 가이드라인은 법률적 위임이 존재하지 않는 단지 행정지도로서의 성격을 가지기 때문이다(심우민, 2017: 40~41).

GDPR과 데이터보호법 하에서 가이드라인을 적극적으로 활용하는 영국도 보건의료 데이터의 활용과 관련해서는 개별법을 제정하였다. 2012년 보건 및 사회보장법(Health and Social Care Act 2012)은 영국 국립보건서비스(National Health Service, 이하 NHS)의 개혁을 위해 제정되었으며, 보건의료 데이터의 연계 및 활용을

14) 심우민(2017)은 한국과 영국은 가이드라인을 통한 대응방식, EU와 일본은 입법조치를 통한 대응방식으로 구별했다.

위한 기관 설립의 근거를 명시하고 있다(정현학·장보은, 2015). 영국은 국가가 전 국민에게 무료로 의료서비스를 제공하는 조세 기반 NHS 제도를 시행하고 있기 때문에 전 국민의 보건의료 정보는 NHS Digital이라는 기관에 집적된다.

NHS Digital은 의료정보의 수집 및 이용에 관한 독립된 권한을 가진 별도 기구로서 기능하며, 영국의 일반의들은 환자가 자신의 정보 제공을 반대하지 않는 한 환자의 개인정보 및 의료정보를 NHS Digital에 의무적으로 제공해야 한다(옵트아웃 제도). 제공된 보건의료 데이터는 NHS Digital에서 개인식별정보가 제거된 형태로 변형되어 제3자 및 일반에 제공 및 공개될 수 있도록 하고 있다. 다만, 이러한 제공 및 공개는 2014년 제정된 보살핌법(Care Act 2014)에 따라 ‘의료복지 서비스의 증진, 혹은 국민 건강 증진’ 목적으로 제한되어 연구, 신약개발, 치료방법 개발 이외의 상업적 목적을 위한 이용은 불가능하다(정현학·장보은, 2015).

NHS Digital은 보건·복지 연구 규정의 표준화된 규율을 관리하고 NHS Digital에 정책적 조언을 하는 자문기구 HRA(Health Research Authority)를 두고 있으며, HRA의 구성 및 기능은 보살핌법에 명시되어 있다.

미국, 일본, 영국의 사례로 살펴본 바와 같이 해외에서는 개인정보 분야 또는 보건의료 분야의 법령 및 시행규칙 수준에서 가명정보를 통한 개인 보건의료 데이터의 활용을 명시하고 있다. 미국은 개인의료정보에 관한 단일 법제를 통해 보호와 활용 기준을 비교적 명확하게 규율하고 있으며, 일본은 개인의료정보 활용을 제한하는 개인정보보호법의 한계를 극복하기 위해 특별법을 제정하여 보건의료 데이터 생태계 속 사업자들에게 권리와 책임을 부여하고 있다. 전 국민의 의료정보가 중앙에서 관리되는 구조의 영국은 보건의료 데이터 활용 전담기관의 역할과 의무를 법령에 명시하고 있다. 이와 같이 권리 및 의무, 처벌 및 제재가 명확한 법적 강제력을 바탕으로 미국, 일본, 영국은 옵트아웃 제도를 적용하면서 보건의료 데이터 활용의 실질적 편의성 제고를 꾀하고 있다.

반면 우리나라는 법적 근거 혹은 위임규정도 없이 법적 강제력이 없는 가이드라인에 명시되어, 보건의료 데이터의 활용 촉진이라는 취지뿐만 아니라 정보주체의 권리 보호 측면에서도 해외에 비해 제한적 권리를 보장하고 있다.

<표 3-2> 보건의료 데이터 활용 관련 주요 국가의 법제도 현황

		미국	일본	영국	한국
관련 법령	개인정보 분야	-	개인정보보호법	GDPR, Data Protection Act	개인정보보호법
	보건의료 분야	HIPAA, 21st Century Cures Act 등	차세대의료기반법	Health and Social Care Act 2012, Care Act 2014 등	보건의료 데이터 활용 가이드라인
보건의료 데이터의 정의		O	O	X	X
정보주체의 권리		접근권, 정정권, 삭제권 등	접근권, 동의권 등	접근권, 정정권, 삭제권 등	접근권, 정정권의 제한적 보장
특징		- 데이터 활용 허용 범위가 넓음(상업적 목적 포함) - 비식별화 판단에 대한 명확한 기준 제시	- 예방의학, 맞춤형의료 등 활용 범위가 비교적 넓음 - 인증사업자만 비식별화 처리 가능	- 상업적 목적으로 사용 불가	- 권고 수준의 가이드라인으로, 위반 시 제재 없음
법적 강제력		강함	강함	강함	약함

자료: 연구진 정리

제5절 소결: 좋은 가이드라인의 조건에 대한 시사점

보건의료 데이터 활용 가이드라인의 주요 한계로서 가장 많이 언급되는 것은 가이드라인이라는 수단 자체가 가지는 법적 한계이다. 일반적으로 가이드라인이란 행정기관이 일정 행정목적의 달성을 위해 필요한 기준과 절차를 정한 것으로 법적 구속력은 없는 행정지도의 일종으로 볼 수 있다. 즉 행정목적 달성을 위한 행동 유도 및 협력을 구하는 행정작용으로, 실질적 위법성의 평가기준이 될 수는 있으나 이를 따르지 않더라도 제재가 따르지 않는다는(김동희, 2017; 이기호·김계현, 2020, p. 107).

보건의료 데이터 활용 가이드라인은 현행 개인정보 보호 관련 법령의 해석 및 적용과 관련한 실무적 지침 또는 행정지도를 제시한 것으로 해석할 수 있다. 그러나 보건의료 데이터 활용 가이드라인의 근거로 명시된 개인정보보호법은 가명처리와 가명정보 처리 등에 대해 구체적으로 규정하지 않았고, 이를 하위 법령에 명시적으로 위임하지도 않았다. 따라서 보건의료 데이터 활용 가이드라인의 내용은 보호법에 명시하지 않는 이상 해석과 법적 효력이 문제되는 한계가 있다(신태섭, 2021). 법률에 근거 없는 의무를 부과할 수 없기 때문에 본 가이드라인의 내용은 개인정보처리자에 대한 권고 수준으로서만 기능할 수 있다(이석배, 2021).

전문가들은 보건의료 데이터 활용 가이드라인의 목적인 보건의료 분야 개인정보 처리자 및 연구자의 법적 안정성과 정보주체의 권익 보호를 위해서는 가이드라인의 법률화가 필요하다고 제언한다(이기호·김계현, 2020; 이석배, 2021; 이하영·최봉석, 2023; 법률신문, 2021.10.21.). 가명처리 방법의 기본 원칙에 대해서는 법률에서 규정하고 그 법적 근거 하에 가이드라인은 보다 구체적이고 세부적인 절차, 요건 등을 안내함으로써 현재 지나치게 가이드라인에 의존하고 있는 가명처리 관련 사항을 법령에 명문화할 필요가 있음을 강조하였다(법률신문, 2021.10.21.).

| 제4장 | [사례2] 비대면진료 가이드라인

제1절 우리나라의 비대면진료 추진 과정

1. 코로나19 팬데믹으로 전격적 비대면진료 실시

2019년 12월에 발생한 코로나 팬데믹으로 인해 그동안 시범사업의 형태로 추진되었던 원격의료와 감염병 위기 단계가 심각 단계로 상향 조정되면서 2020년 2월 24일 전화 상담과 처방을 할 수 있는 비대면진료라는 형태로 처음으로 현실화되었다(코로나바이러스감염증-19중앙사고수습본부, 2020.2.23). 2020년 12월 15일에는 감염병 예방법 개정으로 한시적 비대면진료에 대한 법적 근거가 마련되고 한시적 비대면진료의 제도화가 이루어졌고, 2022년 8월 4일에는 한시적 비대면진료의 개정이 이루어졌다. 비대면진료는 코로나19가 본격적으로 시작되었던 2020년 2월 24일부터 코로나19 감염증이 엔데믹 선언으로 이어졌던 2023년 5월 31일까지 한시적으로 운영되었다. 비대면진료는 코로나19의 폭발적 증가로 인해 발생할 수 있는 의료진의 감염에 따른 의료 공백을 최소화하기 위한 어쩔 수 없는 선택이었다고 할 수 있다. 2020년 2월부터 2023년 5월까지 비대면진료를 받았던 건수는 월평균 22만 2,404건, 이용자 수는 20만 1,838명이었으며, 비대면진료 시범사업이 실시된 2023년 6월에는 비대면 진료건수 15만 3,339건, 이용자 14만 373명, 7월에는 각각 13만 8,287건과 12만 7,360명이었다(김진숙, 2024.01: 17).

한시적 비대면진료 허용 안의 주요 내용은 다음과 같다(보건복지부 2020.12.15.). 코로나19 감염병 위기대응 심각단계의 위기경보 발령 기간 동안 의사의 의료적 판단에 따라 안전성이 확보된다고 판단되는 경우 전화 상담·처방을 실시하고 유·무선 전화, 화상통신을 활용한 상담 및 처방이 이루어졌다. 수가는 “가-1 외래환자” 진찰료를 산정하고, 의료 질 평가에 따른 지원금을 별도 산정할 수 있는 방식으로 이루어졌다. 처방전 발급은 의료기관에서 의사가 환자의 전화번호가 적힌 처방전을 팩스나 이메일 등으로 환자가 지정하는 약국에 발송하는 방식으로 이루어졌고, 의약품 조제와 함께 유선 및 서면을 통한 복약지도가 병행되었으며, 의약품 배달은 환자와 약사가 합의하

여 결정하였다. 2022년 8월 4일 한시적 비대면진료 허용방안 개정안에 의해 비대면 진료를 실시할 때 환자가 의료기관을 특정하여 진료를 요청하도록 하는 환자의 의료 기관 선택권에 대한 근거가 마련되었다(보건복지부 2022.8.4.).

〈표 4-1〉 한시적 비대면진료 허용방안

구분	내용
내용	의사의 의료적 판단에 따라 안전성이 확보된다고 판단되는 경우에는 전화 상담·처방 실시
적용 범위	유·무선 전화, 화상통신을 활용한 상담 및 처방 * 진료의 질을 보장하기 위하여 문자메시지, 메신저만을 이용한 진료는 불가
적용 기간	코로나19 감염병 위기대응 심각 단계의 위기경보 발령 기간
수가	가-1 외래환자 진찰료 산정(환자부담은 현행 외래본인부담률과 동일), 의료 질 평가 지원금 별도산정 가능 의원급(보건의료원 포함) 의료기관에서 한시적 비대면 진료시 전화상담 관리료 별도 산정(진찰료의 30%) 가능(환자 본인부담 면제) * 야간, 공휴, 심야, 토요, 소아 등 별도 가산 미적용
처방전 발급	의료기관에서 의사가 진료한 환자의 전화번호*를 포함하여 팩스 또는 이메일 등으로 환자가 지정하는 약국에 처방전 전송
의약품 수령	환자에게 복약지도(유선 및 서면) 후 의약품을 조제·교부(수령 방식은 환자와 약사가 협의하여 결정)

자료: 보건복지부(2020.12.14.), 「한시적 비대면 진료 허용방안 안내」.

비록 한시적이기는 하지만 비대면진료를 하기 위해서는 법적 근거가 필요했다. 2002년 개정된 「의료법」은 의사와 의사간의 원격 자문만을 허용하고 있을 뿐 원격 진료를 인정하고 있는 것은 아니었기 때문이다. 코로나19로 보건의료 비상 상황을 맞이한 정부는 「보건의료기본법」 제39조(주요 질병 관리체계의 확립)와 제40조(감염병의 예방 및 관리), 제44조(보건의료시범사업),¹⁵⁾ 「의료법」 제59조 제1항(지도와 명령),¹⁶⁾ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제4조(국가 및 지방자치단체의

15) 「보건의료기본법」 제39조(주요 질병 관리체계의 확립)는 “보건복지부 장관은 국민건강을 크게 위협하는 질병 중에서 국가가 특별히 관리하여야 할 필요가 있다고 인정되는 질병을 선정하고, 이를 관리하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다”, 제40조(감염병의 예방 및 관리)는 “국가와 지방자치단체는 감염병의 발생과 유행을 방지하고 감염병 환자에 대하여 적절한 보건의료를 제공하고 관리하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다”, 제44조(보건의료시범사업)는 “① 국가와 지방자치단체는 새로운 보건의료제도를 시행하기 위하여 필요하면 시범사업을 실시할 수 있다. ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 시범사업을 실시한 경우에는 그 결과를 평가하여 새로 시행될 보건의료제도에 반영하여야 한다.”라고 규정되어 있다.

16) 「의료법」 제59조 제1항(지도와 명령)는 “① 보건복지부 장관 또는 시·도지사는 보건의료정책을 위하여 필요하거나

책무)17)를 비대면진료의 법적 근거로 삼았다(김진숙 2024.01: 2). 그리고 2020년 12월 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제49조를 개정함으로써 원격의료의 한 형태인 비대면진료의 시행을 위한 법적 근거를 마련하였다. 신설된 조항인 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제49조의 3(의료인, 환자 및 의료기관 보호를 위한 한시적 비대면 진료)은 “① 의료업에 종사하는 의료인(의사·치과의사·한의사)은 감염병과 관련하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 심각 단계 이상의 위기경보가 발령된 때에는 환자, 의료인 및 의료기관 등을 감염의 위험에서 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 「의료법」 제33조제1항에도 불구하고 보건복지부장관이 정하는 범위에서 유선·무선·화상통신, 컴퓨터 등 정보통신기술을 활용하여 의료기관 외부에 있는 환자에게 건강 또는 질병의 지속적 관찰, 진단, 상담 및 처방을 할 수 있다. ② 보건복지부장관은 위원회의 심의를 거쳐 제1항에 따른 한시적 비대면진료의 지역, 기간 등 범위를 결정한다.”라고 규정되었다.

이처럼 코로나19로 인해 비대면진료의 법적 근거가 만들어짐으로써 우리는 원격의료와 관련하여 비대면진료와 원격의료를 혼용하여 사용해야 하는 상황에 봉착했다. 비대면진료는 앞서 본 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제49조의 3에 따라 “의료기관에 방문하지 않고 재택 등에서 컴퓨터나 화상통신과 같은 정보통신기술을 활용하여 의사에게 영상으로 진찰, 처방 등 의료서비스를 받는 것”을 의미한다. 원격의료는 「의료법」 제34조에 따르면 “컴퓨터·화상통신 등 정보통신기술을 활용하여 먼 곳에 있는 의사·치과의사·한의사 등 의료인에게 의료지식이나 기술을 지원하는” 것으로 정의되어 있다.18) 즉 현재의 의료법에서 얘기하는 원격의료의 범위는 의료인 간의 원격자

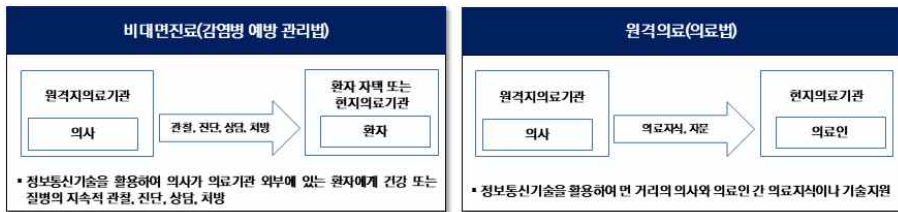
국민보건에 중대한 위해가 발생하거나 발생할 우려가 있으면 의료기관이나 의료인에게 필요한 지도와 명령을 할 수 있다”라고 규정되어 있다.

17) 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 감염병 환자 등의 인간으로서의 존엄과 가치를 존중하고 그 기본적 권리를 보호하며 법률에 따르지 아니하고는 취업 제한 등의 불이익을 주어서는 안된다. ② 국가 및 지방자치단체는 감염병의 예방 및 관리를 위하여 다음 각호의 사업을 수행하여야 한다.

18) 「의료법」 제34조(원격의료) ① 의료인(의료업에 종사하는 의사·치과의사·한의사만 해당한다)은 제33조제1항에도 불구하고 컴퓨터·화상통신 등 정보통신기술을 활용하여 먼 곳에 있는 의료인에게 의료지식이나 기술을 지원하는 원격의료(이하 “원격의료”라 한다)를 할 수 있다. ②원격의료를 행하거나 받으려는 자는 보건복지부령으로 정하는 시설과 장비를 갖추어야 한다. <개정 2008. 2. 29., 2010. 1. 18.> ③ 원격의료를 하는 자(이하 “원격지의사”라 한다)는 환자를 직접 대면하여 진료하는 경우와 같은 책임을 진다. ④원격지의사의 원격의료에 따라 의료행위를 한 의료인이 의사·치과의사 또는 한의사(이하 “현지의사”라 한다)인 경우에는 그 의료행위에 대하여 원격지의사의 과실을 인정할 만한 명백한 근거가 없으면 환자에 대한 책임은 제3항에도 불구하고 현지의사에게 있는 것으로 본다.

문을 의미할 뿐, 원격 모니터링, 원격 진료 및 처방 등을 의미하는 본래적 의미의 원격 의료와는 개념상 많은 차이가 있으며, 오히려 현재 시행되고 있는 비대면진료가 일반적으로 의미하는 원격의료의 개념에 훨씬 더 가깝다.¹⁹⁾ 이처럼 비대면진료와 원격의료는 그 정의나 법적 근거에서 많은 차이를 보이고 있다.

[그림 4-1] 비대면진료와 원격의료의 개념 비교



자료: 김유석 외(2022.5: 2)

2. 코로나19 엔데믹 이후 비대면진료 시범사업 추진

코로나의 위기경보 단계가 심각 단계에서 경계 단계로 하향 조정됨에 따라 2023년 6월 1일부터는 의료계의 반발을 무릅쓰고 「비대면진료 시범사업」이 전격 추진되었다. 2023년 8월 31일까지 3개월 동안의 계도기간을 설정하였고, 그 기간이 지난 후 2023년 9월 1일부터 비대면진료 시범사업이 본격 시행되었다. 그러나 코로나 위기 단계시 법적 근거로 활용되었던 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제49조의 3은 심각 단계 이상의 위기경보가 발령된 때에 한해서 비대면 진료에 가능하다고 규정되어 있기 때문에 비대면진료 시범사업은 의료법상 불법 행위가 되었다(김진숙, 2024.01: 3). 그렇지만 정부는 한시적 비대면진료 종료 이후 의료법 개정 등의 제도화 전까지 「보건의료기본법」 제44조에 근거한 시범사업 시행을 통해 제도 공백을 최소화하고 제한적 범

19) 2013년 보건복지부의 「동네 의원 중심의 의사-환자간 원격의료 추진방안」에서는 원격医료를 “의사 등 의료인이 IT를 이용하여 멀리 떨어져 있는 환자의 질병 관리, 진단, 처방 등 의료서비스를 제공”하는 것으로 정의하고 그 유형을 원격 자문, 원격 모니터링, 원격 진료의 3가지 형태로 구분하였다. 원격자문은 “원격지 의사가 멀리 떨어진 의료인의 의료 과정에 대해 지식이나 기술을 자문하는” 것이며, 원격모니터링은 “의료인이 환자의 질병 상태를 지속적으로 모니터링하고 상담·교육 등 관리하는” 것이며, 원격진료는 “의료인이 대면진료를 대체하여 원격으로 환자의 상태를 진단하고 처방전 발행 등 진료를 하는” 것으로 정의하고 있다.

위에서 비대면진료를 추진하고자 했다. 그리고 계도기간 동안 관련 기관의 의견을 수렴한 정부는 비대면진료 시범사업의 계도기간이 끝난 후 2023년 9월 1일 「비대면진료 시범사업 지침(개정안)」을 공고하였다. 이후에도 비대면진료 시범사업 지침은 2023년 12월 15일, 2024년 2월 23일, 2024년 4월 3일 등 3번 더 개정되었다.

<표 4-2> 비대면진료 시범사업 추진방안의 주요 내용

구분	시범사업 추진 방안(2023.6)			
실시기관 / 대상환자	의원급 의료기관	재진원칙	대면진료 경험자	• 해당 의료기관에서 해당 질환에 대해 1회 이상 대면 진료 경험 (만성질환자 1년 이내, 기타 질환 30일 이내)이 있는 환자 • 소아 환자(만 18세 미만)의 경우 대면진료 이후의 비대면 진료(재진) 원칙, 휴일·야간*에 한해 대면진료 기록이 없더라도 비대면 진료를 통한 의학적 상담은 가능(처방 불가) * (휴일) 공공서의 공휴일에 관한 규정에 의한 공휴일 (야간) 평일 18시(토요일은 13시) ~ 익일 09시
				초진도 허용
	병원급 의료기관	• 해당 의료기관에서 해당 질환에 대해 1회 이상 대면하여 진료한 경험이 있는 환자 중 희귀질환자(1년 이내), 수술·치료후지속적 관리(30일 이내)*가 필요한 환자 * 신체 부착된 의료기기의 작동상태 점검, 검사결과의 설명		
수가	의료기관	• 진찰료 + 비대면 진료 시범사업 관리료(진찰료의 30% 수준)		
	약국	• 약제비 + 비대면 조제 시범사업 관리료(약국관리료, 조제기본료, 복약 지도료의 30% 수준)		
실행방식	진료방식	• 화상진료 원칙, 예외적으로 (화상통신 사용이 곤란한 환자의 경우)음성전화 가능		
	처방전 전달	• 환자가 지정하는 약국으로 팩스·이메일 등 송부		
	의약품 수령	• 본인 수령, 대리 수령, 재택 수령* 등 환자와 약사가 협의하는 방법 * 심·박지 환자, 거동 불편자, 감염병 확진 환자, 희귀질환자에 한함		
실시기관 준수사항	① (본인 확인) 의료기관은 환자의 본인여부 및 비대면진료 허용대상여부 사전확인 후 진료 실시 ② (부적절한 비대면진료 행위 금지) 의료법 상 허가·신고된의료기관 내 진료실 등 비대면진료에 적합한 진료환경에서 실시 ③ (전담기관 운영 금지) 비대면진료만 실시하는 의료기관, 비대면조제만 실시하는 약국 운영 금지 ④ (처방 금지) 마약류, 오·남용 우려 의약품			

자료: 보건복지부(2023.6), 「비대면진료 시범사업 추진방안」.

비대면진료 시범사업에서 제시된 가이드라인은 의료기관용, 약국용, 중개 플랫폼용의 세 가지 버전으로 제시되었다. 의료기관용 지침에는 사업개요(목적, 근거, 추진체계 및 역할), 사업의 세부 내용(대상 환자 및 서비스 절차), 요양급여 비용 산정 및 청구

방법, 시범의료기관 준수사항 등이 포함되었다. 약국용 지침도 사업개요(목적, 근거, 추진체계 및 역할), 사업의 세부 내용(대상 환자 및 서비스 절차), 요양급여 비용 산정 및 청구 방법, 시범약국 준수사항 등으로 구성되었다. 중개 플랫폼용 지침은 정의 및 목적, 플랫폼의 의무, 플랫폼 업무 수행의 세부 준수사항 등을 다루었다.

비대면진료 시범사업 지침의 주요 내용과 개정안의 내용은 다음과 같다(보건복지부, 2023.6). 먼저 비대면진료의 3대 추진 원칙으로 ① 안전성 확보를 위한 대면 진료 중심 실시를 통한 국민건강 우선, ② 1차 의료기관인 의원급 의료기관 중심 실시를 통한 편의성 제고, ③ 의료기관 선택, 약국 지정 등 서비스 전반에 대한 환자 선택권 존중이 제시되었다.²⁰⁾ 참여범위는 제한적 시범사업의 형태로 이루어졌고, 실시기관으로는 의원급 의료기관이 원칙이고 병원급 의료기관이 예외적으로 허용되었다. 대상환자는 국민 건강 증진과 의료취약 계층의 접근성 제고에 중점을 두고 제한적으로 대상을 설정하고, 대상환자 중 의사가 의료적 판단에 따라 안전성이 확보된다고 판단되는 경우에 실시하는 것으로 하였다.

2023년 9월 1일 「비대면진료 시범사업 지침(개정안)」에서는 대상 환자 규정과 관련하여 거동불편자 중 장기요양등급 판정자에 만 65세 이상 나이 규정이 추가되었다. 2023년 12월 15일의 개정안에서는 비대면진료 대상 환자의 내용에 일부 변경이 있었다. 대면진료 경험자의 경우 질환 상관없이 동일 의료기관에서 6개월 이내 1회 이상 대면 진료 경험이 있는 자로 변경되었고, 의료 접근성이 낮은 경우 대면진료 경험이 없어도 비대면진료가 가능하게 되었다. 즉, 응급의료 취약지 98개 시·군·구가 추가되었다. 의사의 대면 진료 요구권도 명확해졌고 처방금지 의약품의 일부 변경 및 처방전 전송 방법에 있어서 의사가 환자 지정 약국으로 처방전 직접 전송이 가능하게 되었다. 2024년 2월 23일의 개정안에서는 의료법 제33조 관련 조항 신설을 통해 근거 조문을 추가하였고, 전체 의료기관에서 보건의료 위기상황에 진료가 필요한 환자의 비대면진료가 가능하도록 추가되었으며, 시범약국에서 비대면조제 관련 전담기관 예외 조항이 추가되었다. 2024년 4월 3일의 개정안에서는 보건의료 위기 상황에 진료가 필요한 경우 보건의료원, 보건소, 보건지소 등의 진료가 가능하도록 대상기관이 추가되었다.

20) 대한의사협회는 비대면진료 제도화를 위한 4대 원칙으로 “① 대면진료 원칙, 비대면진료는 보조 수단 ② 재진환자 중심 운영 ③ 의원급 의료기관 중심 운영 ④ 비대면 진료 전담기관 금지”를 제안하였다(김진숙, 2024.1: 9).

3. 비대면진료 시범사업의 성과와 한계

정부는 지난 3년 여간의 코로나19 위기 상황에서 추진되었던 한시적 비대면진료가 의료인·환자 등이 적극 활용하면서 국민 건강 증진에 크게 기여하였다는 판단 하에 국민의 의료 접근성 제고를 위해 비대면진료 시범사업을 추진하였다고 설명하고 있다. 김유석 외(2022.5)는 비록 짧은 기간 동안의 평가라는 한계를 갖지만, 코로나19 기간 동안 시행되었던 비대면진료 사업이 환자의 의료 접근성 및 편의성 제고, 당뇨병 등 만성질환자에 대한 주기적 모니터링 및 상시적 처방에 효과 확인 등의 긍정적 효과가 있었다고 평가하였다. 김은정(2022.01.30: 4)은 보건복지부와 대한의사협회의 의료 현안협의체 회의를 근거로 비대면진료에 대해 “의료계 내에서도 안전성과 유효성을 확보할 수 있는 모델에 대해 논의해야 할 시점임은 인정하고 있다”고 보고 있다.

그러나 비대면진료 시범사업의 한계에 대한 지적도 다수 나타나고 있다. 김진숙(2020)은 의학적 위험성이 높은 전화 상담 및 처방 허용으로 인한 의학적 안전성 무시, 의료 사고 시 의사의 법적 책임 등의 문제가 있음을 지적하였다. 김유석 외(2022.5)는 고령층의 비대면 진료 앱 이용 제약, 환자의 자기 부담금 상승 등의 문제와 더불어 비대면진료의 품질 개선을 위해 필요한 시설·장비 확보, 의료 데이터 활용 등의 문제도 있었다고 보고 있다. 김진숙·오수현(2024.6)은 비대면진료 시범사업의 추진 목적의 불명확성,²¹⁾ 초진 허용 및 전화 사용에 대한 엄격한 제한 부재 등으로 인한 비대면진료의 안전성 확보 어려움, 의료적 안전성 보다는 산업 진흥의 관점에서 비대면진료 접근 등의 문제를 지적하였다. 김진숙(2024.01)은 의사를 대상으로 비대면진료 시범사업에 대한 설문을 한 결과 시범사업에서 안전성에 대한 고려가 미흡하며, 초진부터 전화로 진행할 때 안전성 위협이 가장 높아진다고 지적하였다. 그 외에도 비대면재진료 중개플랫폼의 관리 강화 필요, 비대면진료와 관련한 행정적·법적 제도 개선의 필요성도 있음을 지적하고 있다. 김은정(2024.01.30)은 전화 상담으로 인한 오진의 위험성, 불법 사례에 대한 감독주체가 불명확하여 생긴 법적 책임/제도적 안전장치 부족 등의 문제가 있었음을 지적하고 있다.

21) 김진숙·오수현(2024.6)은 시범사업 추진 목적의 불명확성의 근거로 “시범사업을 통해 검증하고자 하는 효과 미제시, 엄격한 사전 설계 없이 전국민을 대상으로 추진, 시범사업의 모호한 시행기간” 등을 들고 있다.

제2절 비대면진료 관련 쟁점 사항

비대면진료와 관련한 쟁점 사항을 자세히 파악하기 위해서는 그동안 정부와 의료계 사이에서 이루어졌던 원격의료와 관련한 시범사업 추진 과정 및 의료법 개정 과정에서 나타난 이해관계의 대립을 이해할 필요가 있다. 이 과정에서 정부와 의료계간, 그 외 다양한 관련 주체 간에 첨예한 의견 대립이 나타나기 때문에 비대면진료 관련 쟁점 사항이 자연스레 도출된다.

1. 원격의료 시범사업²²⁾ 추진과정에서 나타난 주요 한계

우리나라에서 원격의료가 최초로 전면에 등장한 것은 주로 기술성에 초점을 맞추어 1988년 서울대학교병원과 연천보건소 간 진행된 원격영상진단 시범사업이다(김종엽·이관익, 2020: 221). 1990년에는 원격영상진단 시범사업은 서울대, 한림대, 경북대 등 3개 대학병원과 연천, 화천, 울진 등 3개 보건의료원간 시범사업으로 확대되었으나 전송속도 등의 기술적 문제로 중단되었고, 1994년에는 경북대와 전남대 등 2개 대학병원과 울진, 구례 등 의료취약지역의 보건의료원을 초고속 공중교환망으로 연결해서 원격의료 영상진단 및 원격문진 시범사업이 추진되었으나 이또한 당시의 기술수준, 법/제도 미흡 등의 이유로 활성화되지 못했다(류시원, 2005.8: 7-8).

1996년에는 의사-의료인간 원격의료, 즉 원격자문 형태의 치매환자 원격진료 시범사업이 서울대병원 치매센터에서 추진되었고, 2005년 현재는 치매협회로 이관되어 서울 북부 노인종합복지관에서 제한적으로 운영되고 있다(류시원, 2005.8: 8).

2002년 의료법 개정을 통해 의사-의료인간 원격의료가 허용되면서 그동안 축적된 기술 및 지식에 기초하여 공공분야 시범사업 등이 추진되었다.²³⁾ 1999년부터는 강원도 16개 보건소를 대상으로, 2003년에는 서울 강남구 보건소, 2004년에는 안산시 단원보건소에서 원격영상진료 시범사업이 실시되었는데, 주요 대상자는 공중보건의료

22) 지금까지 추진된 모든 원격의료 시범사업의 내용을 담고 있지 않으며, 관련 주요 내용 및 평가 의견을 쉽게 구할 수 있는 시범사업을 중심으로 작성하였음.

23) 2004년까지의 국내 원격의료 추진실적에 대한 내용은 류시원 외(2004.12)의 부록 4. 1988-2004년간 국내 원격의료 추진 실적 참조(원전은 김인숙(2000.9), 「원격진료: 간호예의 응용」, 『간호학탐구』 9권 1호)

대상자와 고혈압 및 당뇨병 환자 등 만성질환자이며, 의료영상 데이터를 송수신할 수 있는 원격진료시스템과 보조적 장치를 사용하였다.²⁴⁾ 이용환자의 만족도, 치료 순응도 등은 높았으나 다른 시범사업과 마찬가지로 구축된 원격의료시스템의 낮은 품질 수준, 원격지 의료인의 참여 부족 등의 문제점이 나타났다(류시원 외, 2004.12).

〈표 4-3〉 원격의료 시범사업 주요 추진 과정

연도	주요 내용
1988	서울대학교병원과 연천보건소 간 진행된 원격영상진단 시범사업
1990	3개 대학병원(서울대, 한림대, 경북대) 및 3개 보건의료원(연천, 화천, 울진)간 원격의료 시범사업
1994	2개 대학병원(경북대, 전남대)과 의료취약지역의 보건의료원간 원격의료 영상진단 및 원격문진 시범사업
1996	치매환자 원격진료 시범사업(서울대병원 치매센터)(의사-의료인간 원격의료 시범사업)
1997	삼성의료원이 강북삼성병원, 마산삼성병원, 삼성제일병원을 연계한 원격의료시스템 구축
1999	강원도 16개 시·군 보건진료소 대상 원격의료 시범사업
2002	의료법 개정을 통해 의사-의료인간 원격의료 허용 월드컵 경기장 원격응급진료 서비스 시행(세브란스병원)
2003	서울 강남구보건소 단원보건소 원격영상진료 추진
2004	안산시 단원보건소 원격영상진료 추진
2006	의사-환자간 원격의료 시범사업 실시
2010	산업부, 스마트케어 서비스 시범사업(만성질환자 원격 모니터링 및 진료 서비스)
2015	의료취약지 의료지원 시범사업 추진(원격협진 네트워크 시범사업)
2018	정부, 원격의료 단계적 추진 입법 발표: 군부대, 원양어선, 교정시설, 의료인이 없는 도서벽지 등 4개 유형에 대해서 의사-환자간 원격 의료 도입
2019	강원도 디지털 헬스케어 규제특구 지정, 원격의료 허용
2020	정부, 코로나19로 전화상담·처방 및 대리처방 한시적 허용(2월)

자료: 김종엽·이관익(2020), 류시원(2005.8), 이준명·곽동철(2020.9) 등에 의거하여 작성

2010년에는 만성질환자에 대한 원격서비스인 스마트케어 서비스 시범사업이 추진되었다. 산업부는 2013년 지난 3년간 시행된 스마트케어 시범사업이 만성질환 재진 환자를 대상으로 한 원격의료서비스 제공을 통해 단순 약물 복용 환자에 비해 치료효과가 있었고 향후 만성질환 관리에 효율적일 수 있다고 결론지었으나, 대한의원협회는 만성질환자 규모 감소에 따른 자료 누락, 부실한 성과 측정과 사업평가 등의 문제

24) 그 외에도 농어민, 도서지역주민, 시설수용자 등을 대상으로 하여 전남 곡성, 부산 등에서도 원격의료의 시점적으로 실시되었다(류시원 외, 2004.12: 73)

를 제기하였다.²⁵⁾ 김종엽·이관익(2020)은 스마트케어 서비스 시범사업에 대한 효과 실증을 통해 의미 있는 비대면진료 서비스가 좀더 효과적이기 위해서는 비대면 의료 서비스 모형 개발과 의료전문가의 적극적 참여, 적절한 비대면의료 거버넌스가 필요함을 지적하였다.

2015년에는 의료취약지 의료지원 시범사업이 추진되었다. 대상자는 경증·만성질환을 가진 의료취약지·취약계층 주민으로 의사-의료인간 원격 모니터링·진료가 이루어졌다. 사업은 보건복지부와 과학기술정보통신부 2개 부처에서 수행되었는데, 보건복지부는 강원, 충남, 경북, 경남, 경기에서 과학기술정보통신부는 전남, 인천에서 각각 원격모니터링 및 원격 진료 사업을 추진했다. 가톨릭대학교 산학협력단(2023.11)이 수행한 성과분석에 따르면 혈압 이외의 항목에 대한 원격협진의 효과 확인이 어려우며 고혈압의 경우 원격협진을 통해 효과적 관리가 될 수 있다고 보았다. 그리고 효율적 원격 협진을 위한 명확한 대상자 의료취약지 및 대상자 선정, 데이터의 관리, 수익 구조 보장을 위한 수가체계 및 인센티브, 원격협진 가이드라인의 필요성 등을 강조하였다. 2018년에는 정부가 의사-환자 간 원격의료를 군부대, 원양어선, 교정시설, 의료인이 없는 도서벽지 등 4개 유형에 대해서 제한적으로 허용했다.

지금까지 추진되었던 국내의 시범사업은 당시의 기술적 수준, 불충분한 수요 파악, 의료사고에 대한 책임 소재, 수가, 의료인의 자격 등과 관련한 법과 제도의 미비, 의료기관의 저조한 참여 및 이해관계자의 참여한 반대 등으로 활성화되지 못했고(류시원, 2005.8), 그 유효성, 안전성도 충분히 검증하지 못했다고 할 수 있다(이준명·곽동철, 2020.9: 20). 이처럼 원격의료 시범사업 추진과 관련하여 나타났던 문제점들을 살펴보면 크게 효과적인 의료전달체계와 관련된 의료 접근성의 문제²⁶⁾, 영상장비 및 전송 등 기술적 안전성과 의료품질의 문제, 병원의 경우 원격진단 장비 구입 비용부담의 문제와 의료 수가 문제, 개인정보 보호와 관련된 문제, 의료 사고가 발생한 경우 의사의 법적 책임과 관련한 문제 등으로 요약될 수 있다.

25) 최선(2013.11.13.), 「스마트케어 시범사업은 '실패'...추진 근거 반박」, 『Medical Times』.

26) “대면진료와 효과 차이 없고 환자 만족도 높아 법 정비와 인프라 확장 필요, 강원도의 경우 산간 오지가 많아 의료접근성이 떨어지는 문제가 크고 통신기술의 발전에도 불구하고 인프라는 과거 그대로 사용하는 등의 문제가 있고, 디지털 보급률과 디지털 문해력의 문제도 제기” 고종관(2024.08.12.), 「20년 전 시작한 강원도 원격치매진료 아직도 제자리 걸음」, 『더메디컬』 기획기사.

2. 원격의료 도입을 위한 의료법 개정 논의의 주요 쟁점

2002년 의료법 개정을 통해 원격 모니터링, 원격 자문, 원격 진료 등으로 구성되는 원격의료 중 의료인 간의 원격자문만을 허용한 정부는 그 이후 원격모니터링, 원격 진료 등을 포함하는 일반적 의미의 원격의료를 추진하고자 2010년, 2014년 및 2016년 3번에 걸친 개정안을 국회에 제출한 바 있으나 의료계를 비롯한 이해당사자의 강력한 반발에 부딪혀 의료법 개정을 끝내 이루지 못하고 모두 국회의 임기만료로 폐기되었다. 이러한 의료법 개정안 발의는 정부 차원에서만 이루어진 것은 아니었다. 17대 국회(2004-2008)에서는 박찬숙 의원, 19대 국회(2012-2016)에서는 심재철 의원, 20대 국회(2016-2020)에서는 유기준 의원, 21대 국회(2020-2024)에서는 강병원 의원, 최혜영 의원, 이종성 의원, 신현영 의원, 김성원 의원 등의 의료법 개정안 대표 발의가 이루어졌다. 그러나 의원들의 개정 법률안도 정부 발의안과 마찬가지로 임기만료로 모두 폐기되었다.²⁷⁾ 22대 국회(2024-2028) 국회에 들어서 는 아직 원격의료와 관련한 의원 발의는 이루어지지 않았다.

<표 4-4> 의료법 개정 주요 추진 과정

주체	연도	주요 내용
정부	2002	의료법 개정 제34조 원격의료 관련 규정 마련
	2010	정부 의료법 일부 개정안 제출(의안번호 1808132)
	2014	정부 의료법 일부 개정안 제출(의안번호 1909995)
	2016	정부 의료법 일부 개정안 제출(의안번호 2000397)
국회	2007	박찬숙 의원 의료법 일부 개정 법률안 대표 발의(의안번호 177383)
	2013	심재철 의원 의료법 일부 개정 법률안 대표 발의(의안번호 1905383)
	2018	유기준 의원 의료법 일부 개정 법률안 대표 발의(의안번호 2011704)
	2021	강병원 의원 의료법 일부 개정 법률안 대표 발의(의안번호 2112756)
	2021	최혜영 의원 의료법 일부 개정 법률안 대표 발의(의안번호 2112870)
	2022	이종성 의원 의료법 일부 개정 법률안 대표 발의(의안번호 2118012)
	2023	신현영 의원 의료법 일부 개정 법률안 대표 발의(의안번호 2120760, 2121007)
	2023	김성원 의원 의료법 일부 개정 법률안 대표 발의(의안번호 2121133)

자료: 임지연·김진숙(2022), 김진숙(2024.01), 김명수·김근주(2024.3)에 의거하여 작성

27) 의료법 개정안의 주요 논의 과정은 김민아·이경애(2018), 김진숙·임지연·강주현(2022.4), 김진숙(2024.1) 참조.

가. 정부 의료법 개정안의 주요 내용

정부는 2010년 의료인 단체에 대한 불필요한 신고제도 폐지, 의료인과 환자 간 원격의료 허용, 의료법인 부대사업 범위 확대 등 규제완화를 통한 의료서비스 산업의 경쟁력 제고를 위해 의료법 일부 개정안을 발의했다. 특히 원격의료와 관련해서는 의료 접근성 제고와 의료 산업 육성을 위해 원격지 환자에 대한 직접 진료 허용, 도서·벽지 환자에 대해 영상통신 등을 활용한 의료행위 허용 등의 내용을 담았다.

정부의 2014년 의료기술 및 정보통신기술의 발전으로 의료기관 외부에 있는 환자에 대하여 의료서비스를 제공하는 원격의료서비스가 가능하여짐에 따라, 의료기관을 자유롭게 이용하는 데 어려움이 있는 도서벽지에 사는 사람 등에게 원격의료를 실시할 수 있도록 함으로써 의료 사각지대를 해소하고 국민편의 증진과 의료산업 발전을 도모하고자 의료법 개정안을 다시 발의하였다. 발의안의 주요 내용은 섬·벽지 거주자, 거동 어려운 노인 또는 장애인 등 원격의료 대상의 확대, 원격의료 실시기관의 신고, 원격의료 대상 환자 및 의료기관, 원격의료 실시 시 준수사항, 원격의료 시범사업 등의 내용을 담았다. 정부가 2016년도에 발의한 의료법 개정안은 2014년에 발의한 정부의 의료법 개정안의 내용에서 원격의료 시범사업만 제외했다.

나. 의원 발의 의료법 개정안의 주요 내용

박찬숙 의원과 심재철 의원의 안은 모두 제34조에 “의료인 간에 이루어지는 원격의료의 범위를 확대하여 지역적으로 고립되거나 거동이 불편한 환자인 경우 의료인이 직접 방문하여 이동형 전자장비를 통해서 원격지의사가 제공하는 전자처방전이나 의료정보를 환자에게 전달할 수 있도록 한다”라는 단서를 신설했다. 유기준 의원의 안에서는 도서벽지, 해상 선원, 거동이 어려운 노인 또는 장애인 등으로 원격의료의 범위 확대(제34조제1항), 원격의료 실시기관의 신고제도 마련(제34조제2항 및 같은 조 제5항 제2호), 원격의료 대상 환자는 재진환자나 경증 환자, 만성질환자, 도서벽지 거주자 및 노인·장애인 등은 의료급 의원기관, 수술 후 신체에 부착된 의료기기의 작동상태 점검 등 지속적인 관리가 필요한 환자, 교정시설 수용자 또는 군인 등 의료기관 이용

이 제한되는 환자는 의원급 의료기관과 병원급 의료기관이 함께 원격의료를 할 수 있도록 하는 등 원격의료 대상 환자 및 소관 의료기관의 범위 설정(제34조제3항 및 제4항), 원격의료 실시에 따른 준수사항(제34조 제5항) 등이 마련되었다.

<표 4-5> 정부 의료법 개정안의 주요 내용: 2014년의 개정안을 중심으로

구분		정부 개정 법률안의 주요 내용
대면진료 원칙		•없음
진료 형태	초·재진 여부	• 의학적으로 위험성이 낮다고 인정되는 재진환자
	주기적 대면진료	• 같은 환자에 대하여 연속적으로 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 주기적으로 대면진료 의무
제공방법		• 없음
대상환자		• 의료기관 이용이 어려운 다음 해당 환자: 도서벽지 거주자 등 원격지 환자, 교정시설 수용자, 군인 등 의료기관 이용이 제한되는 자, 대통령령으로 정하는 경증 질환을 가진 자, 대면 진료가 불가능한 예외적 경우, 거동이 어려운 노인 또는 장애인, 성폭력 및 가정폭력 피해자 중 의료인의 진료가 필요한 환자
제공주체		• 수술치료 후 지속적 관리 필요 환자, 교정시설 수용자, 군인 등만 병원급 의료기관 가능
비대면전담 금지, 횡수 제한		• 원격의료만 하는 전담의료기관 운영 금지
허용 질환		• 장기간 진료가 필요한 고혈압·당뇨병 등의 만성질환자와 정신질환자
제공의료 서비스형태		• 지속적 관찰 • 상담·교육 • 진단 및 처방
약 처방 배송	약 처방	• 없음
	배송	• 약사법 사안
수가		• 향후 고시로 결정
법적 책임 조새	면책 사유 입법	• 면책 사유 입법 필요성, 환자가 원격지 의사의 지시를 따르지 아니한 경우 • 환자가 갖춘 장비의 결함으로 인한 경우 • 원격지 의사의 과실을 인정할 만한 명백한 근거가 없는 경우
	전문인 배상책임	• 없음

자료: 김진숙·임지연·강주현(2022.12)

21대(2020-2024) 국회에서 발의된 강병원, 최혜형, 이종성, 신현영, 김성원 의원 등의 의료법 개정안 주요 내용을 비교하면 다음 표와 같다. 대부분의 의원 발의안의 경우 정부안에는 없는 대면진료 원칙을 강조하고 있으며, 진료형태 면에서는 의학적으로 위험성이 낮다고 인정되거나 장기간의 진료가 필요한 환자에 대한 재진환자를 대상으로 주기적 대면진료 의무가 있음을 강조하고 있다. 일부 의원안의 경우에는 진료대상 환자에 대한 지정이 이루어지는 경우 초진도 허용하고 있다. 제공방법은 컴퓨

터·화상통신 등 정보통신기술을 활용하는 방법이 제시되고 제공주체는 의원급 의료기관이 중심(필요 시 병원급도 가능)이라고 규정하고 있다. 그리고 일부 의원안의 경우 정부안과 마찬가지로 원격의료 전담금지를 규정하고 있으며, 허용질환은 대부분 상시적이고 지속적인 관리가 필요한 만성질환에 초점을 맞추고 있다. 그리고 대부분의 안이 제공의료의 형태는 원격 모니터링을 의미하는 지속적 관찰, 상담·교육 등의 원격자문, 그리고 원격 진료인 진단 및 처방을 담고 있다. 특히 법적 책임 소재와 관련하여서는 대부분 면책사유 입법의 필요성을 제시하고 있으며 그 내용 또한 환자가 의료인의 지시를 제대로 이행하지 않거나 고의적 또는 중대 과실로 인한 제대로 된 환자 정보 제공 미흡, 통신장애 등의 사유의 경우 면책이 필요하다는 등 큰 이견은 없다.

다. 의료법 개정 정부안과 의원안 비교

2014년과 2016년 제출되었던 정부안과 21대 국회에서 제출되었던 의원안의 주요 내용을 비교할 때 가장 큰 차이는 대면진료 원칙이다. 대부분의 의원안의 경우 원격진료는 대면진료의 보조적 방법이라는 대면진료 원칙을 내세우고 있으나 정부안에서 대면진료 원칙은 보이지 않는다. 그러나 초·재진 여부의 진료형태에서 정부안이 의학적으로 위험성이 낮다고 인정되는 재진환자를 대상으로 하고 있다는 점에서 정부안도 명시적이지는 않지만 암묵적으로 대면진료를 원칙으로 한다고 볼 수 있다. 원격의료 제공방법과 관련하여서 의원안의 경우 유선·무선·화상 통신·컴퓨터 등 정보통신기술 활용 등이 나타나 정부안에서는 보이지 않는다. 다만 최근 이루어진 비대면진료 시범사업 추진방안에서는 화상진료를 원칙으로 하나 예외적으로 화상통신 사용이 곤란한 환자는 음성전화도 가능하다고 규정하고 있다. 대상환자의 경우 정부안이 가장 포괄적이나 이종성 의원안의 경우 환자의 요청이 먼저 있을 때 의료인이 안전성을 인정하는 경우라는 단서 조항을 달고 있는 점이 특징이라고 할 수 있다. 배상책임과 관련하여서 정부안에는 없는데, 의원안에서 불각항력적 사유에 의한 의료사고인 경우 국가와 지방자치단체의 피해 보상 규정이 있는 점도 특징이라 할 수 있다.²⁸⁾

28) 법적 쟁점을 둘러싼 논의는 윤효영(2021.3), 임지연·김진숙(2022), 법제처 법제조정법제관실(2023.6), 김민우(2024.01), 김명수·김근주(2024.3) 등을 참조.

<표 4-6> 의료법 개정 의원 발의안의 주요 내용 검토: 21대 국회(1)

구분		최혜영 의원(2021)	이종성 의원(2022)
대면진료 원칙		• 대면진료 원칙 규정	• 대면진료 원칙 규정
진료 형태	초·재진 여부	• 초진 허용(대상환자 지정) • 1회 이상 대면진료 환자 - 고혈압·당뇨병 등 만성질환자, 정신질환자 - 수술·치료를 받은 후 신체에 부착된 의료기 기의 작동상태 점검 또는 육상 관찰, 중증· 희귀난치질환 등 지속적 관리가 필요한 자	• 초진 허용(대상환자 지정) • 재진(비대면 진료를 실시하는 의료인이 해당 환자에 대하여 동일 상법으로 1회 이상 대면 진료 한 경우) - 상시적이고 지속적인 관리가 필요한 만성질환 자 및 정신질환자
	주기적 대면진료	• 주기적 대면진료 의무	• 주기적 대면진료 의무
제공방법		• 컴퓨터·화상 통신 등 정보통신기술 활용	• 컴퓨터·화상 통신 등 정보통신기술을 활용
대상환자		• 도서벽지 거주자 • 교정시설 수용자, 군인 등 의료기관 이용이 제한되는 자 • 처방전 대리 수령이 가능한 자 • 해당 의료인이 1회 이상 대면진료한 환자로 주기적 대면진료를 전제로 해당의료인이 원 격진료가 필요하다고 인정한 자	• 환자 요청이 있을 때 안전성을 인정하는 경우 • 도서벽지 등 거주자(보건복지부령) • 국외거주, 장애인 또는 교정시설 수용자, 군인 등 의료기관 방문이 어려운 자(보건복지부령) • 타인의 감염 보호를 위해 의료기관 내원 제한 이 필요한 감염병 환자 • 만성질환자/정신질환자 • 그외 비대면진료가 필요한 환자(보건복지부령)
제공주체		• 의원급 의료기관 한정 • 병원급 의료기관 진료가 필요하다고 보건복 지부령으로 정한 환자	• 의원급 의료기관 • 보건복지부령으로 병원급 의료기관 진료가 필 요하다고 인정하는 경우
비대면 전담 금지 및 횡수 제한		• 비대면 전담 의료기관 금지 • 적정 처방일수 권고	• 없음
허용 질환		• 1회 이상 대면진료를 한 다음 환자 - 고혈압·당뇨병 등 보건복지부 지정 만성질환 자와 정신질환자	• 상시적, 지속적 관리 필요 만성질환자와 정신 질환자(해당 의료인이 환자에 대해 1회 이상 대면진료한 경우)
제공의료 서비스형태		• 지속적 관찰, 상담·교육 • 진단 및 처방	• 지속적 관찰 및 상담·지도 • 진단 및 처방
약 처방 배송	약 처방	• 없음	• 환자지정약국에 환자요청에 따라 처방전 발송 • 마약류 등 처방금지
	배송	• 약사법 시안	• 약사법 시안
수가		• 향후 고시로 결정	• 향후 고시로 결정
법적 책임 조세	면책 사유 입법	• 면책 사유 입법 필요성 • 환자가 의료인의 지시 이행하지 않은 경우 • 통신 오류, 환자 이용 장비 결함인 경우 • 환자가 고의 또는 중대과실로 본인 정보를 제대로 제공하지 않은 경우 • 그밖에 의료인의 명백한 과실을 인정할 만한 근거가 없는 경우	• 면책 사유 입법 필요성(조건: 의료인이 비대 면진료 중 해당여부를 인지하지 못한 경우) • 통신 오류, 환자 이용 장비 결함인 경우 • 환자가 고의 또는 중대과실로 정보를 제대로 제공하지 않은 경우 • 의료인의 명백한 과실을 인정할 만한 근거가 없는 경우
	전문인 배상책임	• 없음. 단, 불가항력적 사유에 의한 의료사고인 경우 국가와 지방자치단체에서 피해보상에 대 한 일부 또는 전부를 예산범위 내에서 지원	• 없음
환자 확인		• 없음	• 없음
환자 설명		• 없음	• 없음
시설장비		• 없음	• 없음

<표 4-6> 의료법 개정 의원 발의안의 주요 내용 검토: 21대 국회(2)

구분		강병원 의원(2021)	신현영 의원(2023)	김성원 의원(2023)
대면진료 원칙		• 원격의료는 대면진료의 보조적 방법	• 없음	• 대면진료 원칙 규정
진료 형태	초·재진 여부	• 정기간 진료가 필요한 고혈압, 당뇨, 부정맥 등의 재진환자	• 1회 이상 대면진료 환자	• 1회 이상 대면진료 환자(보건복지부령으로 정하는 만성질환자와 정신질환자)
	주기적 대면진료	• 없음	• 없음	• 없음
제공방법		• 없음	• 유선·무선·화상 통신·컴퓨터 등 정보통신기술 활용	• 컴퓨터·화상 통신 등 정보통신기술을 활용
대상환자		• 재진환자 - 고혈압·당뇨·부정맥·보건복지부 장관이 필요하다고 인정하는 질환	• 1회 이상 대면진료 환자	• 환자의 건강에 위해를 발생시키지 않으면서 의료접근성을 증진시킬 수 있는 경우에 한해 보건복지부령으로 정하는 환자 • 다음 환자는 비대면진료 중단, 대면진료 권고 - 추가적 검사 필요한 경우, 진찰받은 환자가 환자 본인이 아니라고 의심되는 경우, 처방제한 의약품 요구 경우, 그밖에 대면진료 필요 경우
제공주체		• 의원급 의료기관 한정	• 없음	• 의원급 의료기관 • 환자의 의료기관 이용이 제한되는 지역 거주 경우 병원급 의료기관 가능(보건복지부령)
비대면 전담 금지 및 횡수 제한		• 없음	• 비대면 전담 금지 • 비대면 진료 중개 규제	• 비대면진료 정보제공업자 규정 신설
허용 질환		• 다음 해당 재진환자 - 고혈압·당뇨·부정맥·복지부장관 정한 질환	• 없음	• 보건복지부령으로 정하는 만성질환자와 정신질환자
제공의료 서비스형태		• 재진환자 대상 관찰 • 상담 등 원격모니터링	• 지속적 관찰, 상담, 교육, 진단 및 처방	• 지속적 관찰, 상담, 진단 및 처방
약 처방	약 처방	• 없음	• 없음	• 마약류 처방 금지
	배송	• 약사법 시안	• 없음	
수가		• 향후 고시로 결정	• 없음	
법적 책임 조세	면책 사유 입법	• 면책 사유 입법 필요성 • 환자가 원격지에서의 지시를 따르지 않은 경우 • 환자가 갖춘 장비의 결함으로 인한 경우	• 없음	• 면책 사유 입법 필요성(조건: 의료인이 비대면진료 중 해당여부를 인지하지 못한 경우) • 의사지시를 따르지 아니한 경우 • 통신 오류, 환자 이용 장비의 결함인 경우 • 환자가 고의 또는 중대과실로 정보를 제대로 제공하지 않은 경우 • 그밖에 의료인의 명백한 과실을 인정할 만한 근거가 없는 경우
	전문인 배상책임	• 없음	• 없음	
환자 확인		• 없음	• 환자 본인 여부 확인	
환자 설명		• 없음	• 없음	• 비대면진료의 특성 및 대면진료와 차이 • 대면진료 권고 경우 • 비대면진료 환자 준수 사항 • 그밖에 보건복지부령 규정
시설장비				

자료: 김진숙·임지연·강주현(2022.12)의 부록 2의 내용에 신현영, 김성원 의원의 안 및 환자 확인·설명 등을 추가

제3절 국내외 주요 가이드라인 비교

1. 대한내과의사회 비대면진료 시범사업 가이드라인

대한내과의사회는 정부의 비대면진료 시범사업 추진에 앞선 2023년 5월 22일 원격의료TF위원회가 마련한 비대면진료 시범사업 가이드라인을 발표했다. 그리고 제안 사항이 6월부터 실시될 비대면진료 시범사업에 적용되어야 한다고 주장했다. 가이드라인을 보면 제도 시행의 전제 조건으로 ① 비대면 진료는 대면 진찰이 생략된 진료로 인한 오진의 위험성이 높기 때문에 대면 진료의 보조적 수단 ② 제도 시행에 앞서 한 시적 비대면 진료에 대한 철저한 검증 필요 ③ 민간 플랫폼이 주도하는 산업적 측면보다 국민의 건강과 안전 우선시 ④ 비대면 진료에 대한 법적, 제도적 정비 완결 후 시행 ⑤ 해외처럼 비대면 진료의 정책 수립 및 조정과정에서 의사단체 중심 등을 내걸었다. 특히 비대면 진료 시범사업은 섬, 산간벽지, 군부대, 교정시설 등 의료 취약지와 중증 장애인 등 거동이 불가능한 의료취약계층을 대상으로 우선 시행하고 평가위원회에서 평가, 검증 이후 전국으로 확대 시행돼야 한다고 강조했다.

진료지침을 보면 진료 개시의 조건, 진료 형태, 허용질환, 제공의료 서비스, 환자 위치/제공주체, 진료 주기 및 횟수, 비대면진료 전담금지, 수가, 플랫폼, 법적 책임소재, 개인정보, 사후 평가 등 12가지 항목에 대한 대한내과의사회의 의견을 담았다. 비대면 진료는 의사가 환자에게 그 장단점 및 위험성을 충분히 설명한 후 환자의 동의를 얻어 실시하고, 의사와 환자간 신뢰가 없는 경우 오진의 가능성이 있어 재진 환자만 대상이 되어야 하며 화상 또는 디지털 기기 사용이 미숙한 고령층을 위한 전화통화 방식의 진료가 제공되어야 한다고 했다. 비대면진료가 가능한 질환은 만성질환으로 제한하고 그 범위는 전문가단체의 논의 후 추가할 수 있으며, 진료를 통해 제공하는 의료서비스는 만성질환 관리에 대한 교육·상담, 진단 및 처방이며, 약 처방의 범위는 재진 진료와 관련한 처방 약으로 한정하며, 3회 이상 같은 질병으로 대면 진료를 받은 환자만 비대면 진료를 받되 2회 연속은 불가능하며 비대면 진료 건강보험 적용 횟수도 제한할 필요가 있다고 했다.

<표 4-7> 대한내과의사회 비대면진료 시범사업 가이드라인

진료 지침	주요 내용
진료 개시 조건	• 대면진료와 마찬가지로 의사-환자간 신뢰 중요, 의사와 환자가 사전에 서로 아는 관계 • 의사는 환자에게 비대면진료에 대해 설명하고 동의를 얻은 후 진료 시작 • 의사와 환자간의 신분확인 완료 후 비대면진료, 신분 확인방법은 별도규정으로 명시
진료 형태	• 의사와 환자간 신뢰 없는 경우 오진 위험성이 높아 초진 절대 불가 / 재진 환자만 가능 • 진료제공 방법은 화상 또는 고품질의 경우 디지털 기기 사용 미숙으로 인해 전화 통화 허용
허용 질환	• 진료 가능 질환은 만성질환, 만성질환의 범위는 전문가단체가 논의하여 추가 • 경증의 급성기 질환이라도 불충분한 진찰을 통한 진료로 중증, 응급상황 악화 가능
제공 의료 서비스	• 만성질환 관리에 대한 교육·상담, 진단 및 처방 • 약처방의 범위는 재진 진료와 관련된 처방약, 마약류/오남용 우려가 있는 약물 처방 불가
환자 위치, 제공 주체	• 섬, 산간벽지, 군부대, 교정시설 등의 의료취약지와 중증 장애인 등 거동이 불가능한 의료 취약 계층을 대상으로 환자 거주지역의 권역별 진료권 내에서 진료 • 의료전달체계의 왜곡 막기 위해 환자 거주지역의 1차의료기관에 한해 진료 가능
진료 주기 및 횟수	• 3회 이상 같은 질병으로 대면진료 한 경우 비대면 진료 가능, 2회 연속 비대면진료 불가능 • 환자가 비대면진료 받을 수 있는 보험적용 횟수 제한
비대면 진료 전담금지	• 의료영리화의 우려와 건강보험 재정 건전성을 고려 비대면진료 전담 금지 • 비대면진료는 의료기관당 월 진료 인원 수의 10% 미만 또는 연 20% 미만 제한
수가	• 대면진료 수가가 낮고 비대면진료에 필요한 기기·장비 구입, 설치, 운영 및 위험 부담을 고려, 대산의사협회 대의원회에서 제시한 수가 인용
플랫폼	• 한시적 비대면진료 기간에 플랫폼중개 서비스 제공에 따른 이용자의 의약품 오남용, 환자 의 의료기관 및 약국의 선택권 제한 등 위법 행위 속출, 비대면진료 중개서비스는 민간 비대면진료 플랫폼을 의협에서 인증한 경우 가능 • 플랫폼의 건전 운영 관리방안 마련, 플랫폼 기업과 이해관계 없는 의료인, 법조인으로 구성된 윤리위원회 설치
법적 책임소재	• 환자의 요청이 있더라도 의사의 비대면진료 거부권 인정 • 진료행위와 관련없이 정보통신기술의 오류 등으로 인한 불가항력적 의료사고에 대한 면책 사유 구체화 및 특례법 제정 • 국가와 지방자치단체는 불가항력적 의료사고에 대한 피해보상비용 지원 • 의료인, 법조인으로 구성된 윤리위원회 설치, 비윤리적 회원에 대한 면책 불인정
개인정보	• 비대면진료 개인정보는 기존 의료법, 정보통신망법, 개인정보보호법 등을 통해 보호, 의협 주도로 개인정보보호 지침을 별도로 개발 • 의사, 환자 개인의 신상정보, 진료기록정보 관련 의료데이터의 소유권 및 소유권 보장을 명시한 관련 법률 개정
사후평가	• 시행 과정에서 의학적, 사회·경제적 관점에서 안전성, 유효성을 정기적으로 평가, 검증

자료: 대한내과의사회(2023.5.22.), 「대한내과의사회 비대면진료 시범사업 가이드라인」.

비대면 진료는 섬, 산간벽지, 군부대, 교정시설 등 의료취약지와 중증 장애인 등 거동이 불가능한 의료취약층을 대상으로 진행돼야 하며 환자 거주지를 중심으로 권역 내 1차 의료기관으로 제한하고, 비대면 진료만 하는 전담 기관은 금지하며 의료기관 1곳당 비대면 진료 인원을 월 진료 인원의 10% 미만 또는 연간 20% 미만으로 제한해야 한다고 했다. 비대면진료 수가는 대한의사협회 대의원회에서 제시한 비대면진료 수가를 인용해야 한다고 했다. 비대면진료 시 법적 책임소재 문제에 대해서는 담당 의사의 재량에 따른 비대면진료 거부권을 법적으로 명시하고 정보통신기술의 오류 등으로 인한 불가항력적 의료사고에 대한 면책 사유를 구체화해 특례법을 제정해야 하며, 불가항력적 의료사고에 대한 정부와 지방자치단체의 피해 보상비용 지원이 필요하다고 했다. 개인정보와 관련 대한의사협회 주도로 개인정보보호 지침을 별도로 개발하고, 비대면진료의 안전성, 유효성을 정기적으로 평가, 검증해야 한다고 했다.

2. 한국원격의료학회 비대면진료 가이드라인

한국원격의료학회는 정부의 비대면진료 시범사업 추진에 앞선 2023년 8월 23일 비대면진료 가이드라인을 제시했다. 한국원격의료학회 비대면진료 가이드라인에는 비대면진료 시설의 기본 원칙에서 의사, 환자, 설비제공자의 의무를 각각 명시하고, 초진 비대면진단에 적합하지 않은 증상 및 초진 비대면처방에 충분한 검토가 필요한 의약품에 대해 규정하고, 관련 유권해석에 대한 가이드라인을 제시했다. 가이드라인에서 비대면진료란 환자가 의료인과 직접 대면하지 않고 다양한 정보통신기술 수단을 이용해 의료서비스를 받는 형태의 진료라고 정의하였다. 특히 이 가이드라인은 비대면진료의 실시와 관련하여 환자, 의사, 설비제공자 간의 역할과 책임을 명확히 함으로써, 환자의 의료접근성을 제고하고 환자의 능동적인 치료 참여와 정보 제공을 촉진하여 환자의 건강과 권익을 증진하는 것을 목적으로 함을 밝히고 있다.

<표 4-8> 한국원격의료학회 비대면진료 가이드라인

항목	주요 내용	
비대면진료 실시 기본 원칙	의사	• 환자의 의료접근성 등 권익과 건강 증진을 목적으로 비대면진료 실시 - 의사본인 진료제공 인증, 환자 본인 진료 여부 확인 - 비대면진료의 한계와 우려를 환자에게 고지, 환자가 희망하는 경우 치료 실시 - 환자의 비대면진료가 적절치 않다고 판단하는 경우 대면진료로 전환 - 비대면진료를 직업적·윤리적 기준 하에 실시, 정기적 평가·검증에 협력 - 비대면진료의 마지막 단계에서 만성질환에 대한 후속조치에 대한 안내 제공
	환자	• 자신이 정보통신망으로 제공한 정보에 입각, 의사가 의료행위에 대한 판단할 수밖에 없음 이해, 자신의 증상, 병력, 특이체질, 환경 등에 대한 정확한 정보 제공
	설비 제공자	• 매개자의 역할에 그치지 않고 환자와 의사, 약국 간 비대면진료 서비스 제공 및 이용에 관한 편의 증진 도모위해 적극 노력 - 의사/환자 본인 확인, 의사 고지/환자 희망의사 표시, 환자 정보제공 촉진 위한 인 터페이스와 설비 환자/의사에 제공, 효과적이고 안전한 비대면진료 환경 조성 - 의료데이터의 누설, 변조가 없도록 기술적·관리적 조치 시행 - 의료법 등 관련 법령 준수 및 의사의 관련법령 준수에 조력 - 처방은 의사의 진료권/선택에 전적 의존, 의사에 대체·임의조제 권고/강요 불가 - 의약품 배송 수행 사업자는 의약품 배송 관련 유통망 구축
본인 확인	• 의사는 환자 본인의 진료 여부 확인 및 이에 환자 협조, 환자 협조가 이루어지지 않는 경우 응급처치 외에 진료 미개시 혹은 중단, 의사는 비대면진료 시 본인의 의료 제공 인증 • 설비제공자는 의사·환자의 본인 인증을 위한 기술적 수단 제공	
비대면진료 한계/불이익 고지 및 환자 동의	• 의사는 비대면진료의 첫 단계에서 환자에게 비대면진료의 한계와 발생가능 불이익 고지 - 비대면진료 시 얻을 수 있는 정보가 한정되어 환자의 적극 협력 및 대면진료 조할 필요 - 환자가 관련 정보 제공하지 않을 경우 정확한 진단이 어려운 점, 환자가 한정된 정보만을 제공할 경우 중앙·감염병·심혈관질환 등 중증질환에 대한 진단 노력 가능하며 비대면진료를 받은 사실이 이러한 진단을 배제하는 근거가 될 수 없는 점, 중증질환에 대한 진단자연이 초 래되지 아니하도록 환자 스스로 정기적인 건강검진 또는 대면진단 실시해야 하는 점 - 비대면진료 이후 증상/상태 악화 경우 대면진료로 즉시 전환 - 의사는 불가항력적 의료사고에 대한 책임이 없는 점 - 환자가 위의 사실을 이해하고 비대면진료를 희망하는 경우 비대면진료 실시 • 비대면진료 의사 표시 확인은 다음의 경우 생략 가능 - 의사가 환자에게 이미 위의고지 이행, 환자가 비대면진료 의사 표시한 경우 - 설비제공자가 해당 환자의 비대면진료 의사표시를 수령하여 기록 보관하는 경우 - 의사가 환자의 응급상황 등 긴급 사유로 의사표시확인인 시간적 여유가 없다고 보는 경우 • 비대면진료 의사표시는 설비제공자가 제공하는 온라인고지 화면 등을 통해 제공 가능	
환자 정보제공	• 환자는 의사에게 본인 관련 정확한 정보 제공, 이를 거부하거나 부정확한 정보 제공의 경우 의사는 비대면진료 중단 및 거부 가능 • 설비제공자는 환자정보 제공을 위한 필요 수단 제공, 환자의 개인정보 전송 요구권 행사에 조력	
초진 비대면 불가 증상 및 처방 검토 필요 의약품	• 의사의 판단에 따라 비대면진료에 적합하지 않은 증상/상태가 악화되는 환자에 대해서는 신속하게 비대면진료 중단, 대면진료로의 전환 요구 • 의사의 판단에 따라 특히 기저질환 등의 정보가 파악되지 않은 환자에 대해, 초진 비대면 처방에 충분한 검토가 필요한 의약품 처방에 신중 • 의사는 개별 환자의 상태에 따라 유연하게 대응, 최종 판단은 의사의 의학적 판단	
유권해석 등	• 유관 단체는 환자의 본인확인, 희망 표시, 정보 제공 거부/지연/부정확한 경우, 또는 의사의 대면진료·처방 전환 사유가 있다고 판단할 경우 등 이는 진료거부에 해당하지 아니함을 분명히 하기 위한 유권해석 기타가이드라인을 도출하기 위하여 노력	

자료: 한국원격의료학회(2023.8.23.), 「대한내과의사회 비대면진료 시범사업 가이드라인」.

3. WHO의 원격의료 안내서

WHO(2022.11) 코로나19로 인해 원격의료 서비스의 구현이 전 세계적으로 매우 중요한 이슈로 등장함에 따라 원격 의료를 구현하고 그 혜택과 영향을 최적화하기 위한 주요 단계와 고려 사항에 대한 개요를 제공하는 원격의료 안내서를 발간하였다. 이 안내서는 COVID-19 팬데믹에서 얻은 교훈을 활용하여 원격의료와 관련하여 주요 계획, 구현 및 유지 관리 프로세스에 대한 포괄적인 개요를 제공하는 것을 목적으로 하고 있다. WHO는 2003년 노르웨이 원격의료센터를 통해 보츠와나공화국, 남아프리카공화국, 스리랑카, 네팔 등의 국가에서 원격의료 타당성 연구를 수행한 바 있으며, 이를 통해 정책, 조직, 재정, 기술 관련 사항 등 4개 영역에 대한 고려 사항 및 지침을 제시한 바 있다(Sørensen, 2003). 특히 원격의료 사업모델을 개발할 때 고려해야 하는 중요한 점검항목을 제시하였다.²⁹⁾ 그리고 원격의료(디지털 헬스)는 국가의 보건 우선순위에서 필수적인 부분이 되어야 하며 투명성, 접근성, 확장성, 복제성, 상호 운용성, 개인정보 보호, 보안 및 기밀성 원칙에 입각하여 추진되어야 한다고 WHO(2021)는 제시하고 있다.

WHO(2022.11)는 환자-의사간 원격의료에 있어서 원격의료는 대면 진료를 대체하는 것이 아니라 보완하는 것이며, 이는 환자의 안전성, 개인정보, 책임성 및 보안을 모니터링할 수 있는 환경에서 가능하다고 권고하고 있다. 특히 모니터링에서는 환자의 동의, 데이터 보호 및 저장, 제공자 라이선스 및 자격 증명 확인을 위한 프로토콜을 설명하는 표준 운영 절차(SOP)를 수립하는 것이 포함되어야 함을 강조하고 있다. 그리고 의료인과 의료인 간의 원격의료에 있어서는 환자의 안전, 개인정보 보호, 책임성 및 보안을 모니터링할 수 있는 환경에서 제공자 간 원격 의료를 사용할 것을 권장하고 있다. WHO의 안내서는 원격의료 프로그램의 계획, 실행 및 유지 프로세스를 용이하게 하는 단계별 체크 리스트를 아래의 표와 같이 제시하고 있다. 단계는 크게 원격의료를 추진하고자 하는 초기 과정, 실행 과정, 그리고 모니터링 및 평가과정의 3단계로 나누고, 각각의 단계에서 고려해야 할 사항들이 역시 단계별로 제시되고 있다.

29) 2003년 노르웨이 원격의료센터 연구의 자세한 내용에 대해서는 류시원(2004.12) 참조.

<표 4-9> WHO 원격의료 안내서가 제시하는 원격의료 실행 단계별 고려 사항

단계	구분	고려해야 할 주요 내용
상황 평가	팀 구성 및 목표 설정	• 이해 관계자 파악
	의료 프로그램 상황 및 목표 정의	• 원격의료 서비스의 프로그램 및 지리적 범위 결정
	환경 분석 수행	• 소프트웨어 애플리케이션 및 채널에 대한 환경 분석 수행 • 하드웨어 요구사항 및 가용성 검증
	지원 환경 평가	• 디지털 성숙도 평가에 기초한 인프라 및 조직 요구 사항 결정 • 의료진의 가용성 역량 검토 • 규제 및 정책 고려사항 평가 • 관찰권 간 정보 흐름에 대한 영향 고려 • 자금조달 메커니즘 검토
실행계획 수립	원격의료 시스템 운용 방식 결정	• 기능적·비기능적 요구사항 정의 • 요구사항 반영, 워크플로우 업데이트 • 광범위한 사용자 테스트 실시 • 변경관리 계획 수립
	환자 및 의료 종사자 안전 및 보호를 위한 메커니즘 시행	• 데이터 개인정보 보호, 환자 정보 접근 및 보호 위한 시스템 구축 • 의료 종사자의 면허/인증 검증 방법 시행 • 오디오/비디오 녹화 여부 결정 및 공개
	표준 운영 절차 수립	• 임상 프로토콜을 명확히 하고 잠재적 책임 고려 사항 파악 • 교육 패키지 및 지원 채널 결정 • 신원 확인 절차 수립 • 명확한 동의 문서 수립 • 의료진 보수 변경이 필요한지 검토 • 연결된 의료 기기 관리 계획 수립
	고객/환자 참여와 성별, 형평성 및 권리에 투자	• 정보 소외자를 위한 정책 홍보 강화 • 형평성, 성별 및 권리에 대한 영향 평가 • 장애인을 위한 접근성 보장
	예산 개발	• 전체 소유 비용에 대한 예산 정의 • 일상적 의료 서비스 제공 및 구매 계획에 원격 의료 통합 방법 계획
모니터링 및 평가	성과 및 영향 평가를 위한 지표 정의	• 성과 및 영향 평가를 위한 지표 정의
	지속적 개선 및 적응적 관리 계획 수립	• 일상적인 모니터링 및 지속적인 개선을 위한 메커니즘 구축 • 잠재적 위험 완화

자료: WHO(2022.11), Consolidated Telemedicine Implementation Guide.

4. 미국 의사협회의 원격의료 가이드라인

미국 의사협회(AMA: American Medical Association, 2022)는 코로나19로 인해 원격의료 추진의 필요성이 더욱 커진 상황에서 효율적인 원격의료 추진을 위해 비

대면진료 권고안(AMA Telehealth Implementation Playbook)을 발간하였다. 권고안은 의료인의 입장에서 효율적인 비대면진료 구현을 위한 새로운 비대면진료 진행 방식, 주요 단계, 모범사례, 필요 자원 등의 내용을 담고 있다. 권고안은 원격의료가 진료의 연속성 제고, 의료 접근성의 문제 해결, 환자의 이동 시간 감소, 도서벽지의 의료인력 부족 해결 등의 다양한 장점을 가지지만, 일관되지 않은 환급모델, 주간(interstate) 면허 문제, 법적·제도적 규제, 보안 및 개인정보 보호 문제, 건강관리비용에 영향에 대한 증거 부족, 안전하고 효과적 치료를 위한 임상 의무에 미치는 영향에 대한 우려 등의 장벽도 존재한다고 명시하고 있다.

권고안은 원격의료를 위한 사전 준비 단계와 실행 단계를 각각 6단계로 구분하고 각각의 단계에서 무엇을 해야 하는지에 대해 상세한 점진적 요소를 제시하고 있으며, 따라야 할 모범사례와 피해야 할 오류에 대해서도 제시하고 있다. 그리고 성공적인 원격의료가 되기 위해서는 명확하고, 측정 가능하고, 달성 가능하고, 연관되며 적절한 시점에 추진되어야 한다는 SMART(Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely)한 목적이 설정되어야 한다는 것을 강조하고 있다.

<표 4-10> AMA의 원격의료 실행을 위한 권고안

단계	구분	고려 내용
사전 준비	니즈 파악	• 문제가 무엇인가
	팀 형성	• 누가 언제 참여해야 하는가
	성공의 정의	• 달성하고자 노력해야 하는 것은 무엇인가
	공급자 파악	• 올바른 기술은 무엇인가
	사례 만들기	• 정치적·재정적 구매를 어떻게 할 것인가
	계약	• 공급업체와 계획, 예산, 예상시점은 무엇인가
실행	작업흐름 설계	• 기술을 통합하기 위해 필요한 변화는 무엇인가
	의료팀 준비	• 원격의료를 성공적으로 추진하기 필요한 것이 무엇인지 참여자는 알고 있는가
	환자 파트너링(제휴)	• 환자가 필요한 것은 무엇인가
	실행	• 실제 어떻게 해야 하는가
	성공 평가	• 성공적으로 이루어졌는가
	스케일링	• 다음은 무엇인가

자료: AMA(2022), Telehealth Implementation Playbook.

5. 일본 후생성의 온라인진료 가이드라인

일본은 1997년 12월 「정보통신기기를 활용한 원격진료에 대해서」를 통해 도서 및 산간 벽지 환자를 대상으로 만성질환에 대한 대면진료를 보조하는 방식으로 의사-환자간 원격의료를 제한적으로 허용한 이래 점진적으로 원격의료를 확대하여 왔다.³⁰⁾ 2015년 8월에는 원격의료가 전면 허용되었고, 2018년 4월부터 원격진료에도 의료보험이 적용되면서 「온라인 진료의 적절한 실시에 관한 지침」이 발표되었다³¹⁾(김지연, 2020: 16-17). 이 지침에서는 원격의료를 “정보통신기기를 활용한 건강 증진 및 의료 관련 행위”로 정의하고 원격의료의 범위를 의사와 의사간, 의사와 환자간 원격의료를 포함하는 것으로 정의하고 있다. 그리고 의사와 환자간 원격의료의 유형을 진단 등의 의학적 판단을 포함하는 온라인진료와 온라인진찰 권장, 일반적인 정보를 제공하는 원격건강의료 상담의 세 가지 형태로 구분하고 있다. 특히 온라인진료는 “의사와 환자간에 정보통신기기를 통해 환자를 진찰 및 진단하여 진단결과를 전달하고 처방 등의 진료 행위를 실시간으로 하는 행위”로 정의하고 있다. 후생노동성의 온라인진료 주요 지침에 대한 내용은 아래의 표에 정리되어 있다.

한편 코로나19로 인해 2020년 2월 28일에는 만성질환 등을 가진 정기검진 환자 등이 계속적인 의료와 투약이 필요한 경우 전화나 정보통신기기를 이용한 진료를 받고 팩스 등으로 처방전 정보를 받을 수 있도록 하는 내용을 담은 「신형코로나바이러스 감염증 환자 증가시의 전화나 정보통신기기를 이용한 진료나 처방전의 취급에 대해」를, 동년 3월 26일에는 쉽게 예측이 가능한 만성질환자의 증상에 대해서도 전화나 정보통신기기를 이용한 진료와 처방을 추가한 「신형코로나바이러스 감염 확대방지책으로써의 전화나 정보통신기기를 이용한 진료 등의 임시적·특례적인 취급에 대해」를, 그리고 동년 4월 10일에는 앞서 발표한 2개의 통지를 대체하는, 신종코로나바이러스 감염 확대 및 의료기관 방문의 어려움에 비추어 전화 및 정보통신기기를 이용한 진료 및 복약지도에 대한 좀더 포괄적인 대책을 담고 있는 「신형코로나바이러스 감염증 확대시의 전화나 정보통신기기를 이용한 진료 등의 한시적·특례적인 취

30) 이때 원격진료는 “정보통신기기를 응용하여 진료를 지원하는” 것으로 정의되고 있다(후생성, 1997.12).

31) 일본의 원격의료 추진 과정과 관련한 상세한 내용에 대해서는 고순주·정성영(2020) 참조.

급에 대해」를 공표하였다. 2023년 6월에는 원격의료 도입을 위한 환경 조성 추진을 목적으로 하는 「온라인 진료 기타 원격의료 추진을 위한 기본방침」이 발표되었다.

<표 4-11> 후생노동성의 온라인진료 지침

단계	구분	주요 내용
온라인 진료 제공 관련 사항	의사-환자 관계 /환자 합의	• 의사와 환자의 신뢰 구축이 중요, 의사와 환자의 합의 필요 • 환자의 온라인 진료 희망 명시적으로 확인 필요 • 합의 전 환자에게 온라인진료의 이점과 약점 설명 등 충분한 정보 제공 • 의사가 의학적 관점에서 온라인진료 실시의 가부 판단, 온라인진료가 적절치 않다고 판단하는 경우 온라인진료 중단하고 대면진료 실시 • 긴급한 상황의 경우 먼저 온라인진료 실시 후 설명가능한 시점에서 설명 • 온라인진료 만으로 충분한 정보를 얻지 못하는 경우 대면진료 조합 필요
	적용 대상	• 초진 (단골의사) 및 응급환자는 대면 원칙 • 온라인진료는 직면 대면진료를 받은 후 재진부터 실행하는 것이 원칙 • 환자가 적절한 치료를 받기 어렵고 신속한 진료를 받는 것이 필요하거나, 온라인진료의 필요성·유효성·위험성을 검토하여 의사가 필요하다고 판단하는 경우 온라인 진료 시행 가능, 이 경우에도 온라인진료 후 대면진료 실행이 원칙 • 온라인진료를 실시하는 의사는 원칙적으로 대면진료를 실시한 의사(여러 의사로 구성된 팀 진료의 경우 교대로 온라인 진료 허용, 그러나 온라인진료를 실시할 예정의 의사가 병결, 근무변경 등에 의한 경우 다른 의사의 온라인진료가 가능하나 이경우에도 환자의 동의와 충분한 인수인계가 있어야 하는 조건이 필요함)
	진료 계획	• 의사와 환자 간 필요한 규칙을 진료계획으로 작성하고 온라인진료 실시에 앞서 환자의 합의를 얻어야 함 • 온라인진료계획에 포함되어야 하는 내용 -온라인진료를 실시하는 구체적 진료내용(달병명, 치료내용 등) -온라인진료와 직접 대면진료, 검사 조합에 관한 사항(빈도, 타이밍 등) -진료시간에 관한 사항(예약제 등) -온라인진료 방법(사용하는 정보통신기기 등) -온라인진료를 행할 수 없다고 판단하는 조건에 해당하는 경우 대면진료로 대체 -축진 등이 불가하여 정보가 제한되는 경우 환자의 적극적 진찰 협력 필요 -응급시 대응방침(스스로 대응할 수 없는 질환의 경우 대응 의료기관 명시) -복수의 의사가 온라인진료를 실시할 예정이 있는 경우 그 의사의 이름, 어떤 경우 어떤 의사가 온라인 진료를 하는지 명시 -정보보안에 대한 책임의 범위 등 명시 • 영상, 음성 등의 온라인진료 기록의 보존 여부, 저장기기 등 합의
	본인 확인	• 의사와 환자 양쪽에서 본인 확인 실시 • 의사는 면허 확인, 환자는 보험증, 운전면허증 등 제시
	약제처방·관리	• 현재 온라인진료를 질환과 연결된 의약품은 의사의 판단으로 온라인 처방 가능 • 새로운 질환에 대해 실시하는 의약품 처방은 직접 대면진료 • 의사는 환자가 현재 복용하고 의약품 확인 필요, 환자는 정확한 정보 제공
	진찰 방법	• 화상통화 등 실시간 시청각 정보가 포함된 정보통신수단 이용 • 직접 대면진료를 대체할 수 있을 정도로 환자 심신 상황에 대한 유용한 정보를 얻을 수 있는 경우 보조적 수단으로 화상, 문자 등에 의한 정보 교환 활용 가능 • 정보통신기기를 이용, 동시에 복수의 환자 진료를 행하는 것은 안됨

〈표 4-11〉 후생노동성의 온라인진료 지침(계속)

단계	구분	주요 내용
온라인 진료 제공체제 관련 사항	의사 소재	- 온라인진료 실시 장소는 반드시 의료기관일 필요는 없지만 소음이 있는 등 환자 정보를 얻기에 부적절한 장소와 공개된 장소는 안됨 - 진료 질의 확보를 위해 의료기관에 있는 정도의 정보 획득을 할 수 있는 체제 정비 필요
	환자 소재	- 병원, 진료소 등의 의료제공시설 또는 환자의 거주지 등에서 진료해야 하는다는 의료법상 규정이 온라인진료에서도 동일하게 적용 - 환자의 위치가 대면 진료가 이루어지는 경우와 같은 정도로 깨끗하고 안전하며, 개인정보 보호를 할 수 있는 공간
	통신환경 (정보보호· 이용기기)	- 이용하는 정보통신기기와 클라우드서비스를 포함한 진료시스템(범용비디오 전화서비스 등도 포함)을 적절히 선택·사용하기 위하여 환자·의사·온라인진료시스템 제공 사업자 3자의 합의가 중요 - 의료정보를 보존하는 시스템에 접속하지 않는 경우와 접속하는 경우로 나누어 각각의 경우에 검토·고려해야 하는 사항 기재 - 환자의 잘못에 의해 정보 보호 문제와 손해 등이 발생하는 경우를 대비하여 환자 자 책임소재 등에 대해 합의 필요 - 기술적 안전대책 외에 인적, 물리적, 조직적 안전대책을 종합적으로 검토·실시 하는 것이 필요
기타 온라인 진료 관련 사항	의사교육/ 환자교육	- 온라인 진료에서는 의학적 지식뿐만 아니라 정보 통신 기기 사용이나 정보 보호 등에 관한 지식이 필요하기 때문에, 의사는 의료관계단체 등에 의한 연수 수강 등에 의한 지식 습득 필요 - 환자는 온라인진료의 한계를 인식하고 의사의 결정을 존중하며, 적절한 정보제공 방법에 대해 의사와 환자간 계속 협의
	질 평가/ 피드백	- 질 평가는 의학적, 의학 경제적·사회적 관점 등 다각적인 관점에서 평가 - 대면진료와 마찬가지로 정도의 진료 기록의 기재는 필요, 진단 등의 기초가 되는 정보(진찰시 동영상·화상 등) 보관의 경우 의료정보안전관리 관련 가이드라인 등에 따라 보안 강구
	증거 축적	온라인진료의 안정성·유효성 등에 관한 정보는 개개 의료기관에서 보관할 뿐 아니라 급후 온라인진료의 발전을 위해서도 사회 전체에서 공유·분석되는 것이 바람직

자료: 厚生労働省(2018), 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」.

온라인진료의 적절한 실시에 관한 지침 발표 이후 2019년 7월, 2022년 1월, 2023년 3월 등 3차례에 대한 개정이 이루어졌다. 이러한 지침 개정에서 온라인진료의 제공체제에 새로운 형태의 유형 신설, 통신환경에 프라이버시가 추가되면서 관련 규정의 상세한 내용 추가, 원격의료에 대한 이해를 돕기 위한 여러 가지 사례 제시 등 별첨 추

가, 대면진료 원칙의 예외 조항 추가 등이 이루어졌다. 이처럼 온라인진료 지침 개정은 다양한 사례 제시를 통한 규정의 명확화, 상황 및 환경 변화에 따른 내용 신설 및 추가 등 내용의 다양화 등 온라인진료의 보급 확대 및 활성화, 그리고 사용자의 편의성을 높이는 방향으로 진화하고 있다. 한편 총무성(2022.4.; 2024.5)은 원격의료의 보급 촉진을 위한 목적으로 원격의료 도입을 검토하는 지방자치단체와 의료기관 등을 대상으로 원격의료모델 참고서를 발간하였다. 이 참고서는 사전 협의 및 검토, 실제 도입·추진을 진행할 때 구체적인 수순과 시스템 구성 등의 관점에서 참고가 되는 정보와 정보보안 대책 등의 기술적인 면을 중심으로 기술하고 있다.

고순주·정성영(2020: 15)은 우리나라는 관련 법률을 개정하는 방식을 통해 원격의료를 추진함으로써 어려움을 겪고 있으나, 일본은 “법률이 아닌 법률을 해석하는 행정 내부의 문서(후생성의 통지)를 통해 의사와 환자간 원격의료가 가능하게 되었다”는 것을 그 특징으로 지적하고 있다. 그리고 이제까지의 일본의 원격진료 추진과정을 볼 때 비록 “그 보급률은 매우 낮지만 원격의료에 대한 의사와 환자의 수용도는 점차 증가하고 있으며, 코로나19로 인한 특례가 적용되면서 원격의료가 향후 크게 확산될 것으로” 평가하고 있다(고순주·정성영, 2020). 그렇지만 원격의료를 추진하는 과정에서 “온라인진료에 대한 인지 부족 해소, 의사의 업무부담 완화, 정보통신기기 이용시의 불편 해결, 진료보수 적용 질환의 확대 요구에의 대응, 온라인진료시스템 도입을 위한 의료기관의 비용부담 문제 해소 등”을 과제로 지적하고 있다.

6. IDB의 원격의료 가이드라인

IDB에서 발간한 Aizenberg(2022)의 원격 의료 가이드라인은 코로나19로 인해 원격의료의 중요성이 부각하는 가운데 중남미 국가의 원격의료 규제 프레임워크 현황과 그 이행을 위한 핵심 요소를 분석하고 이 지역의 모범 사례와 교훈을 공유하여 규제 개선의 기회를 파악하는데 그 목적을 두었다. 이를 위해 이 보고서는 26개 남미 및 카리브해 국가의 원격의료 관련 기존의 규제 현황을 파악하고, 성숙도 분석을 위한 개념적 프레임워크와 방법론을 제시하며, 평가 도구를 적용한 결과를 공유하고 강점

과 약점을 파악한 후 마지막으로 수정 또는 포함해야 할 과제와 측면에 대한 권고 사항을 제시하고 있다. 원격의료 규정이 다루어야 하는 범주를 원격 의료의 규제 측면, 원격 의료 거버넌스, 원격 의료에서 개인 데이터 보호, 원격 의료의 기술적 측면, 원격 의료에서 의료 기관 및 팀의 역할, 원격 의료에서 환자의 역할, 원격 의료에서 공통 고려 원칙(cross-cutting principle)과 인권 등 7가지로 분류하고, 각각에서 고려해야 할 구체적 규정의 내용을 다루고 있다.

〈표 4-12〉 IDB가 제시하는 원격의료 규정이 담아야 할 주요 내용

구분	주요 내용
원격 의료의 규제 측면	• 원격 의료의 일반적인 규제 문제 • 서비스 제공 • 집행 권한 및 책임
원격 의료 거버넌스	• 국가 전략 및/또는 구체적인 정부 계획 • 원격 의료 교육 및 훈련 • 의료 시스템에서의 구현 범위
원격 의료에서 개인 데이터 보호	• 개인 건강 데이터의 법적 보호 • 건강 데이터의 소유권, 사용 및 전송 • 건강 데이터 보안
원격 의료의 기술적 측면	• 인프라 및 연결성 • 원격 의료의 기술적 및/또는 기술적 측면 • 원격 의료의 디지털 도구 및 서비스
원격 의료에서 의료 기관 및 팀의 역할	• 원격의료 시행을 위한 승인 프레임워크 • 원격 의료 시행과 관련된 문제 • 관할권 간 서비스 제공 • 원격 의료 서비스의 인간화
원격 의료에서 환자의 역할	• 개인 권리 관련 동의 • 접근성 및 형평성 • 환자의 권리와 책임
원격 의료에서 공통 고려 원칙(cross-cutting principle)과 인권	• 디지털 격차 해소 • 장벽 줄이기 • 환경 보호 • 디지털 생명윤리 원칙

자료: Aizenberg, M.(2022), Regulatory Framework for Telemedicine: Current Status and Next Steps, Inter-American Development Bank.

제4절 비대면진료 시범사업 지침에 대한 시사점

1. 관련 법 정비: 법적 추진 근거 마련 및 법적 미비점 보완

코로나19 팬데믹 이후 많은 국가에서 원격의료의 허용 범위를 넓히고 있고 원격의료에 대한 필요성도 높아지고 있다. 더욱이 정보통신기술 및 의료 기술이 빠른 속도로 발전함에 따라 원격의료에 대한 수요는 더욱 높아질 것으로 전망된다. 소비자와 의료진도 원격의료의 추진 필요성에 대해 점점 더 긍정적 반응을 보이고 있다. 먼저 원격의료의 도입과 관련하여 의료진을 대상으로 한 설문조사 결과를 보면 2014년 찬성은 불과 3.48%에 불과하였는데, 2022년 찬성 비율은 34.8%로 대폭 높아져 원격의료에 대한 의료진의 인식 변화가 있음을 알 수 있다(김진숙·임지연·강주현, 2022.4: 126). 소비자 설문조사 결과를 보면 응답자의 92.6%가 원격의료 도입에 찬성하고 있고, 82.6%는 향후 원격医료를 이용할 의향이 있다고 응답하였다(김민아·이경아, 2018). 코로나19 이후 비대면진료 서비스에 대한 인식조사 결과를 보면 93.8%의 응답자가 대체로 긍정적인 답변을 하는 등 비대면진료 필요성에 대한 인식이 조금 더 높아졌다고 볼 수 있다(김유석 외, 2022.5: 3). 원격医료를 둘러싸고 과학기술 환경 및 관련 이해당사자의 인식 변화가 빠르게 변화하고 있는 상황에서 이를 현실화시키기 위해서는 제도 마련, 특히 관련 법의 개정과 더불어 규정 마련이 필요하다.³²⁾

현재 비대면진료 시범사업을 추진하는데 있어서 근거로 삼고 있는 법 조항은 앞서 살펴본 바대로 「보건 의료법」 제44조(보건 의료 시범사업)이다. 이 조항은 “① 국가와 지방자치단체는 새로운 보건 의료제도를 시행하기 위하여 필요하면 시범사업을 실시할 수 있다”는 내용을 담고 있다. 비대면진료, 즉 원격의료와 관련하여 중요한 사항들은 「의료법」 제34조(원격의료)의 규정 개정을 통해 그 근거를 마련하여야 함에도 불구하고 정부와 의료계 간에 원격医료를 둘러싸고 원만한 합의가 이루어지지 않아

32) 김진숙·임지연·강주현(2022.4: 107)은 “대부분의 국가에서는 원격의료 시행 이전에 법·제도 정비를 먼저 진행한 후 원격医료를 시행하였다. 국내에서도 원격의료 시행 전에 원격의료 시행에 있어서 우려되는 점(예를 들면 법적 책임 소재)에 대한 법·제도 정비를 먼저 진행한 후 원격의료 시행에 대한 논의를 시작할 필요가 있음”을 지적하고 있다.

비대면진료는 시범사업의 형태로 추진되고 있는 것이다. 따라서 향후 시범사업의 형태가 아니라 본격적인 형태의 원격의료를 추진하기 위해서는 「의료법」 개정을 통한 법적 근거가 마련될 필요가 있다. “원격의료는 국민의 건강과 직결되는 의료서비스 제공수단이기 때문에(김진숙·오수현, 2018: 27)”, 원격의료와 관련한 법 규정은 매우 구체적이고 명확하게 규정될 필요가 있다. 더욱이 의료법 개정에 더해 “향후 원격의료의 정착을 위해서는 개인의료정보 보호를 위한 제 규정과 자가 측정 자료를 원격진료에 이용하는 정보통신 S/W에 대한 규정의 마련, 관련 의료기기법 개정, 전자처방이나 온라인 약국 설치를 위한 관련 약사법 규정, 원격의료의 보험수가에 관한 국민건강보험법 개정 등 관련된 다수의 법률 정비가 단계적으로 이루어질 필요가 있다(윤효영, 2021.3: 485).”

2. 시범사업 지침의 내용 보완: 포괄적 범위의 지침 내용

앞서 원격의료관련 국내의 주요 가이드라인을 살펴보았는데, 이를 바탕으로 비대면진료 시범사업 지침의 내용과 비교하여 정리한 것이 다음 <표 4-13>이다. 물론 대부분의 가이드라인이 모든 내용을 다 포괄하고 있는 것은 아니지만, 현재 국내에서 추진되고 있는 비대면진료가 시범사업의 형태로 추진되고 있다는 사실에 주목할 필요가 있다. 일본 후생노동성 온라인진료 지침의 경우 온라인진료의 질 평가/피드백 및 증거 축적과 관련한 모니터링 및 평가가 주요 내용으로 포함되고 있다. 즉 경제적·사회적 관점 등 다각적인 관점에서 평가가 이루어질 필요가 있고, 온라인 진료의 안전성·유효성 등에 대한 정보가 사회 전체적으로 공유·분석되어야 온라인진료의 발전이 이루어질 수 있다고 보고 있다. 따라서 시범사업이 향후 실제 사업으로 원활하게 이행하기 위해서는 유효성 검증을 위한 장치들이 마련될 필요가 있다. 즉, “비대면진료 시범사업의 추진이 의도하는 바 목적을 분명히 하고 검증하고자 하는 정책효과 및 평가기준을 명확히 제시하는 것이 필요하다”(김진숙·오수현, 2024.6), 이를 위해서는 성과 및 영향 평가를 위한 지표를 정의하고, 일상적인 모니터링 및 지속적 개선을 위한 메커니즘을 구축하여야 한다.³³⁾ 「보건의료법」 제44조(보건의료 시범사업)에서도 “② 국가와

지방자치단체는 제1항에 따른 시범사업을 실시한 경우에는 그 결과를 평가하여 새로 시행될 보건의료제도에 반영하여야 한다”고 규정하고 있다.

〈표 4-13〉 비대면진료 시범사업 지침의 주요 포괄 내용 비교

구분	비대면진료 시범사업 지침	정부의료법 개정안 (2014)	대한내과 의사회 가이드라인	한국원격 의료학회 가이드라인	WHO 원격의료 안내서	후생노동성 온라인진료 지침
대면진료 원칙			○	○		○
실시기관/대상환자	○	○	○	○	○	○
수가	○	○	○	○	○	○
진료 방식	○	○	○	○	○	○
제공 의료 서비스	○	○	○	○	○	○
약 처방/배송	○	○	○	○		○
비대면전담 금지	○	○	○			
진료 횟수 제한		○	○			
본인 확인	○		○	○	○	○
개인 정보			○	○	○	○
의사/환자 교육						○
법적 책임소재		○	○	○		
모니터링 및 평가			○		○	○
유권 해석				○		

자료: 관련 지침 및 가이드라인에 의거하여 연구진 작성

특히 비대면진료와 관련하여 가장 중요한 쟁점이라고 볼 수 있는 법적 책임소재에 대한 내용도 지침에 포함될 필요가 있다. 비대면진료 시범사업 추진 후 의료진을 대상으로 한 조사 결과를 보면 “비대면진료 시범사업에 참여하지 않은 이유로 ‘법적 책임 소재에 대한 면책 조치가 없어서’가 66.5%로 가장 응답률이 높았고 그 다음으로 안전

33) 김지연(2020: 28)은 “2014년부터 시행된 시범사업들을 통해 원격의료의 만족도, 안전성 및 임상 효율성에 대한 데이터는 어느 정도 수집되었으나 의료비 절감과 그 외 가능한 효과에 대해서는 추가적 분석이 필요”하다고 봄으로써 그동안의 시범사업에 있어서 일부 모니터링 및 평가가 이루어졌다고 보고 있으나, “원격의료 시범사업 20년 동안 효과성 검증이 부실했다”는 지적도 제기되고 있어(이창진, 2022.05.26.)“ 시범사업의 효과성을 높이기 위해서는 평가 및 피드백이 매우 중요하다고 할 수 있다.

성이 검증되지 않아서가 61.8%로 높았다(김진숙, 2024.1: 83).” 이처럼 비대면진료를 하는데 있어서 의료진이 가장 크게 느끼는 것은 오진 혹은 의료사고로 인한 책임을 「의료법」 제34조 제3항에 따라 온전히 의료진이 진다는 점에 있다. 비대면진료가 제도화되는 과정에서 의료인의 수용성을 높이기 위해서는 의료과실의 원인을 따져 의료인의 책임이 없다고 판단하는 경우 책임 면책 규정을 마련할 필요가 있다.³⁴⁾ 김진숙·임지연·강주현(2022.12)에 따르면 “법적 책임 소재에 대해서 해외의 경우 비대면진료 행위에 대한 면책 규정은 부재하나 시행조건, 서면동의, 절차요건 등을 통해 법적 안전성을 확보하고 있었다.” 예를 들어 일본의 온라인진료 지침을 보면 온라인진료 시 의사가 지켜야 할 최소 준수사항과 권장 사항을 규정하고 있고, 온라인진료의 안전성을 담보하고 진료로써 유효한 문진, 진단 등이 행해지기 위해 필요한 최소 준수사항을 이행하는 경우 의사법 제20조에 저촉되지 않는다고 명시하고 있다.

이외에도 개인정보 보호와 관리/감독의 문제와 관련한 내용이 지침에 포함될 필요가 있다. 정보통신기술을 이용한 해킹을 통해 개인 의료정보의 변질, 도용 및 유출과 같은 정보 침해사고가 일어날 가능성이 있고, 비대면진료에 필요한 개인의료정보의 오용 및 남용 가능성도 있다. 개인의료정보의 경우 개인의 사생활의 비밀과 자유가 침해될 가능성이 있기 때문에 이와 관련한 강력한 보안체계 마련이 필요하다. 또한 진료에 필요한 개인정보의 활용 및 공유가 너무 억제될 경우 적절한 비대면진료가 이루어지지 못하거나 비대면진료 활성화에 걸림돌이 될 수도 있다. 따라서 개인 정보 보호와 관련한 적절한 표준화된 지침 마련이 필요하다.

34) “의사는 환자가 제공한 의료 정보에 근거하여 내린 의학적 판단으로 인해 발생할 수 있는 오진과 의료사고는 물론 정보통신기술(기기, 인터넷 네트워크, 소프트웨어 등)의 결함으로 인한 오작동 및 해킹과 같은 보안상의 위험으로 인해 발생할 수 있는 오진과 의료사고가 발생했을 때도 책임을 져야 한다. 환자 진단 및 치료에 집중해야 하는 의사가 정보통신기술을 습득하고 관리하면서 오진과 의료사고 발생 가능성, 법적 책임소재 및 의료분쟁 발생 가능성까지 감내하면서 원격의료를 할 수는 없다. 법적 책임소재에 대한 제도화는 원격의료와 관련하여 가장 먼저 해결되어야 할 문제이다(김진숙·임지연·강주현, 2022.4: 17-18).”

| 제5장 | [사례3] 유전자검사 가이드라인

제1절 DTC 유전자검사 가이드라인 연구의 필요성

최근 유전체 분석 기술이 발전하고 유전체 서열분석(genome sequencing)에 소요되는 시간과 비용이 단축되고 있고, 대량의 유전정보를 토대로한 유전자 검사 시장이 활성화될 것으로 전망된다(경기도경제과학진흥원, 2019). 유전자 검사기술의 발달로 유전체 분석 기술의 사용 범위는 의료분야 뿐만 아니라 비의료 분야에서도 지속적으로 확대되고 있는 추세이며 특히, 가장 대중적으로 사용되는 분야는 소비자 직접 구매 유전자 검사(Direct-to-Consumer Genetic Test, 이하 DTC 유전자검사)이다(정진화, 2020; 국가생명윤리정책원, 2024).

생명윤리법에서 유전자검사는 “인체유래물로부터 유전정보를 얻는 행위로서 개인의 식별 또는 질병의 예방·진단·치료 등을 위하여 하는 검사”로 정의하며, 유전자 검사는 크게 비의료기관에서 활용하는 혈연감정, DTC 유전자 검사와 의료기관에서 질병진단 및 치료의 목적으로 수행하는 유전자검사로 크게 구분할 수 있다. 친자확인과 같이 혈연관계를 감정하는 혈연감정은 피검사자의 인권, 복지 및 법적 효력에 영향을 줄 수 있기 때문에 검사기관에는 검사에 대한 법적 근거에 기반한 절차적 정당성 확보가 중요했다(국가생명윤리정책원, 2024). 반면, 의료기관에서 요구하는 유전자 검사는 질병 치료 등을 위한 의료 행위이기 때문에 의료법 및 의료기기법 등의 법률에 영향을 받았다(국가생명윤리정책원, 2024).

하지만, 최근 확대되는 DTC 유전자검사의 경우 의료기관이 아닌 비의료 영역에서 수행되고, 개인의 유전적 특징을 알 수 있는 형태로 제공됨에도 일반인을 대상으로 검사 결과의 분석 및 해석이 제공되기 때문에 정보의 제공 방식 등에 따라 오도의 우려가 높아 시행 및 관리가 중요하다(국가생명윤리정책원, 2024). DTC 유전자 검사에 대한 소비자 인식도 조사 연구에 따르면, DTC 유전자 검사에 대해 ‘약간 안다’라고 대답한 비율이 59.4%(558명), ‘전혀 모른다’라고 답한 비율이 38.6%(362명)으로 DTC 유전자 검사에 대한 이해도는 낮은 것으로 보인다. 하지만, DTC 유전자 검사의 정확도와 신뢰성을 묻

는 질문에 대해 ‘매우 높다’라고 답한 비율이 37.7%(354명), ‘다소 높다’라는 응답이 39.4%(370명)으로 신뢰도는 높은 것을 확인할 수 있었다(약사공론, 2024.07.16.³⁵⁾).

DTC 유전자 검사의 경우 의료 기관에서 행하는 의료 행위가 아니라 소비자가 구매를 하는 일종의 상품이자 서비스로 의료기관을 거치지 않고 온라인상에서 구매할 수 있어 개인의 행복과 알 권리를 보장한다(정진화, 2020). 반대로 유전 정보나 개인의 식별이 가능한 정보의 경우 유전정보에 의한 차별 가능성, 부모의 결정으로 시행되는 미성년 대상의 유전자검사로 인한 결정권 문제 등 개인의 기본적 인권과 관련되어 있으며 활용 방법과 절차에 따른 잠재적인 위험을 내포하고 있다(조소희, 2020). 따라서, DTC 유전자검사의 경우 적절한 규제와 이를 지원하는 가이드라인이 마련되지 않을 경우 결과의 불확실성에 대한 이해 부족으로 개인의 건강과 관련된 결정에 오판을 초래할 수 있고 그 과정에서 발생하는 윤리적 문제 또한 간과할 수 없다. 이러한 이유로 DTC 유전자검사의 안정성을 보장하고 소비자의 권익을 보호하는 가이드라인에 관한 연구는 중요하다. 이에 본 장에서는 유전체 분석 기술을 활용하는 유전자 검사 중에서도 DTC 유전자검사와 관련된 가이드라인을 살펴보고자 한다.

제2절 DTC 유전자검사 가이드라인 현황

생명윤리법은 인간과 인체유래물 등을 연구하거나, 배아나 유전자 등을 취급할 때 인간의 존엄과 가치를 침해하거나 인체에 위해를 끼치는 것을 방지함으로써 생명윤리 및 안전을 확보하고 국민의 건강과 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다. 유전자 연구와 연구에 따른 성과 활용을 대상으로 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 생명윤리 및 안전에 관하여서는 동 법률을 따르도록 한다(조소희, 2020).

DTC 유전자검사의 법적 허용 범위도 2005년 시행된 생명윤리법에 따라 규정돼 왔다. DTC 유전자검사는 2005년부터 2015년도 생명윤리법이 일부 개정되기 이전까

35) DTC 유전자 검사 약국시장, 어디까지 성장 가능할까?, <https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?idx=252042&category=G>(검색일자: 20240822)

지 대통령령(시행령)으로 엄격히 금지되었다(김훈기, 2024). 하지만 2015년도부터 유전자검사 기조가 금지에서 허용으로 변화하고 있다(김훈기, 2024). 2015년 12월 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제50조 제3항이 개정되면서, 의료기관이 아닌 유전자검사기관에서는 “질병의 예방과 관련된 유전자검사로 보건복지부장관이 필요하다고 인정하는 경우”에는 유전자검사가 가능해졌다.

<표 5-1> 생명윤리 및 안전에 관한 법률 제50조

- 제50조(유전자검사의 제한 등) ① 누구든지 과학적 증거가 불확실하여 검사대상자를 오도할 우려가 있는 신체 외관이나 성격에 관한 유전자검사 또는 그 밖에 국가위원회의 심의를 거쳐 대통령령으로 정하는 유전자검사를 하여서는 아니 된다. <개정 2020. 12. 29.>
- ② 유전자검사기관은 근이영양증이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 유전질환을 진단하기 위한 목적으로만 배아 또는 태아를 대상으로 유전자검사를 할 수 있다.
- ③ 의료기관이 아닌 유전자검사기관에서는 다음 각 호를 제외한 경우에는 질병의 예방, 진단 및 치료와 관련한 유전자검사를 할 수 없다. <개정 2015. 12. 29.>
1. 의료기관의 의뢰를 받은 경우
 2. 질병의 예방과 관련된 유전자검사로 보건복지부장관이 필요하다고 인정하는 경우
- ④ 누구든지 유전자검사에 관하여 거짓표시 또는 과대광고를 하여서는 아니 된다. 이 경우 거짓표시 또는 과대광고의 판정 기준 및 절차, 그 밖에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2020. 12. 29.>

DTC 유전자검사와 관련된 가이드라인은 보건복지부와 보건복지부 산하 국가생명윤리정책원에서 발행 및 관리하고 있으며, 관련 가이드라인을 마련하게 된 법적 근거 조항은 크게 생명윤리법 제49조의 2(유전자검사기관의 평가 및 인증), 제50조(유전자검사의 제한 등), 제51조(유전자검사의 동의)와 관련이 있다.

<표 5-2> 생명윤리법 중 DTC 유전자검사 가이드라인 관련 조항

- 제49조의2(유전자검사기관의 평가 및 인증) ① 유전자검사기관의 장은 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 숙련도 평가를 받아야 하며, 보건복지부장관은 그 결과를 공개할 수 있다.
- ② 제50조제3항제2호에 따른 검사(이하 “소비자 대상 직접 시행 유전자검사”라 한다)를 하려는 유전자검사기관의 장은 보건복지부령으로 정하는 시설 및 인력 등을 갖추고 보건복지부장관으로부터 검사항목별 숙련도, 검사결과 분석·해석·전달, 검사대상자와 개인정보의 보호방안 등 해당 기관의 검사역량에 대하여 인증을 받아야 한다. 이 경우 인증받은 기관은 인증 유효기간 동안 제1항에 따른 숙련도 평가를 받지 아니할 수 있다.
- ③ 제2항에 따른 인증의 유효기간은 인증을 받은 날부터 3년으로 하며, 인증의 유효기간이 끝난 후에도 계속하여 그 인증을 유지하려는 경우에는 재인증을 받아야 한다.
- ④ 보건복지부장관은 제2항에 따라 인증을 받은 유전자검사기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 인증을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 그 인증을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 부정한 방법으로 인증을 받은 경우
 2. 유전자검사기관의 검사역량에 시설·인력·장비 등 중요한 변동사항이 발생하여 제2항에 따른 인증기준에 맞지 아니하게 된 경우
 3. 인증받은 항목 외에 소비자 대상 직접 시행 유전자검사를 수행한 경우
 4. 검사대상자의 개인정보를 유출하거나 검사의 효용성을 왜곡하는 등 검사대상자를 현저하게 오도(誤導)하는 방식으로 소비자 대상 직접 시행 유전자검사를 수행한 경우
 5. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 기준을 위반하여 소비자 대상 직접 시행 유전자검사를 수행한 경우
- ⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 평가, 인증, 재인증, 인증 취소의 기준과 절차 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. [본조신설 2020. 12. 29.]
- 제50조(유전자검사의 제한 등) ① 누구든지 과학적 증거가 불확실하여 검사대상자를 오도할 우려가 있는 신체 외관이나 성격에 관한 유전자검사 또는 그 밖에 국가위원회의 심의를 거쳐 대통령령으로 정하는 유전자검사를 하여서는 아니 된다. <개정 2020. 12. 29.>
- ② 유전자검사기관은 근이영양증이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 유전질환을 진단하기 위한 목적으로만 배아 또는 태아를 대상으로 유전자검사를 할 수 있다.
- ③ 의료기관이 아닌 유전자검사기관에서는 다음 각 호를 제외한 경우에는 질병의 예방, 진단 및 치료와 관련한 유전자검사를 할 수 없다. <개정 2015. 12. 29.>
1. 의료기관의 의뢰를 받은 경우
 2. 질병의 예방과 관련된 유전자검사로 보건복지부장관이 필요하다고 인정하는 경우
- ④ 누구든지 유전자검사에 관하여 거짓표시 또는 과대광고를 하여서는 아니 된다. 이 경우 거짓표시 또는 과대광고의 판정 기준 및 절차, 그 밖에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2020. 12. 29.>
- 제51조(유전자검사의 동의) ① 유전자검사기관이 유전자검사에 쓰일 검사대상물을 직접 채취하거나 채취를 의뢰할 때에는 검사대상물을 채취하기 전에 검사대상자로부터 다음 각 호의 사항에 대하여 서면동의를 받아야 한다. 다만, 장애인의 경우는 그 특성에 맞게 동의를 구하여야 한다.
1. 유전자검사의 목적
 2. 검사대상물의 관리에 관한 사항
 3. 동意的 철회, 검사대상자의 권리 및 정보보호, 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 사항
- ② 유전자검사기관이 검사대상물을 인체유래물연구자나 인체유래물은행에 제공하기 위하여는 검사대상자로부터 다음 각 호의 사항이 포함된 서면동의를 제1항에 따른 동의와 별도로 받아야 한다.
1. 개인정보의 보호 및 처리에 대한 사항
 2. 검사대상물의 보존, 관리 및 폐기에 관한 사항
 3. 검사대상물의 제공에 관한 사항
 4. 동意的 철회, 동意的 철회 시 검사대상물의 처리, 검사대상자의 권리, 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 사항
- ③ 유전자검사기관 외의 자가 검사대상물을 채취하여 유전자검사기관에 유전자검사를 의뢰하는 경우에는 제1항에 따라 검사대상자로부터 서면동의를 받아 첨부하여야 하며, 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 개인정보를 보호하기 위한 조치를 하여야 한다.
- ④ 검사대상자가 동의 능력이 없거나 불완전한 경우의 대리인 동의에 관하여는 제16조제2항을 준용한다. 이 경우 “연구대상자”는 “검사대상자”로, “연구”는 “검사”로 각각 본다.
- ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 동의 없이 유전자검사를 할 수 있다.
1. 시체 또는 의식불명인 사람이 누구인지 식별하여야 할 긴급한 필요가 있거나 특별한 사유가 있는 경우
 2. 다른 법률에 규정이 있는 경우
- ⑥ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 서면동의를 받고자 하는 자는 미리 검사대상자 또는 법정대리인에게 유전자검사의 목적과 방법, 예측되는 유전자검사의 결과와 의미 등에 대하여 충분히 설명하여야 한다.
- ⑦ 유전자검사의 동의 방식, 동의 면제 사항, 그 밖에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

DTC 유전자검사 관련 가이드라인은 크게 소비자용과 검사기관용으로 구분된다. 2020년 배포된 소비자용 가이드라인은 DTC 유전자검사 기관마다 다른 결과에 대한 해석이 다른 만큼 국민에서 DTC 유전자 검사의 활용과 한계에 대한 정확한 정보를 제공하기 위한 목적과 국민이 스스로 개인정보인 유전자 정보를 활용하여 다양한 건강증진과 질병 예방을 하는 것을 지원하는 것을 목적으로 한다(MEDICAL WORLD NEWS, 2020.03.10.³⁶⁾). 이에 소비자용 가이드라인은 DTC 유전자 검사를 받을 때의 주의할 점과 결과 해석에 대한 사례를 제시한다. 일반인을 대상으로 DTC 유전자 검사의 정의, 검사 방법, 결과의 활용 및 제한, 한계, 검사기관의 선택, 개인정보 보호, 결과의 이해, 용어의 이해 등으로 구성된다(보건복지부, 2020).

<표 5-3> DTC 유전자검사 가이드라인(일반 소비자용)

시행시기	주요 내용
	[주요 목적] • 국민이 스스로 유전자 정보를 활용하여 다양한 건강증진과 질병 예방을 하는 것을 지원 • DTC 유전자검사 기관마다 다른 결과에 대한 해석이 다른 만큼 국민에서 DTC 유전자 검사의 활용과 한계에 대한 정확한 정보를 제공
소비자용 2020.03	[주요 내용] DTC 유전자 검사를 받을 때의 주의할 점과 결과 해석에 대한 사례 • 정의: 의료기관이 아닌 유전자검사 기관이 검체 수집, 검사, 검사 결과 분석 및 검사 결과 전달 등을 소비자 대상으로 직접 수행하여 실시할 수 있는 검사 • 검사절차: 검사 키트 구입→동의서 작성→검체 채취 및 수집→분석→결과 수령 • 결과의 활용 및 제한: 결과 활용, 유전자검사에 의한 차별 금지, 미성년자 대상 유전자 검사의 제한, 신고되지 않은 검사기관 및 위탁자에 의한 검사의 제한, 허용되지 않은 검사항목의 제한 • DTC 유전자검사의 한계: 검사 기관별 결과 해석의 차이 발생 가능성 • DTC 유전자검사 선택: 소비자가 DTC유전자검사를 하기 전 검사기관 선정을 위한 체크리스트 • 개인정보 보호, 검사 분류별 결과 / DTC 유전자검사 결과지 용어 이해, DTC 결과의 이해 예시

자료: 보건복지부(2020.03), DTC 유전자검사 가이드라인(1차) -일반 소비자용-

36) 보건복지부, 소비자 대상 직접(DTC) 유전자검사 가이드라인 배포, [https://www.medicalworldnews.co.kr/skin/news/basic/view_pop.php?v_idx=1510934612\(검색일자:20240822\)](https://www.medicalworldnews.co.kr/skin/news/basic/view_pop.php?v_idx=1510934612(검색일자:20240822))

유전자검사기관용 가이드라인은 2022년도에 보건복지부의 위탁을 받아 국가생명윤리정책원³⁷⁾에서 배포하였다. 검사기관용 DTC 유전자검사 가이드라인은 DTC 유전자검사 항목 신청 가이드라인과 DTC 유전자검사 서비스를 위한 가이드라인 2개로 이루어진다. DTC 유전자검사 서비스를 위한 가이드라인은 DTC 유전자검사 서비스에 대한 업무 범위의 설정과 그에 따른 관리 주체의 책임 등을 정의하고 DTC 유전자검사 서비스를 제공함에 있어서 유전자검사기관이 고려해야 할 광고 또는 홍보 등 정보의 제공과 실제 검사를 위한 동의 및 상담, 판매, 그리고 생성되는 유전정보의 취급에 관한 사항과 결과 전달 시에 고려되어야 할 사항에 대한 원칙 등을 안내하는데 목적이 있다. 2022년도 7월에 1차 가이드라인을 배포하고 이후 2024년도 3월에 2차 가이드라인을 배포하였다. 2차 가이드라인에서는 DTC 검사 특성을 고려한 소비자 권리 및 프라이버시 보호 등을 위한 서비스 시행방안을 마련하였다.

DTC 유전자검사 서비스를 위한 항목 신청 가이드라인은 유전자검사기관이 생명윤리법 제 49조의2에 따른 인증을 받아 DTC 유전자검사 서비스를 제공하고자 할 때 제공하려는 검사 항목의 신청 및 검토 기준과 방법을 안내한다. 2022년도 12월 1차 가이드라인을 배포하였으며, 2024년도 6월 2차 가이드라인을 발표하였다. 이때, 유전자검사기관에서 신청하는 항목의 분류가 더 구체적으로 제시되었다.

37) 국가생명윤리정책원은 보건복지부 산하 기관으로 생명윤리법에 따라 2022년도 2월부터 도입된 소비자 대상 직접 시행 유전자검사를 위한 검사역량 평가 및 인증 업무를 담당하는 검사역량인증처리기관

<표 5-4> DTC 유전자검사 서비스를 위한 가이드라인(유전자검사기관용)

시행 시기	주요 내용
1차 2022. 07.18	[주요 목적] • DTC 유전자검사 서비스에 대한 업무 범위의 설정과 그에 따른 관리 주체의 책임 등 정의 • DTC 유전자검사 서비스를 제공함에 있어서 유전자검사기관이 고려해야 할 광고 또는 홍보 등 정보의 제공과 실제 검사를 위한 동의 및 상담, 판매, 그리고 생성되는 유전정보의 취급에 관한 사항과 결과 전달 시에 고려되어야 할 사항에 대한 원칙 등을 안내 [주요 내용] • 목적 및 적용 범위: 검사기관의 책임과 역할, 운영 중 고려해야 할 원칙과 방향을 안내하며, DTC 유전자검사 서비스 제공을 위하여 인증을 신청하는 기관 및 인증을 받아 해당 서비스를 제공하고 있는 검사기관은 이 가이드라인 따라야 함 • 주요 용어 및 개념 안내 • 유전자검사기관 운영의 기본 원칙 • 광고 등 소비자에게 제공되는 정: 기본원칙, 실천사항 • DTC 유전자검사 서비스의 판매: 기본원칙, 실천 사항 • 설명 및 동의서 관리: 기본원칙, 실천 사항 • 검사 결과의 전달: 기본원칙, 실천 사항 • 검사대상물 및 유전정보의 취급: 기본원칙, 실천 사항 • [별첨] 「DTC 유전자검사기관 검사역량 평가·인증」 평가자료 제출 안내
2차 2024. 03.28.	[개정 목적] • DTC 검사 특성을 고려한 소비자 권리 및 프라이버시 보호 등을 위한 서비스 시행방안 마련 [주요 개정 내용] • 2차 서비스 정의: DTC 유전자검사를 수행하고 그 결과를 이용하여 소비자에게 건강기능식품 과 같은 상품 등의 판매 또는 건강관리를 위한 지원 등의 정보를 서비스하는 것을 말한다. 다만, 이는 근본적으로 유전자검사나 그 결과와의 연관성에 대한 근거가 없으므로 개인정보보호 법에 따라, 사전에 소비자에게 검사결과를 활용한 2차 서비스 안내 여부에 대한 설명 및 동의를 반드시 받은 뒤에 제공 가능하다. • 2차 서비스 연계 시행 조건: 유전자검사 결과와 그 활용에 관한 사항(단, 2차적 서비스는 개인 정보보호법에 따른 설명 및 동의서를 갖추어 검사역량인증처리기관에 제출된 홍보 및 판매 계획서의 범위 내에서 가능) • 검사 결과를 활용한 2차 서비스 안내(신설): 유전자검사결과를 활용할 수 있는 2차 서비스의 유형 3가지

자료: 국가생명윤리정책원(2022.07.18.); 국가생명윤리정책원(2024.03.28.); 보건복지부·국가생명윤리정책원(2024.6.28.)

<표 5-5> DTC 유전자검사 서비스를 위한 항목 신청 가이드라인(유전자검사기관용)

시행시기

주요 내용

1차
2022.
12.28.

[주요 목적]

- 유전자검사기관이 생명윤리법 제 49조의2에 따른 인증을 받아 DTC 유전자검사 서비스를 제공하고자 할 때 제공하려는 검사 항목의 신청 및 검토 기준과 방법을 안내

[주요 내용]

- 목적 및 적용 범위
- 항목 신청 절차: 신규 항목 신청 절차, 변경인증 신청 절차
- 검토 기준: 항목 검토 기준, 항목별 적절성 검토 기준
- 유전자검사기관의 책임과 의무

2차
2024.
06.28.

[개정 목적]

- 유전자검사기관에서 신청하려는 항목 분류가 변경

[주요 개정 내용]

- 신규 항목 신청 시, DTC 유전자검사 항목의 구분 변경
- 기존

대분류	중분류	소분류
A. 영양, 생활습관 및 신체적 특징에 따른 질병의 예방을 위한 유전자검사	1) 영양 관련	① 체내 대사 정보
		② 특정 영양소 흡수 정보
		③ 기타
	2) 생활습관 관련	① 식습관
		② 운동 습관
		③ 행동 습관
		④ 기타
	3) 신체적 특징 관련	① 내면적 특징
		② 외형적 특징
		③ 기타
	4) 기타	기타
B. 유전적 혈통을 찾기 위한 유전자검사		

- 개정

대분류	중분류*	
A. 영양, 생활습관 및 신체적 특징에 따른 질병의 예방을 위한 유전자검사	가군	· 건강관리와 관련성 낮은 항목 (예컨대, 와인선호도, 모기 물리는 빈도, 왼손/오른손잡이 등 호기심에 기반한 항목)
	나군	· 건강관리와 간접적 관련성이 있는 항목 (예컨대, 비타민 C 농도, 찜맛민감도 등 일반적인 건강 관리에서 고려될 수 있는 항목)
	다군	· 건강관리와 관련된 질병유사항목 (예컨대, 콜레스테롤, 혈압, 혈당, 복부비만(영양이허리비율) 등 질병 예방을 위한 건강 관리 차원에서 고려될 수 있는 항목. 단, 의사 처방 하에 시행되는 질병 진단 지표는 신청 불가)
B. 유전적 혈통을 찾기 위한 유전자검사		

자료: 국가생명윤리정책원(2022.12.28.); 국가생명윤리정책원(2024.06.08.); 보건복지부·국가생명윤리정책원(2024.6.28.)

제3절 주요 이슈

1. 의료기관과 비의료기관 간 규제의 비대칭성

2015년 생명윤리법이 개정되면서, DTC 유전자검사 기관은 생명윤리법 제50조(유전자검사의 제한 등) ③에 따라 대통령령으로 금지 및 제한된 유전자를 제외하면 질병의 예방과 관련된 유전자검사로 보건복지부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 유전자검사를 시행할 수 있다. 반면에, 의료기관의 유전자 검사는 의료기기법과 의료보험법에 나아가 생명윤리법의 규제 대상이다(김종원, 2015; 김훈기, 2024).

의료기관이 유전자검사를 실시하기 위해서는 의료기기법에 의해 식품의약품안전처로부터 의료기기법에 준해 의료기기 인허가를 받아야 하며, 건강보험심사평가원으로부터 요양급여 기준에 부합하는지 검토받아야 한다. 이에 반하여 DTC 유전자 검사기관은 생명윤리법의 규제만 받기 때문에 금지 및 제한된 유전자를 제외한 검사를 의료보험 등재와 관련 없이 실시할 수 있다(김훈기, 2024).

<표 5-6> 국내 의료기관의 유전자검사 규제 현황

구분	검사항목 제한	검사기관 관리	의료기기 인허가	신의료기술 평가	건강보험 등재
근거 법령	생명윤리법 제50조	생명윤리법 제49조	의료기기법	신의료기술 평가에 관한 규칙	국민건강 보험 요양급여 기준에 관한 규칙
운영 주체	보건복지부	질병관리본부	식품의약품안전처	한국보건의료연구	건강보험심사평가원
주요 내용	금지 및 제한 항목과 유전자	시설 및 인력 등 신고	제조업 및 수입업 허가, 제도 및 수입 허가·인증·신고	신의료기술 평가 대상, 절차 등	신의료기술 등의 요양급여 결정

주: 음영 부분은 DTC 유전자검사 기관도 해당
자료: 김훈기, 2024, P.347

이러한 국내 의료기관과 DTC 유전자검사 기관의 규제의 비대칭성은 그 결과의 목적과 활용이 다르기 때문인 것으로 이해할 수도 있다. 한편으로 규제의 비대칭성이 검사 결과의 신뢰성과 결과의 활용성에서 차이를 초래할 수 있다는 우려도 가능하다. 현재의 DTC 유전자검사 기관은 생명윤리법 하에서 웰니스 항목에서 검사를 제공함으

로써 개인의 건강 관리 차원의 정보 활용의 기회를 제공하지만, 개인이 소비한 DTC 유전자검사를 통해 확보한 자신의 유전자 정보를 병원과 공유하는 것이 국내에서는 불가능 하다(데일리한국, 2024.07.15.³⁸). 반면에 의료기관에서는 보다 엄격한 규제 하에서 신뢰성 있는 검사를 제공하고 결과를 바탕으로 질병의 진단에 활용할 수 있다. 이러한 규제의 비대칭성은 소비자에게 다양한 선택지를 제공하고 의료기관에서 시행하는 유전자검사의 안정성과 신뢰성 강화에 기여할 수 있으나, 소비자와 환자에게 혼란을 초래할 수 있고 DTC 유전자검사 기관과 의료기관 등 각 기관의 이해관계가 충돌할 수 있다는 점에서 주의가 필요하다.

2. 생명윤리법상 DTC 유전자검사 항목에 대한 대통령령과 보건복지부장관령의 충돌

현재, 유전자검사의 제한을 규정한 생명윤리법 제50조에는 대통령령으로 절대적 금지를 명시한 조항(제1항)과 보건복지부장관령으로 예외적 허용을 부가한 조항(제3항 제2목)이 공존하고 있어, 보건복지부장관령과 대통령령 두 규정 간의 충돌이 발생한다(김훈기, 2024). 제50조(유전자검사의 제한 등) ①에 따라 누구든지 과학적 증명 이 불확실하여 검사대상자를 오도할 우려가 있는 신체 외관이나 성격에 관한 유전자 검사 또는 그 밖에 국가위원회의 심의를 거쳐 대통령령으로 정하는 유전자검사를 하여서는 아니 된다. 그러나 제3항제2목에 따르면, 질병의 예방과 관련된 유전자검사로 보건복지부장관이 필요하다고 인정하는 경우, DTC 유전자검사 기관에서 검사가 허용되어 “신체 외관이나 성격” 관련 검사가 가능해진 상황이다(김훈기, 2024).

2015년 개정된 생명윤리법(제13651호)이 2016년 6월 30일에 시행됨에 따라 국가 심의위원회는 DTC 기관에서 허용가능한 항목에 대한 심의와 의결을 진행하였으며, 개정법에 따라 기존 대통령령으로 금지해온 ‘네거티브 방식’과 달리 보건복지부장관이 필요하다고 인정할 때마다 유전자검사를 허용하는 ‘포지티브 방식’의 규제가 도입되었다(김훈기, 2024). 이에 따라 보건복지부는 2016년도 6월에 양적 형질, 피부 유전체,

38) 데일리 한국(2024.07.15.), 제도 완화되는 DTC 유전자검사…산업 활성화 기대감 커진다, <https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1105472>(검색일자: 20240823)

영양유전체에 대한 8개 검사항목을 허용하였고 추가로 4개의 검사항목에 대해서 허용 후 2년이 지난 시점에서 재검토하도록 한다는 계획을 발표하여 총 46개 유전자에 대한 DTC 기관의 검사를 허용하는 고시가 2016년도 6월 30일부터 시행되었다.

〈표 5-7〉 생명윤리법 제50조(유전자검사의 제한 등)

- 제50조(유전자검사의 제한 등) ① 누구든지 과학적 증명이 불확실하여 검사대상자를 오도할 우려가 있는 신체 외관이나 성격에 관한 유전자검사 또는 그 밖에 국가위원회의 심의를 거쳐 **대통령령으로 정하는 유전자 검사를 하여서는 아니 된다.** <개정 2020. 12. 29.>
- ② 유전자검사기관은 근이영양증이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 유전질환을 진단하기 위한 목적으로만 배아 또는 태아를 대상으로 유전자검사를 할 수 있다.
- ③ 의료기관이 아닌 유전자검사기관에서는 다음 각 호를 제외한 경우에는 질병의 예방, 진단 및 치료와 관련한 유전자검사를 할 수 없다. <개정 2015. 12. 29.>
1. 의료기관의 의뢰를 받은 경우
 2. **질병의 예방과 관련된 유전자검사로 보건복지부장관이 필요하다고 인정하는 경우**
- ④ 누구든지 유전자검사에 관하여 거짓표시 또는 과대광고를 하여서는 아니 된다. 이 경우 거짓표시 또는 과대광고의 판정 기준 및 절차, 그 밖에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2020. 12. 29.>

이후 의료기관이 아닌 유전자검사기관이 직접 실시할 수 있는 유전자검사 항목에 관한 규정 제2023-300호(2023. 12. 29.)에서 유전자검사 항목을 삭제하고, 소비자 대상 직접 시행 유전자검사 인증 의무 규정(안 제2호)과 인증 받은 항목을 신고하도록 하는 절차 규정을 신설(안 제3호)하면서 소비자 대상 직접 시행 유전자 검사를 하려는 의료기관이 아닌 유전자검사기관은 검사역량에 대해 인증을 받은 후, 질병관리청에 검사항목을 신고하면, 범위 내에서 소비자를 대상으로 직접 유전자검사를 실시할 수 있게 되었다(법 제49조의2제2항, 같은 법 시행규칙 제49조의3).

DTC 유전자검사 서비스를 위한 항목 신청 가이드라인(2024)에 따르면, 신규 항목 신청 절차, 변경인증 신청 절차, 항목 검토 기준, 항목별 적절성 검토 기준 등을 안내하고 있다. 항목 검토 기준에서 DTC 유전자검사 목적³⁹⁾의 범주 내에 있는 항목인지, 해당 항목에 대한 정의가 있고 서비스의 시행 근거를 확인할 수 있는지⁴⁰⁾, 소비자를 대상으로 직접 서비스될 경우, 윤리적인 우려⁴¹⁾가 없는 지를 검토한다.

39) 영양, 생활습관 및 신체적 특징에 따른 질병의 예방을 위한 유전자검사 또는 유전적 혈통을 찾기 위한 유전자검사

40) 정의를 통해 검사 목적 및 범위가 명료하며, 제출된 논문에서 제시된 표현형과 일치여부. 특히, 중분류 다군으로 신청 시, 질병 관련성 검토

위에서 살펴본 것처럼 DTC 유전자검사 기관의 유전자검사 항목에 대한 포지티브 규제 도입은 검사 항목의 빠른 확대를 가능하게 하였다. 특히, DTC 유전자검사 서비스를 위한 항목 신청 가이드라인에서 확인할 수 있는 것처럼 DTC 유전자검사 기관은 과학적 근거를 바탕으로 신규 항목을 신청할 수 있으며, 이 과정에서 요구되는 기준에 부합할 경우 관련 유전자검사 항목이 신속하게 승인될 수 있기 때문이다.

이에 따라 2016년 6월 12개 항목, 46개의 유전자에 대한 검사가 허용된 이후 유전자검사 항목의 수는 점진적으로 증가하였다(김훈기, 2024; 임지숙, 2024). 2023년도에는 허용 유전자검사 항목의 승인 절차가 고시 변경을 통해 특정 항목을 제한적으로 나열해주던 방식에서 나아가 DTC 유전자검사 기관이 과학적 근거를 뒷받침할 경우 새로운 항목을 자유롭게 신청할 수 있도록 허용함에 따라 2024년 4월 기준 181개 항목으로 확대되었음을 확인할 수 있다.

〈표 5-8〉 국내 DTC 유전자검사 허용 항목의 확대 추이

시행시기	허용 항목의 종류와 수
2016.6	12항목(유전자개수): 체질량지수(3), 중성지방 농도(8), 콜레스테롤(8), 혈당(9), 혈압(8), 색소침착(2), 탈모(4), 모발굵기(1), 피부노화(1), 피부탄력(1), 비타민C농도(1), 카페인대사(2)
2020.2	7영역, 56항목(개수): 영양소(10), 운동(8), 피부/모발(10), 식습관(5), 개인특성(12), 건강관리(10), 혈통(1)
2020.11	7영역, 70항목(개수): 영양소(19), 운동(8), 피부/모발(11), 식습관(5), 개인특성(12), 건강관리(14), 혈통(1)
2023.4	81항목
2023.6	101항목
2023.9	129항목
2023.12	165항목
2024.4	181항목

자료: 김훈기(2024); 임지숙(2024)

보건복지부장관령으로 허용된 국내 DTC 유전자검사 허용 항목이 빠르게 확대되는 것과 달리, 동일 법령 제1항의 대통령령으로 금지된 항목 간의 규제 충돌이 발생하고 있다. 현재, 골다공증, 당뇨병, 비만, 우울증, 폐암 등 질병 관련 항목 5개, 그리고 장

41) 생명윤리법 제46조제1항에 따른 차별 또는 제50조제1항에 따른 과학적 증명이 불확실하거나 검사대상자를 오도할 우려가 있는 신체 외관이나 성격 등은 시행 불가

수, 지능, 체력, 폭력성, 호기심 등 개인특성 관련 항목 5개는 여전히 대통령령에 의해 금지된 상태이며, 이러한 금지 규제는 의료기관에도 적용되는 것이기 때문에 그 삭제 과정은 엄격한 심사를 통해 점진적으로 해제될 수 있다(김훈기, 2024).

<표 5-9> 대통령령 금지 항목(2017.2.28.)과 보건복지부장관령 허용 항목 비교

대통령령 금지 항목/유전자	보건복지부장관령허용 항목(시행 시기)
골다공증/VDR	골질량(2020.11.30)
당뇨병/Mt16189	혈당(2016.6.30)
비만/UCP-1·PPARgamma·ADRB3(B3AR)	비만, 중성지방 농도, 체지방율, 체질량 지수, 식욕, 포만감(2020.2), 복부비만(허리엉덩이비율), 운동에 의한 체중감량효과, 체중감량 후 체중회복 가능성(2020.11), 사지 체지방량(2023.4), 체지방량, 엉덩이둘레(2023.6), 지방 음식 선호도, 탄수화물음식 선호도(2023.12)
우울증/5-HTT	-
폐암/CYP1A1	-
장수/Mt5178A	-
지능/IGF2R 또는 CALL	-
체력/ACE	근력운동 적합성, 유산소운동 적합성, 지구력운동 적합성, 근육발달 능력, 단거리 질주 능력, 발목부상 위험도, 악력, 운동 후 회복능력(2020.2), 보행속도, 심폐 지구력(2023.4), 골강도, 골격근량, 심박수(2023.12)
폭력성/SLC6A4	-
호기심/DRD2 또는 DRD4	-

자료: 김훈기(2024)

2007년부터 대통령령으로 금지된 항목 중 일부는 2016년 이후, 보건복지부장관령에 의해 허용된 사례가 발생하였다. 예를 들어 금지된 VDR 또는 Mt16189 유전자 외의 유전자로 골질량이나 혈당을 검사함으로써 결과적으로 골다공증, 당뇨병과 연관된 검사가 가능해진 것이다(김훈기, 2024). 이로 인해 결과적으로 2015년 생명윤리법 개정에 따라 상위법령(대통령령)에서 검사를 금지하고 있는 항목이 하위 법령(보건복지부장관령)에서 허용되는 양상을 보여주는 모순적 상황이 발생하게 되었다.

생명윤리법 제50조(유전자검사의 제한 등)에서 발생하는 규제 간 충돌은 DTC 유전자검사 항목의 확대와 제한이라는 상충되는 상황을 야기한다. DTC 유전자검사 항

목 신청 가이드라인을 통해 보건복지부장관령에 의해 과학적 근거에 기반한 항목이 허용되었는데 이가 대통령령에 의해 금지되는 항목과 유사할 수 있기 때문이다. 그리고 이러한 충돌은 DTC 유전자검사 서비스의 신뢰성과 안전성의 문제로 이어진다. 보건복지부장관령에 의해 DTC 유전자검사 기관에 허용된 항목은 현재는 질병 예방과 관련된 유전자검사로 한정되어 있다. 때문에 대통령령과 상충하는 경우에도 그 영향이 비교적 제한적이라는 점에서 문제가 적을 수는 있다. 다만, 기획재정부에서 2023년도 데이터 경제 활성화 추진 과제로 유전자 데이터 활용 제고를 위해 DTC 유전자검사 허용 범위를 기존 웰니스 항목에서 질병 유사 항목까지 확대하겠다고 발표한 만큼 DTC 유전자검사에 대한 정부의 허용이 확대 기조에 있어 사전에 이러한 법적 충돌을 해소하여 DTC 유전자검사 항목의 안전성과 신뢰성을 보장할 수 있도록 법령과 가이드라인의 조정은 중요하다고 볼 수 있다.

3. 미성년자 대상 DTC 유전자검사 가이드라인의 부재

DTC 유전자검사가 시행되면서 자신의 건강과 잠재적 유전인자에 대해 관심이 높아지면서 이러한 관심이 자녀들에게까지 확대되고 있다(김명신, 2021). 2020년 2월 14일 개정된 보건복지부 고시 제2020-35호 의료기관이 아닌 유전자검사기관이 직접 실시할 수 있는 유전자검사 항목에 관한 규정에서 미성년자 대상 유전자 검사의 제한 조항이 신설되었다. 해당 조항에서는 소비자 대상 직접 유전자검사를 미성년자 등 동의능력이 없거나 불완전한 사람을 대상으로 실시하기 위해서는 실시가능 범위 및 모집방법 등을 포함한 실시방법 등에 대해 보건복지부 장관이 정하는 기준에 따라 수행할 것으로 제한하고 있다. 하지만, 아직까지 미성년자를 대상으로 하는 가이드라인은 부재한 상태이다.

미성년자에 대한 DTC 유전자검사의 해외의 규정을 살펴보면 모든 검사를 불허하는 나라부터 질병과 웰니스 항목을 분리하거나 특별한 규정을 하지 않는 국가도 있어 각 국가의 유전자 검사 규정, 사회적 문화적 배경, 윤리 요소 등 국가의 상황에 맞게 규정하고 있는 것으로 보인다(김명신, 2021).

현재 우리나라의 경우 18세 이하 청소년을 대상으로 한 DTC 유전자검사는 시행이 어려운 것으로 보이나 현재 정부가 미성년 대상 규제 항목 개선 움직임을 보여 미성년자 대상 가이드라인의 필요성이 커질 것으로 보인다. 2024년도 발표된 DTC 유전자검사 서비스를 위한 항목 신청 가이드라인(유전자검사기관용)에 따르면, DTC는 불확실한 유전정보로 인한 오도를 최소화하기 위하여 미성년자를 대상으로 하려는 경우, 미성년자를 대상으로 해야 하는 근거와 함께 서비스 하려는 대상 연령을 추가로 선택하도록 하고 미성년자를 대상으로 시행할 수 있는 과학적인 근거를 별도로 제출하도록 하고 있다. 가이드라인에 따르면 DTC 유전자검사 기관이 ‘청소년을 대상으로 연구된 관련 논문’을 제출해야 하지만, 실제 청소년을 대상으로 수행한 연구가 많지 않다. 이에 정부는 2023년 데이터 경제 활성화 추진과제로 미성년자 대상 서비스 제공을 위해 ‘미성년에 특화된 항목 유효성 근거’가 필요하다는 규제 항목을 개선하여 ‘성인 대상 항목 유효성 근거’로 규제를 완화하고 미성년 대상 동의·결과 전달 기준 등을 제출하면 검사를 받게 하는 것으로 규제 항목을 개선하겠다고 밝혔다(전자신문, 2024.01.08.⁴²⁾)

현재 보건복지부에서 2024년도에 미성년자 검사 절차 간소화 관련 연구용역을 진행할 예정이라고 발표하였다(전자신문, 2024.01.08.⁴³⁾). 이 연구용역을 통해 미성년자 대상 DTC 유전자검사 가이드라인을 발표하여 미성년자의 권익을 보호하고 신뢰성을 강화할 필요가 있다. 미성년자 대상 DTC 유전자검사 가이드라인에서는 미성년자의 유전정보가 부적절하게 사용되는 것을 미연에 방지할 필요가 있다. 또한, 유전자정보 공유 여부 등에 대한 동의를 본인이 아니라 부모가 하기 때문에 성인이 되었을 때, 관련 동의를 철회할 수 있는 방침을 마련하는 등의 추가 조치(김명신, 2021)에 대한 가이드라인 등이 제시될 필요가 있다.

42) 정부, DTC 유전자검사 ‘청소년 제한’ 일부 완화, <https://www.etnews.com/20240108000266>
(검색일자: 20240826)

43) 정부, DTC 유전자검사 ‘청소년 제한’ 일부 완화, <https://www.etnews.com/20240108000266>
(검색일자: 20240826)

제4절 가이드라인 개선방향

1. 규제의 일관성과 통합성 확보

DTC 유전자검사와 같이 바이오 분야 기술의 발전은 새로운 규제와 가이드라인의 필요성을 증대시킨다. DTC 유전자검사 사례에서 확인할 수 있듯이 의료기관과 비의료기관 사이의 규제 비대칭성은 검사 결과의 신뢰성과 활용성에서 차이를 초래할 수 있다. 이런 규제의 일관성 부족은 법적 혼란을 야기할 수 있기 때문에 규제의 일관성을 확보하기 위해 법령 내에서 상위 법령과 하위 규정간의 조화는 중요하다. 즉, 생명윤리법을 비롯한 관련 법령에서 규정간 충돌이 발생하지 않도록 법적 체계를 정비하고 명확한 기준에 근거하여 가이드라인을 검토할 필요가 있다.

DTC 유전자검사 기관은 생명윤리법 제50조에 따라 유전자를 대상으로 하는 검사를 수행하지만, 의료기관처럼 의료기기법이나 신의료기술 평가 규칙 등의 규제는 받지 않는다. 반면에 의료기관은 유전자검사를 수행하기 위해 식품의약품안전처의 인허가, 건강보험심사평가원의 검토를 받아야 한다. 즉, 의료기관과 비의료기관 간의 규제 수준이 다르게 적용된다(김훈기, 2024).

따라서 규제의 일관성을 확보하기 위해서는 동일한 목적과 기능을 가진 서비스에 한해서라도 동일한 규제 기준이 적용되도록 법령과 가이드라인을 정비하는 등의 고민이 필요하다. DTC 유전자검사 기관과 의료기관에서 수행하는 동일한 목적의 유전자검사 간에는 규제를 통일하거나, DTC 유전자검사 기관만을 대상으로 하는 가이드라인이 아니라 제공하는 서비스의 특성에 맞게 차별화된 기준을 설정하거나 가이드라인을 정비하는 것도 방법일 수 있다.

또한, 상위 법령과 하위 규정 간의 충돌을 해소하는 것도 중요한 부분이다. 현재 생명윤리법 제50조에서는 대통령령으로는 특정 유전자검사를 금지하고 있고, 동시에 보건복지부장관령에 의해 특정 유전자검사가 허용되는 상황이 발생하고 있다(김훈기, 2024). 이러한 모순은 법적 혼란을 야기할 수 있고 운영하는 과정에서 일관성을 유지하기 어렵다. 때문에, 상위법령과 하위 규정 간의 일관된 규제 체계 구축이 필요하다.

그리고 이 과정에서 가이드라인 개정이 중요하다. 가이드라인을 통해 법령에 대한 구체적인 적용과 해석을 구성할 수 있기 때문이다. 따라서 가이드라인을 개정하는 방법이 필요할 수 있다.

2. 윤리적 고려와 미성년자 등 소비자 보호의 강화

DTC 유전자검사 결과처럼 개인의 유전 정보의 경우 윤리적 고려와 소비자 보호가 중요하다. 생명윤리법 제50조에서는 과학적 증명이 불확실하거나 검사대상자를 오도할 우려가 있는 경우에 유전자 검사를 금지하고 있지만, 앞에서 살펴본 것과 같이 규제의 일관성 부족 혹은 법령간 충돌에서 소비자 보호가 충분히 이루어지지 않을 수 있기 때문이다.

유전 정보는 변화하지 않고 개인의 인권과 직결되는 민감한 정보이며, 엄격한 윤리적 기준의 적용이 요구된다. DTC 유전자검사 결과의 잘못된 해석 혹은 과대광고로 인한 소비자의 결과 오해는 소비자의 건강에 나쁜 영향을 미칠 수 있다. 때문에 DTC 유전자검사 가이드라인은 유전자검사 기술의 발전에 맞추어 소비자용 뿐만 아니라 검사기관용에서도 검사 결과를 정확히 이해할 수 있도록 상세한 설명과 해석을 제공하고 검사 결과의 한계와 위험성도 제공할 필요가 있다.

특히, 최근에 DTC 유전자검사 서비스 2차 제공과 관련한 가이드라인이 개정되었다. 그로인해 DTC 유전자검사 가이드라인에서 윤리적 고려와 소비자 보호의 중요성은 더욱 중요해졌다. 가이드라인이 개정되면서 DTC 유전자검사 결과를 기반으로 한 2차 서비스가 가능해졌기 때문이다. 이는 DTC 유전자검사 기관이 소비자에게 제공하는 정보의 범위와 활용 가능성 확대를 의미한다.

때문에 소비자 대상 가이드라인도 유전자검사 기관용 가이드라인의 변화에 맞추어 개정될 필요가 있다. 소비자 대상 가이드라인에서는 2차 서비스 제공 시 소비자가 알아야 할 정보, 결과 해석의 한계 및 위험성에 대한 경고를 강조할 필요가 있다. 또한, 소비자가 자신이 제공받는 DTC 유전자검사 서비스의 정확성과 신뢰성을 비교 혹은 검토할 수 있는 기준, 체크리스트 등을 제공하는 것도 방법일 수 있다.

미성년자 보호 또한 중요하다. 현재 미성년자를 대상으로 하는 DTC 유전자검사에 대한 가이드라인이 부재한 상태이다. 미성년자는 자신의 유전정보의 활용에 대해 충분히 이해하지 못하고 검사에 동의할 수 있다. 또한, 자신이 아닌 부모의 결정에 따라 유전자 검사를 받는다. 따라서 미성년자의 권리를 보호하고 개인정보가 부적절하게 활용되지 않도록 하는 보호 장치로 미성년자 대상의 가이드라인이 중요하다. 특히, 미성년자가 성인이 되었을 때 자신의 유전 정보 제공을 철회하거나 수정할 수 있도록 권리를 보장해주는 것도 필요하다(김명신, 2021). 미성년자가 성인이 되었을 때 자신의 유전 정보에 대한 통제권을 가질 수 있도록 하는 것이다.

DTC 유전자검사에서 윤리적인 문제를 고려하고 소비자 보호를 강화하는 것은 가이드라인의 중요한 역할이라고 생각한다. 가이드라인에서 이러한 부분에 대해 고민하고 가이드라인을 제시하였을 때, DTC 유전자 검사에 대한 신뢰성이 유지되고 기술 발전으로 인해 발생할 수 있는 윤리적 문제를 사전에 예방할 수 있을 것이다.

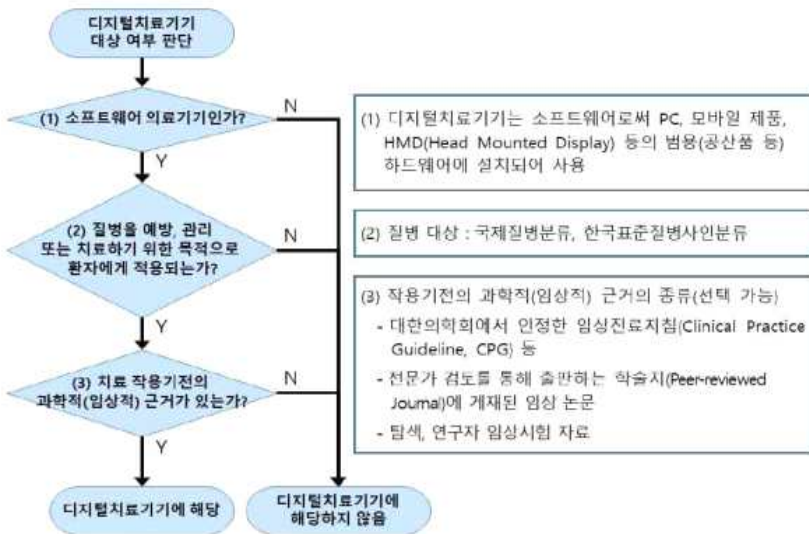
| 제6장 | [사례4] 디지털 치료기기 가이드라인

제1절 사례의 개요

1. 디지털 치료기기의 정의 및 분류 기준

한국에서 디지털 치료기기에 대한 공식적인 정의는 식품의약품안전처의 「디지털 치료기기 허가·심사 가이드라인을 따른다(심보람 외, 2022). 이 가이드라인에서는 디지털 치료기기를 '의학적 장애나 질병을 예방, 관리, 치료하기 위해 환자에게 근거 기반의 치료적 개입을 제공하는 소프트웨어 의료기기(Software as Medical Device, SaMD)'로 정의하고 있다. 이러한 정의는 국제적으로 통용되는 정의와 크게 다르지 않지만, 국내에서는 '디지털 치료기기'라는 명칭을 사용하여 이들이 의료기기의 범주에서 관리된다는 점을 강조하고 있다.

[그림 6-1] 디지털 치료기기 대상 여부 판단 기준 및 절차



자료: 식품의약품안전처(2020)

다시 말해 디지털 치료기기는 임상시험을 통한 치료 효과 증명, 의사 처방 여부, 특정 질환 치료 목적 등을 구체적으로 명시하고 있다는 점에서 일반 건강관리 애플리케이션 및 웨어러블 의료기기와 차별화된다.⁴⁴⁾ 이러한 특성을 통해 디지털 치료기기는 단순한 건강관리 도구가 아닌, 의학적 근거를 바탕으로 한 치료 수단으로서의 역할을 수행할 수 있다.

특정 질병을 대상으로 하는 애플리케이션이 증가하면서 심장박동수나 수면패턴을 측정해 생활습관 개선을 도와주는 애플리케이션이 디지털 치료기기와 유사하게 보일 수 있다. 그러나 디지털 치료기기는 임상시험을 통해 치료 효과가 입증된 제품을 의미하며, 단순히 생체 신호를 측정하거나 건강관리를 도와주는 일반 건강관리 애플리케이션과는 차별화된다. 식약처에서는 「의료기기와 개인용 건강관리(웰니스) 제품 판단 기준(지침)」에 따라 건강 및 웰니스 애플리케이션을 비의료기기인 웰니스 제품으로 분류하고 있다.

디지털 치료기기의 범위를 결정하는 중요한 요소 중 하나는 의사의 처방 여부이다. 미국에서는 의사의 처방 없이 사용되는 제품도 디지털 치료기기로 간주하지만, 처방형 디지털 기기(Prescription Digital Therapeutics, PDT)라는 개념도 사용한다. 반면, 일본은 의사의 처방이 필요한 제품만 디지털 치료기기 범주에 포함시킨다. 독일에서는 의사나 임상심리사의 처방에 따라 디지털 치료기기에 급여를 적용하지만, 환자가 적응 증에 대한 진료기록을 보험기금에 제출하면 의사 처방 없이도 급여를 받을 수 있다.

디지털 치료기기는 특정 질환이나 증상 등 적응증을 명시해야 하는 특성상, 질환 발생 이전의 일차 예방 목적의 제품은 포함되지 않는다. 독일과 한국은 치료적 개입이 필요한 환자를 대상으로 디지털 치료기기를 사용하도록 제한하고 있다. 그러나 일본에서는 금연 애플리케이션이 임상 효과에 대한 근거를 바탕으로 의사의 진단 및 처방 하에 사용되므로, 예방 목적임에도 불구하고 디지털 치료기기로 분류된다.

웨어러블 의료기기가 대중화되고 건강보험 급여 결정 사례가 등장하면서 디지털 치료기기와 혼동될 수 있다. 이 제품은 의료기기 허가를 받았고 의사의 처방에 따라 사용되기 때문에 디지털 치료기기와 유사하다. 그러나 웨어러블 의료기기는 의사의 진

44) 심보람, 주진한, 김현정, & 김병수. (2022). 디지털 치료기기의 건강보험 적용방안.

단이나 환자 상태의 모니터링을 지원하기 위한 목적이므로, 직접적인 치료적 개입을 제공하지 않기 때문에 디지털 치료기기로 분류되지 않는다.

2. 디지털 치료기기 관련 정책 추진 현황

정부는 2022년 7월 발표된 '120대 국정과제'에서 '디지털헬스 글로벌 중심국가 도약'을 목표로 디지털 헬스 산업 육성 정책을 추진 중이다. 보건복지부는 2023년 2월 '바이오 신시장 창출 전략 - 의료, 건강, 돌봄의 디지털 전환'을 발표하였는데, 주요 내용으로는 데이터 기반 의료 및 건강 돌봄 서비스 혁신, 바이오헬스 산업 수출 활성화, 첨단 융복합 기술 연구개발 강화, 바이오헬스 전문인력 양성, 창업 지원 및 법, 제도, 인프라 구축 등이 포함된다.

보건복지부는 또한 2023년 3월 제3차 규제혁신전략회의를 통해 '바이오헬스 신산업 규제혁신 방안'을 발표하였으며, 이는 디지털 치료기기를 포함한 바이오헬스 7대 핵심 분야에 대한 규제혁신을 추진하는 내용을 담고 있다. 식품의약품안전처는 디지털 치료기기 활성화를 위해 2027년까지 약 10종의 맞춤형 디지털 치료기기 임상 허가 관련 가이드라인을 추가로 개발할 예정이며, 소프트웨어와 네트워크 등 디지털 환경에 맞는 규제 프레임워크를 구축하고 규제지원 서비스를 제공할 계획이다.

디지털 치료기기는 의료기기의 한 종류로 의료기기 법령 규제를 적용받는다. 2024년 1월 시행 예정인 '디지털의료제품법'에 따라 디지털 치료기기는 '디지털의료기기소프트웨어' 및 '독립형 디지털의료기기소프트웨어'로 포함되어 해당 법령의 규제를 적용받게 된다.

기존 의료기기 법령에서는 디지털 치료기기에 대한 평가 기준이 명확하지 않아 식약처는 가이드라인을 통해 구체적인 기준을 공표하고, 기존 법제를 해석할 수 있도록 하고 있다(유성희, 이상욱, 2024). 가이드라인을 통한 규제 방식은 법령 개정보다 기술 환경 변화를 신속하게 반영할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 상위법령에 수권 조항이 없는 가이드라인을 통해 규제하는 비공식적 방식은 법적 효력 측면에서 한계가 있을 수 있다.

3. 디지털 치료기기 관련 주요 가이드라인

한국은 2018년 의료기기 정의에 소프트웨어를 포함하고, 2019년 혁신의료기술평가 제도 도입 및 의료기기 소프트웨어 허가·심사 가이드라인 발간을 통해 SaMD(Software as a Medical Device)의 시장 진입을 위한 정책을 적극적으로 추진하였다.⁴⁵⁾ 혁신의료기술평가는 임상적 근거 창출에 어려움이 있으나 사회적 요구도가 높은 혁신의료기술의 신속한 의료현장 도입을 목적으로 2019년 3월에 도입되었으며, 안전성과 잠재적 가치를 반영하여 평가하고 3-5년 후 재평가 절차를 포함하고 있다.

〈표 6-1〉 디지털 치료기기 가이드라인 발간 현황

순번	안내서	발간일자
1	디지털치료기기 허가·심사 가이드라인	2020. 8.
2	불면증 개선 디지털치료기기 안전성·성능 평가 및 임상시험계획서 작성 가이드라인	2021.12.
3	니코틴 사용장애 개선 디지털치료기기 안전성·성능 평가 및 임상시험계획서 작성 가이드라인	2021.12.
4	알코올 사용장애 개선 디지털치료기기 안전성·성능 평가 및 임상시험계획서 작성 가이드라인	2021.12.
5	우울장애 개선 디지털치료기기 안전성·성능 평가 및 임상시험계획서 작성 가이드라인	2022.12.
6	공황장애 개선 디지털치료기기 안전성·성능 평가 및 임상시험계획서 작성 가이드라인	2022.12.
7	활동성 및 주의력 장애(ADHD) 개선 디지털치료기기 안전성·성능 평가 및 임상시험계획서 작성 가이드라인	2023.12.
8	섭식장애 개선 디지털치료기기 안전성·성능 평가 및 임상시험계획서 작성 가이드라인	2023.12.
9	디지털 치료기기의 건강보험 등재 가이드라인	2023. 8.

자료: 유성희, 이상욱(2024)를 수정 및 보완

2019년 4월 의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법 제정으로 혁신의료기기로 지정된 SaMD의 신속한 허가를 위한 혁신의료기기 소프트웨어 특례 및 혁신의료기기 일반 심사 지정제도의 법적 근거가 마련되었다. 2020년 8월에는 국내 최초로 '디지털치료기기 허가·심사 가이드라인'이 발간되어 디지털 치료기기 산업의 발전 가능성을 보여주었다.

2021년부터 불면증, 니코틴 중독, 알코올 중독을 대상으로 하는 디지털치료기기 허가·심사 가이드라인이 시작되어, 2023년 10월 기준 총 5개 적응증에 대한 가이드라

45) 정지민 외(2023)의 내용을 바탕으로 정리

인이 발간되었으며, 2023년 12월에는 ADHD와 섭식장애 개선을 위한 가이드라인이 추가로 발간되었다.

2022년 혁신의료기기 통합심사·평가제도 시행으로 기존 390일이 소요되던 인허가와 혁신의료기기술평가 기간을 80일로 단축하는 제도 개선이 이루어졌고, 이를 통해 국내 1·2호 디지털치료기기는 빠르게 규제를 통과할 수 있었다. 이 제도를 통과한 디지털치료기기는 한국보건 의료연구원의 심의 및 통보를 받은 기관에서만 처방 가능하며, 2023년 10월 기준 에임메드사의 Somzz 제품은 비급여를 선택하였다.

2021년 11월 보건복지부는 제25차 건강보험정책심의회위원회를 통해 혁신의료기술에 대한 건강보험 등재 기본 원칙을 수립하였다. 디지털치료기기와 같은 SaMD는 전통적인 의료기술과 차이가 있다는 의견이 제기되어, 디지털치료기기와 인공지능(AI)을 적용한 의료기기에 적용할 수 있는 건강보험 등재 별도 방안 마련이 논의되었다. 이에 보건복지부와 건강보험심사평가원은 2023년 8월 25일 '디지털치료기기 건강보험 등재 가이드라인'을 발간하고, 2023년 10월 디지털치료기기의 구체적인 건강보험 수가안을 마련하였다.

이외에도 의료기기 허가신고심사 등 디지털 치료기기 또한 의료기기 소프트웨어이기 때문에 <표 6-2>와 같이 용도와 목적에 따라 참여해야할 가이드라인이 규정되어 있다.

<표 6-2> 디지털 치료기기 관련 기타 가이드라인

순번	안내서	발간일자
1	의료기기 허가신고심사 등에 관한 규정 해설서	2015.1
2	의료기기와 개인용 건강관리(웰니스)제품 판단기준(지침)	2015.7
3	가상·증강현실 기술 적용 의료기기 허가·심사 가이드라인	2018.6
4	빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기의 허가심사 가이드라인	2019.1
5	인공지능 기반 의료기기의 임상 유효성 평가 가이드라인	2019.1
6	의료기기 사이버 보안 적용방법 및 사례집	2019.11
7	의료기기의 실사용증거 적용에 대한 가이드라인	2019.2
8	의료기기 소프트웨어 허가·심사 가이드라인	2019.9
9	모바일 의료용 앱 안전관리 지침	2020.2
10	디지털치료기기 허가심사 가이드라인	2020.8
11	의료기기 사이버 보안 허가·심사 가이드라인	2022.1
12	의료기기 제조허가등 갱신에 관한 규정 해설서	2022.3

자료: 바이오타임즈(2022.4.12.), 「디지털 치료제의 개발 및 임상 관련 가이드라인」을 참고하여 연구진 작성
(<https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=7654> 검색일: 2024.9.28.)

제2절 주요 가이드라인

1. 디지털치료기기 허가·심사 가이드라인

식품의약품안전처는 2020년 8월 정보통신기술(ICT)의 발달로 부상하는 디지털치료기기의 허가·심사 방안을 선제적으로 마련하고, 의료기기 업체의 연구 및 개발을 지원하기 위해 '디지털치료기기 허가·심사 가이드라인'을 발간했다. 이 가이드라인은 2020년 5월 1일 시행된 '의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법'에 따라 디지털치료기기를 포함한 혁신의료기기의 신속한 허가·심사를 뒷받침하기 위한 목적으로 마련되었다.

이 가이드라인에서 디지털치료기기(Digital Therapeutics, DTx)를 정의하였는데, 이를 과학적·임상적 근거를 바탕으로 질병의 예방, 관리, 치료를 목적으로 사용하는 소프트웨어 의료기기로, 하드웨어에 종속되지 않고 독립적으로 사용되는 기기로 규정하였다. 당시 디지털치료기기는 정신·신경계 질환(약물중독, 우울증)뿐 아니라 천식, 당뇨 등 다양한 질환의 치료에 적용될 수 있다고 기대 받았으며, 기존 신약 개발에 비해 전임상 단계가 없어 비용과 시간이 적게 소요되는 것으로 예상되었다.

가이드라인의 주요 내용으로는 디지털치료기기의 제품 범위와 정의, 판단 기준, 제품 예시 등을 포함하는 기본 개념과 기술문서 작성 및 첨부자료 등 허가 심사에 필요한 절차와 내용이 포함되어 있다. 기술문서에는 제품명, 등급, 구조 및 작용 원리, 원재료, 제조 방법, 성능, 사용 목적, 사용 방법, 주의 사항, 포장 단위, 저장 방법 및 사용 기간, 시험 규격, 제조원 및 허가 조건 등의 항목이 포함되어야 한다. 첨부자료로는 이미 허가받은 제품과의 비교 자료, 사용 목적 및 작용 원리 관련 자료, 안전성 및 성능에 관한 자료, 전자파 안전 자료, 임상시험 자료, 해외 사용 현황 자료 등 다양한 문서가 요구된다.

다만 2020년 8월 '디지털치료기기 허가·심사 가이드라인'을 발간하는 등 정부 차원에서 디지털치료기기 시장에 신속하게 대응하고 있음에도 불구하고, 국내 디지털치료기기 시장은 여전히 초기 단계에 머물러 있다(이성희, 배민호, 2024). 2023년 8월

기준, 국내에서 디지털치료기기 임상시험 승인을 받은 건수는 총 47건에 달하지만, 이 중 2024년 4월 기준 실제로 디지털치료기기로 허가를 받은 제품은 단 4개에 그치고 있다.⁴⁶⁾

<표 6-3> 국내 주요 디지털 치료기기 개발사 및 제품

기업명	품목명	제품명	제품설명	임상시험 승인일
라이프스맨텍스	호흡재활	레드필 숨트	천식 치료	2021.09.03
에임메드	인지치료	숨즈	불면증 치료	2021.09.10
하이	정서장애치료	엡자이렉스	불안장애 치료	2021.12.30
웰트	인지치료	필로우 Rx	불면증 치료	2022.05.30
뉴냅스	인지치료	비비드 브레인	뇌질환 시야장애 개선	2022.08.01
이모코그	인지치료	코그테라	경도인지장애 치료	2022.09.28
메디마인드	인지치료	알코테라	알코올중독 장애 개선	2022.10.20
웨어앤서비스	호흡재활	이지브리드	호흡재활 치료	2022.11.24

출처: Reproduced with permission from [1].

2. 디지털 치료기기의 건강보험 등재 가이드라인

디지털 치료기기의 건강보험 등재 가이드라인은 디지털 헬스케어 기술의 신속한 도입과 활용을 지원하기 위해 2023년 8월 25일 건강보험심사평가원에 의해 발표되었다. 이 가이드라인은 디지털 치료기기와 인공지능(AI) 의료기기의 건강보험 적용 과정을 명확히 하고, 혁신의료기술의 시장 진입과 활용을 촉진하는 것을 목적으로 한다.

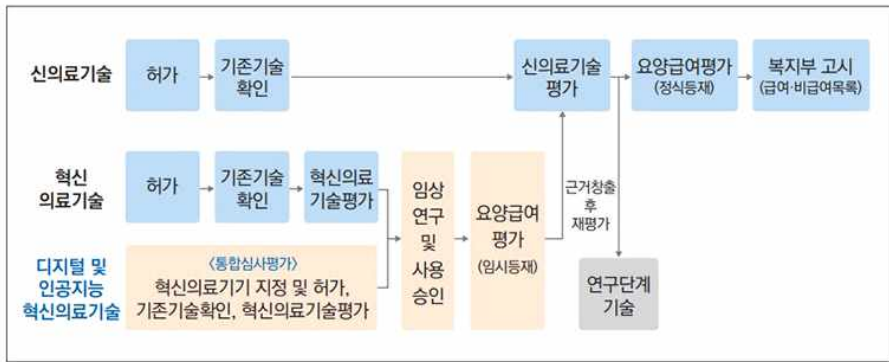
가이드라인에 따르면, 디지털 치료기기의 건강보험 등재 절차는 크게 통합심사·평가, 요양급여여부 임시 등재 평가, 신의료기술 재평가, 요양급여여부 정식 등재 평가의 4단계로 이루어진다. 먼저, 관계부처가 혁신의료기기의 지정 및 인허가를 동시에 진행하는 통합심사·평가를 통해 평가 기간이 390일에서 80일로 단축된다. 다음으로, 혁신의료기기로 고시된 디지털 치료기기는 임시적으로 건강보험 적용을 받으며, 이

46) 청년의사(2024. 4. 19), 국내 3호4호 디지털 치료기기 허가…치료 질환 확대 (<https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3016610>, 검색일 2024. 9. 29.)

기간 동안 근거를 창출하고 임상 효과를 확인한다. 업체는 급여 또는 비급여 여부를 선택할 수 있다. 이후, 사용 기간 종료 전후로 신의료기술 재평가를 받게 되며, 마지막으로 임시 등재 기간 동안 축적된 근거를 바탕으로 경제성과 급여의 적정성 등을 평가하여 정식 등재 여부를 결정하게 된다.

임시 등재 기간 동안에는 임시코드가 부여되고 수가가 적용되며, 이 동안 업체는 충분한 근거를 창출해야 한다. 비급여를 선택한 경우에는 비급여 금액을 신고하고 공개해야 하며, 사후 모니터링을 통해 급여 기준 설정 및 비급여 제한을 검토하게 된다. 신의료기술 평가는 사용 기간 종료 전후로 진행되며, 평가 결과에 따라 정식 등재 여부가 결정된다. 정식 등재를 위한 요양급여여부 평가에서는 임시 등재 기간 동안 축적한 근거를 기반으로 안전성, 유효성, 경제성, 급여 적정성 등을 평가하며, 건강보험정책심의위원회의 심의 및 의결을 거쳐 복지부 장관이 고시하게 된다.

[그림 6-2] 디지털 치료기기 건강보험 등재절차



자료: 보건복지부, 건강보험심사평가원(2023), 「디지털치료기기 건강보험 등재 가이드라인」, p. 5.

제3절 디지털 치료기기 가이드라인의 성과와 한계

1. 주요 성과

디지털 치료기기는 신속한 환경 변화 대응, 체계적인 관리, 통합 심사·평가 제도, 건강보험 적용 및 활용 확대, 관련 법 제정 움직임 등을 통해 의료 기술 발전과 국민 건강 증진에 기여하고 있다. 먼저 ‘디지털치료기기 허가·심사 가이드라인’을 통해 법령 개정 없이도 빠르게 변화하는 기술 환경을 반영할 수 있게 되었다. 이는 산업계가 신속하게 변화하는 의료기기 시장에 대응할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의의가 있다. 또한, 디지털 치료기기를 별도로 분류하고 안전성 및 유효성을 고려한 품목 분류 체계를 마련함으로써 체계적인 안전관리 및 정보 제공이 가능해졌다(유소미, 2024). 다음으로 가이드라인이외에도 혁신의료기기 통합심사·평가제도를 통해 기관별로 순차적으로 진행되던 허가과 심사 절차를 통합함으로써 제품의 시장 진입 기간이 크게 단축되었다. 이는 혁신적인 의료기술의 신속한 현장 활용을 가능하게 하는 데 기여했다(정준화 2023).

또한, 디지털 치료기기의 건강보험 급여 등재 가이드라인이 마련되어 제품의 건강보험 내 활용 및 평가가 가능해졌다. 임시 등재 단계에서 급여 또는 비급여의 선택권을 부여함으로써 디지털 치료기기의 활용성을 높이는 데 기여했다. 마지막으로 ‘디지털의료제품법’이 국회 본회의를 통과함에 따라 디지털 치료제에 대한 제도적 지원 및 안전관리가 강화되고 있다(의사신문, 2024.7.31). 이와 같이 디지털 치료기기는 다양한 제도적 지원과 가이드라인을 통해 신속한 시장 진입, 체계적인 관리, 건강보험 적용 확대 등의 성과를 거두고 있다.

2. 한계

디지털 치료기기는 혁신적인 의료 기술로 주목받고 있지만, 현재의 가이드라인과 제도적 환경에는 개선이 필요한 부분이 존재한다. 이러한 한계점은 크게 중복 규제, 보험급여 체계, 의료환경에서의 현실적 적용, 안전관리 종합계획, 그리고 약사 및 의

료진의 역할 명확화 등으로 나누어 살펴볼 수 있다. 먼저, 디지털 치료기기는 허가 단계에서 임상시험 자료를 제출했음에도 불구하고 신의료기술평가 시 또다시 임상자료를 제출해야 하는 중복 규제의 문제가 있다(데일리팜, 2024.3.28), 이는 기업의 행정 부담을 가중시키고 제품 개발 및 출시를 지연시키는 요인으로 작용한다. 따라서 허가 단계와 신의료기술평가 간의 자료 제출 절차를 통합하고 일원화하여 중복 규제를 해소할 필요가 있다. 다음으로, 디지털 치료기기의 보험급여 체계에 대한 개선이 필요하다. 현재의 급여 적용 범위, 원가 산정 방식, 수가 보상 등이 산업계의 현실과 괴리되어 있으며, 특히 소프트웨어 특성상 유지보수 및 업데이트에 대한 비용 보상이 고려되지 않고 있다(데일리팜, 2024.3.28), 이를 해결하기 위해서는 디지털 치료기기의 특성에 맞는 원가 산정 방식 및 수가 체계를 마련하고, 독일의 DiGA 모델과 같이 우선 보험에 등재한 후 사후평가를 진행하는 방식 도입을 검토할 필요가 있다.

또한, 의료 현장, 특히 의원급 의료기관에서 디지털 치료기기를 사용하는 데 있어 환자 교육 및 상담 등에 따른 추가적인 진료 비용에 대한 보상 방안이 명확하지 않아 현실적인 적용에 어려움이 있다. 이를 해결하기 위해서는 디지털 치료기기 처방 시 초기 환자 교육 및 상담 비용을 별도로 보상하는 정책을 수립하고, 의료진과 환자의 사용을 촉진할 수 있는 지원책을 마련해야 한다.

마지막으로, 일부 디지털 치료기기는 약물과 의료기기의 특성을 동시에 보유하고 있어 약사 및 의료진의 역할에 대한 혼란이 있다. 이를 해결하기 위해서는 약사가 디지털 치료제 개발, 관리, 사용 과정에 어떻게 관여해야 하는지에 대한 구체적인 가이드라인을 수립하여 약사의 관여 범위와 역할을 명확히 설정해야 한다는 약사계의 요구도 있다(팜뉴스(2023.5.23.)). 그리고 한국의 건강보험 체계가 전통적인 의료기기 및 약물에 기반하고 있어 소프트웨어 의료기기인 디지털 치료제와 잘 맞지 않는 문제를 해결하기 위해 디지털 치료기기만을 위한 별도의 보험급여 체계를 구축될 필요도 제기되고 있다(메디파나뉴스(2023.12.1.)). 이 체계는 디지털 치료기기의 사용료, 유지보수, 업데이트 비용을 포함하는 포괄적인 보험급여 모델을 개발하고, 선진입 후평가 방식을 도입하여 신속한 시장 진입을 지원하며, 사후평가를 통해 급여 적용 여부를 재평가하는 내용을 포함해야 한다.

제4절 소결: 이슈와 시사점

1. 가이드라인의 법적 구속력 이슈

디지털 치료기기 가이드라인은 빠른 혁신이 이뤄지고 있는 디지털 치료기기의 발전을 위해 상위 법령이 직접 다루지 않는 많은 세부 사항들에 대한 구체적 지침을 제공하는 역할을 수행하고 있다. 실질적으로 보아도 기술 변화가 빠르기에 기존 의료기기 규제 체계로만은 이러한 변화를 효과적으로 규제하기 어렵다. 가이드라인은 행정 규칙의 일종으로, 상위 법령이 포괄적으로 위임한 영역을 세분화하고 구체화함으로써 산업의 신속한 발전을 지원하고 안전성을 확보할 수 있다. 구체적인 지침을 제공함에 따라 산업계의 구성원들의 활동에 있어 불확실성을 줄일 수 있기 때문이다. 그리고 가이드라인은 법령의 개정 없이도 기술 환경 변화를 신속하게 반영할 수 있기 때문에, 빠르게 발전하는 디지털 치료기기 분야에서 유연하고 실효성 있는 규제를 가능하게 한다. 예를 들어, 식약처의 디지털 치료기기 허가·심사 가이드라인은 해당 기기의 안전성, 유효성, 임상적 근거를 신속하게 평가하고 승인하는 기준을 제공하여 기업들이 보다 명확한 규제 환경에서 제품을 개발하고 출시할 수 있도록 돕는 것이다.

하지만 가이드라인은 법적 지위를 갖지 못하기에 기업과 개발자들에게 가질만한 구속력을 가지지는 못하고 있다. 그러나 이 가이드라인이 법적 지위를 가지더라도, 상위 법령과의 부정합성이나 구속력의 한계가 발생할 수 있다. 그렇기에 기술의 변화와 관련 법제도의 변화에 따라 가이드라인 자체에 대한 지속적인 재검토와 개정이 필요할 수 있다.

2. 가이드라인의 중복 규제와 복잡성 증가

최근 식품의약품안전처는 생성형 AI의 발전에 따라 인공지능 기기의 다양한 산업 적용 추세에 대응하고자 ‘생성형 AI 기반 디지털 의료기기 허가·심사 규제 가이드라인’을 준비하고 있다(의학신문, 2024.5.2.). 이러한 방식으로 새로운 가이드라인이 계

속 만들어지만 최초의 신속한 대응과는 다른 규제의 중복, 복잡성 증가, 그리고 현장의 혼란을 초래할 수 있다.

따라서 이러한 복잡성을 줄이기 위해 가이드라인의 가이드라인, 포괄적인 상위 가이드라인이 필요할 수 있다. 개별 기술마다 새로운 가이드라인을 만들기보다는, AI 의료기기에 대한 포괄적인 상위 가이드라인을 우선 수립하는 것이 중요합니다. 이 상위 가이드라인은 다양한 AI 의료기기 분야(생성형 AI 포함)에 적용할 수 있는 일반 원칙과 기준을 제시하는 식이 될 수 있다. 이 경우 장기적으로 법제화를 염두에 둘 수 있다.

그리고 의료기기 가이드라인을 일목요연하게 분류하고 관리하는 체계적인 틀이 대안이 될 수 있다. 이를 위해 가이드라인의 주요 분야별(예: 디지털 치료기기, AI 의료기기 등)로 체계를 구축하고, 해당 분야에서 새로운 가이드라인이 발간될 때 이를 어떻게 기존 체계에 포함시키고 업데이트할 것인지 명확한 기준을 마련하는 것이다.

그렇지만 반대로 기존의 가이드라인의 개정과 통합을 위해 이력을 관리하고 적절한 폐기 절차를 만들고 수행해야 한다. 예를 들어, '생성형 AI 기반 의료기기'를 위한 가이드라인을 만들기보다는 기존 'AI 의료기기 허가·심사 가이드라인'을 확장하여 생성형 AI의 특수성을 포함하도록 개정하는 것이 바람직할 수 있다. 다시 말해 새로운 가이드라인이 만들어질 때, 기존 가이드라인과의 중복성을 검토하고, 필요하다면 기존 가이드라인을 폐기하거나 업데이트해야 한다. 그리고 사용자들에게 어떤 가이드라인이 현재 유효하며, 과거 가이드라인과 어떻게 달라졌는지 이력 정보를 명확하게 제공하는 시스템을 구축하는 것이 혼란을 줄일 수 있다.

| 제7장 | 가이드라인의 적절한 활용 방안

제1절 전문가 서면 자문 결과

1. 전문가 서면 자문 개요

본 연구에서는 가이드라인의 법적 지위에 대한 정확한 이해를 얻고자 법률 전문가들에게 자문을 구했다. 주로 행정법을 전공한 법학과/법학전문대학원 교수들과 연구기관 소속의 연구자들에게 자문을 의뢰했고, 정확한 의견 개진과 신속한 의견 수렴을 위해 서면 자문 방식을 사용했다. 15명의 법률 전문가들에게 e-mail로 서면 질의서를 보내서 13명으로부터 회신을 받았다. 질의서는 먼저 3개 부처의 가이드라인 전수조사 결과를 포함한 기초 분석 결과를 7쪽 분량으로 요약해서 설명한 후 6개의 질문을 제시하는 형태로 만들어졌다. 아래 <표 7-1>은 자문에 응해준 전문가 목록이고, <표 7-2>는 6개의 질문 목록이다(질의서의 앞부분 설명은 생략함).

<표 7-1> 가이드라인에 대한 전문가 서면 자문 응답자

번호	이름	약칭	소속 직급
1	○○○	학계 전문가1	(수도권) ○○대학교 법학부 교수
2	○○○	학계 전문가2	(영남권) ○○대학교 법학전문대학원 교수
3	○○○	학계 전문가3	(수도권) ○○대학교 법과대학 명예교수
4	○○○	학계 전문가4	(충청권) ○○대학교 법학전문대학원 교수
5	○○○	학계 전문가5	(호남권) ○○대학교 법학과 교수
6	○○○	학계 전문가6	(수도권) ○○대학교 법학과 교수
7	○○○	학계 전문가7	(수도권) ○○대학교 법학전문대학원 교수
8	○○○	학계 전문가8	(호남권) ○○대학교 법학전문대학원 교수
9	○○○	학계 전문가9	(호남권) ○○대학교 법학과 교수
10	○○○	학계 전문가10	(수도권) ○○대학교 법학전문대학원 교수
11	○○○	학계 전문가11	(수도권) ○○대학교 행정대학원 명예교수
12	○○○	연구기관 전문가1	○○연구원 연구위원
13	○○○	연구기관 전문가2	○○연구원 선임연구위원

자료: 연구진 작성

〈표 7-2〉 가이드라인에 대한 전문가 서면 자문 질의서

- Q1. 이상의 분석 결과로 볼 때 가이드라인을 법령보충적 행정규칙으로 볼 수 있을까요? 다음 보기 중 하나를 택하시고 왜 그렇게 보시는지 설명을 부탁드립니다. ()
- ① 대부분의 가이드라인은 법령보충적 행정규칙으로 볼 수 있다.
 - ② 대부분의 가이드라인은 행정규칙이 아니다.
 - ③ 부처마다, 가이드라인마다 다르다. 어떤 것은 법령보충적 행정규칙이고 어떤 것은 행정규칙이 아니다.
 - ④ 기타()
- Q2. 식약처는 가이드라인이 상위 법령의 해설서일 뿐이고 법적 효력은 없다는 점을 강조하고 있습니다. 그러나 인허가 관련 법령의 해설서라는 특성으로 인해 민원인들은 식약처의 가이드라인을 최선을 다해 준수하고 있습니다.
- Q2-1. 이런 경우 형식적 기준에 따라 법적 효력이 없는 해설서로 보는 것이 적절할까요, 아니면 실질적 효과를 보고 법령보충적 행정규칙으로 보는 것이 적절할까요?
- Q2-2. 식약처는 가이드라인이 법적 구속력이 없는 해설서라고 주장합니다. 그러나 실질에 있어서는 가이드라인의 법적 강제력이 작동하는 것으로 보입니다. 만일 식약처의 가이드라인을 행정규칙으로 유권해석한다면 법제처의 사후심사 대상이 됩니다. 만일 법제처가 식약처의 가이드라인의 법적 지위에 대해 자문을 요청한다면, 귀하는 법제처에 어떤 법률적 조언을 하시겠습니까?
- Q3. 앞으로 기술이 발전할수록 전문적·기술적 내용을 법령에 담아야 하는 수요가 증가할 것으로 예상되고, 그에 따라 가이드라인 형식의 탄력적인 입법 방식에 대한 수요도 증가할 것으로 보입니다. 이 경우 가이드라인이 법적 구속력을 지니느냐의 문제가 중요한 이슈가 될 것 같습니다. 다음 중 어느 방향이 더 좋다고 보시는지 선택해주시고 이유도 설명해주시기 바랍니다. ()
- ① 상위 법령에서 법적 강제력에 관한 내용을 최대한 담고 가이드라인에 법적 구속력이 있는 내용을 위임하는 것은 최소화
 - ② 상위 법령에서 적절한 범위 내에서 가이드라인에 위임을 하고 가이드라인이 실질적으로 법적 구속력을 가지도록 하자.
 - ③ 기타
- Q4. 신기술 분야 가이드라인의 실효성을 높이기 위해서는 어떤 방향의 변화가 필요할까요? 예를 들어 가이드라인에 벌칙에 관한 조항을 넣어서 가이드라인을 준수하지 않는 사람에게 제재를 가할 수 있도록 하는 것이 필요할까요?
- Q5. 행정규칙은 법제처의 사후심사를 통해 관리되고 있습니다. 가이드라인도 남발과 오용을 막고 효율적 운영을 위해 부처 단위에서, 그리고 범부처 차원에서 관리체계가 확립될 필요가 있습니다. 가이드라인의 관리를 더 체계적으로 하기 위한 방법을 제안해주신다면 다음 방안들 외에 어떤 방안이 있을까요?
- 부처의 자체 등록번호 부여, 가이드라인 제/개정 점검표 작성 의무화, 가이드라인 제정/개정/폐기의 자체 기준과 절차 마련, 가이드라인의 제정/개정/폐기 이력 공개, 매년 부처 전체의 가이드라인 목록 확정 공개, 가이드라인의 법적 효력에 대해 명시, 상위 법령에 위임 조항 명시, 가이드라인에 근거 법령 명시
- Q6. 기타 가이드라인의 법적 지위, 상위법의 위임과 법적 구속력, 실효성 강화 방안 등과 관련해서 제언하고 싶으신 내용이 있으시면 자유롭게 말씀하여 주시기 바랍니다.

질의서는 6개의 질문으로 구성되어 있지만 실질적으로는 3가지 질문을 다루고 있다고 볼 수 있다. 즉 6개의 질문은 가이드라인의 법적 지위(Q1~Q2, Q6), 가이드라인의 실효성 제고 방안(Q3~Q4), 가이드라인의 투명한 관리 방안(Q5)으로 묶을 수 있다. 이하에서는 법률 전문가들의 응답을 이 3가지 주제로 나누어서 정리했다.

2. 가이드라인의 법적 지위에 대한 전문가 의견

당초 전문가 서면 자문을 기획할 때, 연구진은 각 부처의 가이드라인들이 동일한 법적 지위를 가지지 않고, 행정규칙과 행정규칙 아닌 일반 문서가 섞여 있으며, 행정규칙 중 일부는 법령보충적 행정규칙이라는 인식 하에 질의서를 만들었다. 그러나 전문가들은 대부분 이런 인식에 동의하지 않았다. 13명의 응답자들은 모두 가이드라인의 법적 지위에 대한 판단은 개별 가이드라인의 내용에 따라 달라진다고 전제하면서도, 가이드라인을 행정규칙으로 보는 입장은 소수였고, 법적 구속력이 없는 행정지도, 법령해석규칙, 해설서 등으로 보는 입장이 다수였다. 특히 문서 내에서 명시적으로 법적 구속력을 부인하고 있는 식약처의 가이드라인들은 행정규칙이 아니며, 이를 명시적으로 표기하고 있는 식약처의 태도는 바람직한 것이고, 민원인들이 식약처의 가이드라인을 잘 준수한다는 사실과 가이드라인의 법적 지위는 별개의 문제라고 보았다. <표 7-3>과 <표 7-4>에 가이드라인의 법적 지위에 대한 전문가들의 답변을 요약해서 정리했다. 이 내용을 다시 세 가지로 구분해서 정리하면 다음 가~다 항과 같다.

<표 7-3> 가이드라인의 법적 지위에 대한 전문가들의 답변 요약

약칭	가이드라인의 법적 지위에 대한 의견
학계 전문가1	가이드라인의 법적 지위는 가이드라인마다 다르다. 상위 법령에 직접 위임근거가 명시되어 있고 또한 가이드라인에서 정한 것들이 국민의 권리를 제한하고 의무를 부과하는 경우에는 상위법령과 결합하여 법령보충적 행정규칙이 될 수 있다.
학계 전문가2	가이드라인이 법령보충적 행정규칙인지 여부는 획일적으로 확인할 수는 없고, 개별 가이드라인의 구체적인 내용을 파악해서 판단해야 한다. 가이드라인'이 가지는 성격을 고려하면 법령보충적 행정규칙이 되는 경우는 거의 없다고 보아야 한다.
학계 전문가3	식약처의 「가이드라인」은 원칙적으로 행정규칙에 해당하나, 그것이 법령의 위임에 따라 법령을 보충하여 법규사항을 정하고 있는 경우에는 법률보충적 행정규칙에 해당한다고 볼 여지가 있다.

약칭	가이드라인의 법적 지위에 대한 의견
학계 전문가4	• 법제처의 '국가법령정보센터'에서 검색되고 제목에 예규, 훈령, 고시 등이 표시되어 있는 가이드라인은 행정규칙으로 봐야 한다. • 내/외부적 구속력이 없는 권고적 성격의 문서는 행정지도이며, 행정규칙이 아니다. • 행정규칙의 성질을 갖는 가이드라인 중에 법령의 위임을 받은 경우에는 법령보충적 행정규칙의 성격도 가질 수 있지만, 현재로서는 이에 해당하는 가이드라인은 찾기 어렵다. • 식약처의 가이드라인은 법적 효력이 없는 해설서로서 일종의 행정지도 안내서이다.
학계 전문가5	• 가이드라인이 전문적·기술적 내용을 다루고, 업무의 성질상 위임이 불가피하며, 상위 법령으로부터 명시적 위임이 있는 경우에 법령보충적 행정규칙이라고 볼 수 있다는 설명은 타당하지만, "민원안내서"가 행정규칙 또는 가이드라인에 해당하는지는 의문이다.
학계 전문가6	• 정부의 가이드라인 중에 상위법에서 위임 없이도 만들어지는 것들이 있는데 이 경우는 행정규칙이 아니라 행정지도의 성격을 갖는 것으로 보는 것이 맞다.
학계 전문가7	• 가이드라인은 다양한 목적으로 다양한 내용으로 제정되고 그 제정절차도 상이하기 때문에 일률적으로 그 성격을 논하기는 어렵다. 그러나 대부분 이른바 비공식적 행정작용에 속하는 단순 정보제공이거나, 또는 행정기관이 그 소관 사무의 범위에서 일정한 행정목적 을 실현하기 위하여 특정인에게 일정한 행위를 하거나 하지 아니하도록 지도, 권고, 조언 등을 하는 행정지도(행정절차법 제2조 제3호)에 해당한다고 보아야 한다.
학계 전문가8	• 형식적으로나 실질적 기준으로 볼 때, 가이드라인은 행정입법인 행정규칙이 아니라 법해 석(법해설)의 형식과 내용을 갖는다. • 질문에 대한 답변으로 '② 대부분의 가이드라인은 행정규칙이 아니다'를 선택하였지만, 당위적으로는 '가이드라인은 행정규칙이 아니어야 한다'고 생각한다. 즉, 민원인과 일선 담당자를 위한 해석서(해설서)의 지위를 명확히 하는 것이 필요하다. 이는 규범의 단계적 질서와 법리적 이유에서도 타당한 것으로 생각한다.
학계 전문가9	• 현재 대부분의 가이드라인은 법령보충적 행정규칙은 물론 (일반) 행정규칙으로도 볼 수 없는바, 즉 제도적 의미에서의 행정입법(법규명령 + 행정규칙)이 아니며, 드물게 요건 이 충족되는 경우 행정규칙이나 법령보충적 행정규칙이 될 수도 있으나, 현재 연구진에서 제시한 가이드라인의 경우 법령보충적 행정규칙이라고 볼 수 있는 것은 없다고 보임
학계 전문가10	• 가이드라인이 법령보충적 행정규칙으로서 법규성을 가지려면 ① 상위법령의 위임이 있어야 하고(즉, 해당 사항을 규정할 수 있도록 하는 권한을 법령이 수권하여야 하고), ② 상 위법령의 내용을 보충·구체화하는 것이어야 하며, ③ 상위법령의 위임의 범위를 벗어나 지 않아야 하고, ④ 나아가 위임하는 상위 법령도 포괄위임금지원칙 등 그 위임입법의 한계를 지켜야 한다. 그런데 다른 요건들은 차치하고, 법령이 가이드라인에 그 보충권한 을 위임(위 ①)한 경우가 있는지 의문이다. 만약 이것조차 인정되지 않는다면 더 나아가 살펴 볼 것도 없이 법령보충적 행정규칙에 해당하지 않게 된다.
학계 전문가11	• 식약처가 가이드라인 아래 안내문을 넣어 밝히고 있는 바와 같이 상위법령으로부터 수권 (위임)이 없는 한 법령보충적 행정규칙으로 볼 수 없고 따라서 법적 구속력이 없는 참조 문서에 지나지 않는다.
연구기관 전문가1	• 부처마다, 가이드라인마다 다르다. 보건복지부 가이드라인 중 위반시 상위법상 처벌이나 제재가 가능한 경우는 행정규칙으로 봐야 하고, 보도자료에 고지된 가이드라인은 행정규 칙이라 보기 어렵다.
연구기관 전문가2	• 법령보충적 행정규칙의 개념 징표로서 가장 중요한 것은 상위법령의 위임 여부이므로 어 떤 가이드라인이 법령보충적 행정규칙의 성질을 가지느냐를 결정함에 있어서는 상위법령 의 위임 여부를 살펴야 할 것이고, 모든 가이드라인에 대해서 일률적으로 법령보충적 행 정규칙이다 아니다를 결정하는 것은 곤란

자료: 연구진 작성

<표 7-4> 국민의 준수 여부는 가이드라인의 법적 지위와 무관

약칭	국민의 준수 여부와 가이드라인의 법적 지위는 무관하다는 의견
학계 전문가2	법령보충적 행정규칙은 이는 매우 엄격한 요건 하에서 예외적으로 인정하는 것이므로, 민원인들이 잘 준수한다는 사실상의 상황만으로 이를 인정할 수 없고, '상위 법령과의 연계' 등 법령보충적 행정규칙의 요건이 모두 충족되어야 한다.
학계 전문가4	행정지도의 경우에도 엄청난 실질적 강제력을 갖는 경우가 많지만 이를 가지고 법규성의 특징으로 보지는 않는다. 법규성이란 '국민에게 구속력을 가지고, 재판의 기준이 되는 경우'를 말하는데, 가이드라인은 법적 구속력을 인정하기 힘들고, 가이드라인을 준수했다고 적법하고 위반했다고 해서 위법하다고 판단하는 재판의 기준이 되지도 않는다. 실질적 강제력과 법규성은 다소 다른 개념으로 판단된다.
학계 전문가9	법적 강제력처럼 보이는 부분은 다만 가이드라인의 내용이 인·허가 등을 위한 상위 법률 및 법규명령의 내용을 포함하고 있는 결과에 불과하며, 가이드라인 자체에는 아무런 법적 효력은 없음
학계 전문가10	실질적 효과를 보고서 법령보충적 행정규칙으로 보는 것은 '법적 효력'의 의미를 오해한 것이다. 행정규칙이 가지는 사실상의 효력에 착안하여 그 법규성을 인정하려는 견해가 오래전 과거에 있었지만, 적어도 현재의 일반적인 견해는 아니다.

자료: 연구진 작성

가. 가이드라인은 법령보충적 행정규칙이 아니다.

[학계 전문가 10]의 자문 내용에 따르면, 행정규칙이 법령보충적 행정규칙이 되기 위해서는 다음 4가지 조건이 충족되어야 한다. ① 상위법령의 위임(법령보충권한의 수권)이 있어야 하고, ② 상위법령의 내용을 보충·구체화하는 것이어야 하며, ③ 상위법령의 위임의 범위를 벗어나지 않아야 하고, ④ 상위법령도 구체적으로 범위를 정하여 위임하는 등 위임입법의 한계를 지켜야 한다. 특히, 행정규칙이 법령의 위임(수권) 없이 제정되거나 위임범위를 벗어난 경우에는 법규명령의 효력을 가질 수 없다.

가이드라인의 경우에도 그것이 법령보충적 행정규칙으로서 법규성을 가지려면 이 4가지 조건을 충족해야 한다. 그러나 법령이 가이드라인에 그 보충권한을 위임한 경우는 사실상 없기 때문에 ①번 조건부터 충족하기가 어렵다. “OO은 가이드라인으로 정한다.”라는 법령 규정을 발견하기 어렵고, “OO은 대통령령(또는 총리령, 부령)으로 정한다.”거나 “OO은 고시로 정한다.”라는 법령 규정이 있다면, 해당 사항을 가이드라인으로 정할 수는 없다. “OO은 □□부 장관이 정한다.”라는 식의 법령의 규정이 있는 경우라면 가이드라인으로 제정할 수 있지만, 실제로는 고시, 예규, 훈령과 같은 기존

의 전형적인 행정규칙 형태가 있으므로 가이드라인으로 정할 필요가 없다. 따라서 현재로서는 가이드라인이 법령보충적 행정규칙이 될 가능성은 매우 낮다.

나. 가이드라인은 행정규칙도 아니다.

[학계 전문가 7]과 [학계 전문가 9]의 의견에 따르면 가이드라인은 법령보충적 행정규칙이 아닐뿐더러 일반적인 행정규칙도 아니다, 행정규칙은 행정조직 내부의 관계를 규율하는 일반·추상적 규범으로 정의되며, 상급행정기관이 하급행정기관에 대하여 사무처리기준과 절차를 정하는 것이다. 따라서 행정규칙의 수범자는 행정기관이다. 이에 비해 가이드라인은 기본적으로 행정기관 내부가 대상이 아니고 일반 국민들을 대상으로 하며, 대부분 특정한 사안에 대한 행정청의 입장을 설명하거나 행정 행위와 관련된 정보를 제공함으로써 국민들의 행위를 일정한 방향으로 유도하고자 하는 지도, 권고, 조언을 그 내용으로 한다. 따라서 가이드라인은 행정절차법 제2조 제3호에 나오는 행정지도로 보거나, 법령이나 정책에 대한 해설서나 안내서로 보는 것이 타당하다는 것이 전문가들의 입장이다.

다. 가이드라인은 행정규칙이 아니어야 한다.

[학계 전문가 8]과 [학계 전문가 9]은 현실적으로 볼 때 가이드라인은 행정규칙이 아니지만, 당위적으로도 행정규칙이 아니어야 한다고 보았다. 즉, 가이드라인과 행정규칙을 개념적, 기능적으로 명확히 분리하는 것이 기존 법체계의 단계적 질서를 유지하고 국민의 혼란을 최소화할 수 있다고 보았다. 가이드라인의 기능은 현행 법률, 법규명령, 행정규칙 등 법규정들을 국민들의 해석과 적용이 용이하도록 평이한 내용으로 설명하고 안내하는 기능에 국한하는 것이 적절하고, 가이드라인 자체를 법제도상 또는 법체계상 또다른 하나의 입법형태나 형식으로 만드는 것은 불필요하다는 것이 전문가들의 생각이다. 기술 변화로 인해 보다 “탄력적인 입법방식”이 필요하다면 현행 법령보충적 행정규칙의 입법 방식을 통해서도 해결할 수 있을 것으로 보았다.

3. 가이드라인의 실효성 제고 방안

가이드라인의 실효성을 제고하기 위해 법적 구속력을 추가하는 방안, 즉 가이드라인을 위반하는 경우에 대한 제재 조항을 추가하는 것에 대해 자문에 참여한 모든 전문가들은 한 마디로 펄쩍 뛰는 반응을 보였다. 법 위반에 대한 법적 제재 조치는 죄형법정주의에 따라 오직 법률로만 정할 수 있고, 만일 가이드라인에 제재 조항을 넣는다면 그 자체로 위헌이 될 수 밖에 없으며, 행정부가 자의로 제재 조항을 넣는 것은 오랜 시간을 거쳐 형성된 민주적 삼권분립의 원칙을 훼손하는 중대한 의미도 있다는 것이 전문가들의 의견이었다. 이러한 사항은 법률가들에게 너무 기초적인 내용인 반면, 실제 가이드라인을 만들거나 그것을 준수하려는 민원인들은 모두 한번쯤 생각해본 대안이라는 사실은 법률 전문가들의 전문적 지식과 일반 국민의 인식 사이에 상당한 거리가 있음을 보여준다.

[학계 전문가 7]은 더 나아가 가이드라인의 법적 구속력이 없다는 점이 그 본질적인 특성이고 장점이라고 보았다. 그에 따르면 가이드라인은 법령의 내용을 국민이 알기 쉽게 설명하거나 그 법령을 준수하는 방법을 안내해주는 역할을 하는데, 이러한 해설이나 안내는 여러 대안(방법, 해설) 중 하나에 불과하고, 가이드라인에서 제시된 의미나 방법은 아니지만 여전히 법령을 충족시키는 다른 대안이 존재할 수 있다. 따라서 국민은 여러 다양한 방법 중 하나를 택해서 법령을 준수할 수 있어야 하므로 특정 가이드라인의 준수 여부에 대해 제재 조항을 넣어서는 안 된다. 또한 기술 발전에 따라 어제의 가이드라인으로 권고한 사항을 내일 바꿔야 할 수도 있다. 이렇게 보면, 가이드라인이 제재 조항을 가지지 않고 법적 구속력이 없는 것은 가이드라인의 약점이 아니고 강점이자 본질에 해당한다.

4. 가이드라인의 관리 방안

전문가들은 가이드라인이 법적 효력이 없으므로 행정규칙과 유사한 관리가 필요하지는 않다고 보았다. 대신 가이드라인의 생성 과정에 더 주의하는 것이 필요하다고 보았다. 예를 들어 [학계 전문가 10]은 다음과 같이 3가지 측면의 관리를 제안했다.

① 해당 분야의 전문가의 참여를 통해 해당 분야의 행정목적 달성의 측면에서 ‘합리성·타당성’을 확보하기 위해 노력한다. ② 법률전문가 자문 등을 통해 법적인 측면에서 ‘합헌성·합법성’을 확인하여야 한다. ③ 급변하는 상황변화에 대처해야 하므로 ‘현재의 정확성’이 담보되어야 한다. 기술진보 및 사실관계의 변화 등을 즉시 반영 반영할 수 있도록 온라인 형태로 수시 업그레이드되어 제공될 필요성이 있고, 어떤 형태이든 반드시 ‘기준 시점’ 및 ‘추후 변경될 수 있다’는 주의 문구 등이 필요하다.

이 외에 현재 식약처가 시행 중인 사항들도 추천되었다. 즉 가이드라인의 법적 효력을 포함한 법적 성격과 지위, 관련 법령과의 관계 등에 대한 공지가 필요하다고 보았다.

제2절 가이드라인의 적절한 활용을 위한 제언

1. 가이드라인에 대한 기대와 법적 현실

가이드라인의 제공자와 수요자들이 기대하는 가이드라인의 용도와 지향점은 크게 4가지로 정리될 수 있다. 첫째, 구체성이다. 상위 법령의 내용과 준수 방법 등을 알기 쉽게 구체적으로 설명해주어야 한다. 그러면 국민들은 가이드라인의 도움으로 법령이 요구하는 내용을 더 명확하게 이해하고 실행할 수 있다. 식약처의 임상시험에 관한 가이드라인이 여기에 해당한다. 이때 가이드라인은 꼭 준수해야 하는 의무가 아니고 가이드라인을 따르는 것이 가장 좋은 방법이라는 권고의 의미를 지닌다. 그래서 가이드라인이 제시한 방법이 아닌 다른 방법으로 임상시험을 추진해도 된다. 단, 그 내용과 결과가 법령이 정한 기준에 부합해야 하며 행위자는 식약처에 이를 설명해야 한다.

둘째, 일관성과 정합성이다. 상위 법령의 내용과 취지를 고수하고, 그 범위를 벗어나지 않는 일관성을 가져야 한다. 또한 타 법률과도 충돌하지 않는 정합성을 보여야 한다. 보건의료 데이터 활용 가이드라인은 개인정보보호법, 생명윤리법, 의료법 등과 충돌하는 문제를 드러내고 있는데, 타 법률과의 정합성이 부족하다고 평가할 수 있다.

셋째, 선도성이다. 아직 법령이 제정되지 못한 영역에서 사업 활동 등 국민의 행위를 규율하는 기능이다. 비대면 진료 가이드라인이 여기에 해당하며, 많은 신기술 분야

들에서 이런 상황이 반복해서 나타날 가능성이 크다. 이 경우의 문제점은 법령이 부재한 상황에서 법령의 기초적 형태를 먼저 가이드라인으로 제정하는 것이기 때문에 가이드라인이 행위자들을 규율하는 시장의 규칙 역할을 하는 경우가 많다는 것이다. 가이드라인은 법적 효력이 없으므로 가이드라인이 시장을 규율하는 역할을 하더라도 가이드라인을 준수하지 않는 주체를 제재하기 어렵다.

넷째, 선도성과 긴밀하게 연결된 이슈로 실효성의 문제가 있다. 가이드라인이 실효성이 있다는 것은 국민들이 일정한 방향으로 행동하도록 안내하고, 다른 방향의 행위를 막아 줄 수 있다는 의미이다. 이를 위해 가이드라인을 준수하지 않으면 제재할 수 있는 수단이 필요할 수도 있다.

〈표 7-5〉 가이드라인에 대한 기대와 법적 현실

가이드라인 제공자와 수요자들이 기대하는 가이드라인의 용도와 지향점	법률 전문가들의 판단
• 구체성: 법령의 내용과 준수 방법 등을 알기 쉽게 구체적으로 설명	• (Good) 가이드라인이 행정지도나 법령 해설서의 역할을 하는 경우로 가이드라인의 바람직한 활용 사례
• 일관성과 정합성: 상위 법령의 내용과 취지를 고수하고, 타 법률과도 충돌하지 않아야 함	• (Good) 가이드라인이 기본적으로 갖추어야 하는 요건
• 선도성: 법령이 제정되지 못한 영역에서 사업 활동 등 국민의 행위를 규율	• (Bad) 비록 한시적이라도 입법부의 법률 제정 권한을 침해할 수 있고, 가이드라인 미준수 행위를 제재할 수도 없음
• 실효성: 국민들이 일정한 방향으로 행동하도록 안내하고, 다른 방향의 행위를 막아 줌	• (Bad) 상위 법령에 제재 조항이 있고 가이드라인이 그것을 구체적으로 설명한 것에 불과하다면 문제가 없지만, 가이드라인만으로 미준수 행위를 제재하려고 한다면 문제

자료: 연구진 작성

법률 전문가들의 판단에 따르면 가이드라인은 행정규칙이 아니고 법령보충적 행정규칙은 더더욱 아니다. 행정지도나 법령 해설서로 보는 것이 타당하다. 법적 효력이나 구속력이 없는 것은 가이드라인의 한계가 아니고 장점이자 가장 본질적인 특성이다. 이런 이해를 전제하면, 〈표 7-5〉의 첫 두 가지 지향점은 바람직하고 달성 가능하지만, 나머지 두 가지 지향점은 심각한 문제가 될 수 있다. 법령이 제정되지 못한 영역에서 국민의 행위를 한시적으로 규율할 목적으로 가이드라인을 제정하는 것은 행정지도로서의 가이드라인의 법적 용도를 크게 벗어나는 것이고 행정부가 국회의 입법권을 침

해하는 행위가 될 수도 있다. 법적 구속력이 없으므로 실효성을 담보하기도 어렵다. 학회나 협회 차원에서 행위자 규약을 통해 가이드라인을 함께 준수할 것을 약속한다고 하더라도 그 약속을 준수하지 않는 행위자에 대해 제재할 방법이 없다. 상위 법령이 먼저 존재하는 경우에도 그 법령에 제재 조항이 없다면 가이드라인을 준수하지 않는 행위자를 제재할 방법이 없기 때문에 가이드라인의 실효성은 반감될 수 있다.

2. 좋은 가이드라인의 조건

가. 가이드라인과 행위자들의 이해관계 정렬

그렇다면 위와 같은 문제가 발생하지 않는 좋은 가이드라인의 조건은 무엇일까? 첫째, 가장 중요한 조건은 해당 가이드라인을 준수하지 않는 것이 행위자에게 득이 되는 상황이 없는 것이다. 모든 행위자들이 가이드라인을 지키는 동안 나 혼자 그것을 위반해서 내게 득이 되는 경우가 있다면 가이드라인을 지키지 않는 기회주의적 행동이 많아질 것이다. 그런데 가이드라인은 법적 구속력이 없고 제재 조치도 가질 수 없기 때문에 이런 기회주의적 행동을 막을 수 없고, 결국 가이드라인은 유명무실해질 수 있다.

가이드라인을 위반하는 것이 행위자에게 득이 되는 상황이 없으려면, 가이드라인의 지향점과 행위자들의 이해관계가 일치해야 한다. 즉, 가이드라인을 잘 지키면 행위자들의 이익도 극대화되는 그런 분야와 영역에서 가이드라인은 잘 작동될 수 있다. 이렇게 가이드라인을 준수하는 것과 행위자들의 이해관계가 일치하는 대표적인 영역으로 임상시험 가이드라인이나 각종 인허가 관련 가이드라인을 꼽을 수 있다. 여기서는 가이드라인을 지키지 않으면 자신만 손해이기 때문에 모두가 최선을 다해 가이드라인을 지키려고 노력한다.

나. 상위 법령을 통한 제재와 규율

그러나 가이드라인의 방향과 행위자들의 이해관계의 방향이 같은 경우보다는 다른 경우가 더 많을 것이다. 특히 시장을 규율하는 가이드라인들이 대부분 이런 성격을

떨 것으로 생각된다. 이런 경우는 가이드라인을 위반해서 자신의 이익만 극대화하려는 욕구가 커지는 반면 가이드라인 자체는 법적 효력이나 제재 수단이 없어서 이런 욕구를 통제하기 어렵다는 문제가 있다. 이런 경우라도 가이드라인의 상위 법령이 있고 그 법령에 제재 조항이 있다면 그 가이드라인을 위반하는 주체를 제재할 수단이 생긴다. 즉 가이드라인 자체로는 벌칙 조항을 넣을 수 없지만, 그 가이드라인이 구체화시킨 상위 법령을 통해 제재를 가할 수 있기 때문에 가이드라인은 정상적으로 작동할 수 있다. 따라서 좋은 가이드라인의 두 번째 조건은 상위 법령이 존재하는 것이다.

다. 가이드라인 매트릭스

위의 두 가지 조건을 조합하면 4가지 경우의 수가 생긴다. ① 가이드라인과 행위자들의 이해관계가 일치하면서 상위 법령을 통한 제재도 가능한 경우, ② 가이드라인과 행위자들의 이해관계가 일치하지만 상위 법령을 통한 제재는 어려운 경우, ③ 가이드라인과 행위자들의 이해관계는 다르지만, 상위 법령을 통한 제재는 가능한 경우, ④ 가이드라인과 행위자들의 이해관계도 다르고, 상위 법령을 통한 제재도 어려운 경우. 이 중에서 ①~③번은 가이드라인이 잘 작동할 수 있지만, ④번은 작동하기 어렵다.

〈표 7-6〉 좋은 가이드라인의 조건 매트릭스

가이드라인의 방향 = 행위자들의 이해관계	① 가이드라인과 행위자들의 이해관계가 일치하면서 상위 법령을 통한 제재도 가능	② 가이드라인과 행위자들의 이해관계가 일치하지만 상위 법령을 통한 제재는 어려운 경우
가이드라인의 방향 = 행위자들의 이해관계	③ 가이드라인과 행위자들의 이해관계는 다르지만, 상위 법령을 통한 제재는 가 능한 경우	④ 가이드라인과 행위자들의 이해관계도 다르고, 상위 법령을 통한 제재도 어려 운 경우
	상위 법령을 통한 제재 가능	상위 법령을 통한 제재 어려움

자료: 연구진 작성

그런데 ④번 상황은 신기술 분야에서 시장을 규율하는 제도들이 확립되기 전에 제품 시장이 먼저 열릴 때 자주 발생한다. 아직 해당 제품과 관련된 제도가 생기기 전이어서 상위 법령이 없고, 가이드라인이 한시적으로 법령의 역할을 담당하는 경우이다.

그러나 법률 전문가들의 판단에 따르면 ④번 상황은 가이드라인을 부적절하게 활용하는 경우이다.

3. 가이드라인의 적절한 활용을 위한 제언

이상의 분석으로부터 신기술 분야에서 가이드라인의 적절한 활용을 위한 주의사항을 다음과 같이 제안하고자 한다.

첫째, “복지부 장관 고시, 훈령, 예규 등 기존 행정규칙의 제목에 ‘가이드라인’이라는 단어가 들어간 경우는 가이드라인이 행정규칙이다. 그러나 이 경우를 제외하면, 즉 명시적으로 행정규칙임을 밝히지 않은 문서에 가이드라인이라는 이름이 들어간 경우에 가이드라인은 행정규칙이 아니고 법적 구속력이 없는 행정지도나 법령 해설서로 보는 것이 타당하다. 따라서 가이드라인의 역할에 대한 기대치를 낮추고, 가이드라인이 작동할 수 있는 환경에서만 활용하는 것이 필요하다. 가이드라인은 법적 구속력이 없고 위반 행위를 제재할 수단도 없기 때문에 ① 가이드라인과 행위자들의 이해관계가 일치해서 가이드라인의 준수를 기대할 수 있는 경우이거나 ② 상위 법령을 통해 가이드라인을 지키지 않는 행위자를 제재할 수 있는 경우에 한해 가이드라인을 활용하는 것이 적절하다.

이러한 활용이 가능한 대표적인 경우는 제품의 인허가에 필요한 기준, 절차, 방법을 알기 쉽게 풀어서 설명하고 여러 방법 중 최적의 방법으로 보이는 것을 안내하는 가이드라인이다. 이 경우 민원인은 이 가이드라인을 준수하는 것이 인허가를 위해 가장 좋은 대안이라고 보고 그 가이드라인을 준수할 수도 있고, 더 좋은 방법이라고 생각되는 다른 대안을 따를 수도 있다. 후자의 경우 자신이 택한 새로운 방법이 인허가 기관의 기준에 부합한다는 사실을 입증하기만 하면 문제가 되지 않는다.

둘째, 이렇게 가이드라인의 용도를 좁힐 경우, 신기술 분야의 연구개발과 제품 판매를 규율할 법령이 제정되지 않은 상태에서 한시적으로 가이드라인을 활용하는 관행은 지양되어야 한다. 이런 경우 시장 참여자들의 이해관계가 가이드라인이 지시하는 방향과 일치하지 않을 때 가이드라인을 준수할 유인이 감소하고, 가이드라인을 준수하

지 않아도 제재를 받지 않는다. 그래서 실제로 가이드라인을 위반하는 사례가 나타나게 되고 그 수도 점점 늘어날 수 있다.

셋째, 위와 같은 상황, 즉 법령이 없는 상태에서 신기술 제품이 등장하는 경우에 실효적으로 대응하기 위해서는 가이드라인이라는 수단을 쓰는 대신 국회에서 최대한 신속하게 법을 제정하는 것이 필요하다. 이를 위해 국회에 <신산업 입법 지원 연구소>를 설치하고 신기술 관련 입법을 미리 준비하고 지원하는 방안을 검토해보는 것이 필요하다.

참고문헌

제2장 가이드라인의 법적 지위와 현황

국가법령정보센터 <https://www.law.go.kr/>

황희윤(2014), 「행정규칙 심사·관리기준과 사례」 『법학논총』, 32, pp.231~253.

제3장 보건의료 데이터 가이드라인

개인정보보호위원회·보건복지부(2021.1), 「(2021년) 보건의료 데이터 활용 가이드라인」.

고학수 외(2018), 『해의 비식별 조치 가이드라인 등에 대한 비교·분석』, 한국인터넷진흥원.

김동희(2017), 『행정법 I』, 박영사.

김상태(2022), 「일본의 의료정보 활용 관련 법제도에 관한 연구」, 『생명, 윤리와 정책』, 6(1), (재)국가생명윤리정책원, pp. 1~31.

김수정(2022), 「독일의 디지털 헬스케어 법제」, 『법학논집』, 27(1), 이화여자대학교 법학논집, pp. 227~265.

김재선(2021), 「미국의 보건의료데이터 보호 및 활용을 위한 주요 법적 쟁점」, 『의료법학』, 22(4), 대한의료법학회, pp. 117~157.

김지희(2022), 「보건의료데이터 법제의 개선방안」, 『고려법학』, 106, 고려대학교 법학연구원, pp. 437~481.

보건복지부·개인정보보호위원회(2022.12), 「보건의료 데이터 활용 가이드라인」.

_____(2024.1), 「보건의료 데이터 활용 가이드라인」.

보건복지부 보도자료(2024.1.19.), 「보건의료데이터 가명처리 방법 개선, 개인정보 보호하고 데이터 활용 활성화한다」.

신태섭(2021), 「보건의료 데이터 활용 가이드라인의 의미와 과제」, 『의료법학』, 22(3), 대한의료법학회, pp. 31~55.

심우민(2017), 「개인정보 비식별 조치에 관한 입법정책적 대응과제」, 『NARS 현안보고서』, 305, 국회 입법조사처.

이기호·김계현(2020), 「보건의료 데이터 활용 가이드라인의 내용과 한계에 관한 연구」, 『과학기술법 연구』, 26(4), 한남대학교 과학기술법연구원, pp. 89~118.

이석배(2021), 「'보건의료 데이터 활용 가이드라인'의 현행법상 문제점」, 『의료법학』, 22(4), 대한의료법학회, pp. 3~35.

이하영·최봉석(2023), 「보건의료데이터 활용의 안정성을 위한 법적 쟁점과 입법방향의 고찰」, 『경희법학』, 58(4), 경희대학교 법학연구소, pp. 39~66.

정현학·장보은(2015), 「보건의료 빅데이터 관련 각국의 법체계」, 『보건산업브리프』, 208, 한국보건산업진흥원.

한국인터넷진흥원(2016), 「개인정보 비식별화 관련 해외 현황 및 사례」, 『KISA Report』.

Office of Civil. Rights(2012.11.26), *Guidance Regarding Methods for De-identification of Protected Health Information in Accordance with the Health Insurance Portability and Accountability Act(HIPAA) Privacy Rule.*

메디컬월드뉴스, <https://www.medicalworldnews.co.kr>

법률신문, <https://www.lawtimes.co.kr>

보건복지부, <https://www.mohw.go.kr>

内閣府, <https://www8.cao.go.jp>

개인정보보호법, 법률 제19234호(2023.3.14.)

Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA), Public Law 104-191.

제4장 비대면진료 가이드라인

가톨릭대학교 산학협력단(2023.11), 『의료취약지 의료지원 시범사업 현황분석에 따른 활성화 방안 마련 연구』, 보건복지부.

강병원 의원 대표 발의(2021), 「의료법 일부개정법률안」, 의안번호 2112756, 국회 의안정보시스템.

고순주·정성영(2020), 『일본 원격의료 정책의 분석과 시사점』, ETRI Insight 기술정책 이슈 2020-03, 한국전자통신연구원.

권주영(2020), 「원격의료 추진을 위한 선결과제 및 시사점: 일본을 중심으로」, 『한국융합학회논문지』 제11권 제12호, 한국융합학회.

김대중(2023.08.5.), 「비대면 진료 국내 현황 및 국외 사례: 일본과 프랑스를 중심으로」, 『보건복지포럼』 통권 제322호, 한국보건사회연구원.

김명수·김근주(2024.3), 「비대면의료서비스 확대를 위한 법정정책 고찰 -미국·독일을 중심으로-」, 『법과 정책연구』 제24집 제1호, (사)한국법정정책학회.

- 김민아·이경애(2018), 『의료소비자 관점의 주요국 원격의료 정책 비교 연구』, 정책연구 18-16, 한국 소비자원.
- 김민우(2024.01), 「원격의료 도입의 확대를 위한 법적 과제」, 『법학논고』 제84집, 경북대학교 법학 연구원.
- 김성원 의원 대표 발의(2023), 「의료법 일부개정법률안」, 의안번호 2121133, 국회 의안정보시스템.
- 김유석 외(2022.5), 『국내·외 비대면 진료 현황진단 및 쟁점분석』, 4차산업혁명위원회.
- 김인숙(2000.9), 「원격진료: 간호예의 응용」, 『간호학탐구』 9권 1호, 연세대학교 김모임간호학연구소.
- 김은정(2024.01.30.), 「비대면 진료 시범사업: 각계 의견, 문제점 및 개선 방향」, 『이슈와 논점』 제2183호, 국회입법조사처.
- 김종엽·이관익(2020), 「비대면 의료서비스의 장점 및 필요성」, 『대한내과학회지』 제95권 제4호.
- 김지연(2020), 「비대면 시대, 비대면 의료 국내외 현황과 발전방향」, 『KISTEP Issue Paper』 통권 제288호(2020-10), 한국과학기술기획평가원.
- 김진숙(2020), 「비대면진료, 의료계는 어떻게 대응할 것인가」, 『의료정책포럼』 Vol.18 No.4, 대한의 사협회 의료정책연구소.
- 김진숙(2024.01), 『비대면 진료 시범사업 현황과 개선방안 연구』, 정책현안분석 2023-05, 의료정책 연구원.
- 김진숙·오수현(2018), 「원격의료 정책현황 비교 분석 연구: 미국, 일본, 한국을 중심으로」, 『보건경제와 정책연구』 제24권 제1호, 한국보건경제정책학회.
- 김진숙·오수현(2024.6), 「비대면 진료 시범사업의 문제점과 개선과제」, 『대한의사협회지』 제67권 제6호, 대한의사협회.
- 김진숙·임지연·강주현(2022.4), 『원격의료 정책 현황과 대응방안 연구』, 연구보고서 2022-01, 의료 정책연구소.
- 김진숙·임지연·강주현(2022.12), 『비대면 진료 필수 조건 연구』, 연구보고서 2022-15, 의료정책연구소.
- 대한내과 의사사회(2023.5.22.), 「대한내과 의사사회 비대면진료 시범사업 가이드라인」.
- 류시원(2005.8), 「공공의료 확충을 위한 원격의료 활성화 방안」, 『보건복지포럼』 통권 제1206호, 한국 보건사회연구원.
- 류시원(2004.12), 『공공의료 강화를 위한 원격의료 수용성 제고방안』, 한국보건사회연구원.
- 박찬숙 의원 대표 발의(2007), 「의료법 일부개정법률안」, 의안번호 177383, 국회 의안정보시스템.
- 법제처 법제조정관법제관실(2023.6), 「비대면 진료 관련 의료법 개정 동향」, 법제처.
- 보건복지부(2013.11), 「동네 의원 중심의 의사-환자간 원격의료 추진방안」.

보건복지부(2020.2.), 「전화상담·처방 및 대리처방 한시적 허용방안」, 보건복지부 공고 제2020-177호.
보건복지부(2020.12.15.), 「「한시적 비대면 진료 허용방안」 안내」, 보건복지부 공고 제2020-889호.
보건복지부(2022.8.4.), 「한시적 비대면 진료 허용방안」 개정안 안내, 보건복지부 공고 제2022-575호.
보건복지부(2023.6), 「비대면진료 시범사업 추진방안」.

보건복지부(2023.9.1.), 「비대면진료 시범사업 제도기간 종료 및 시범사업 지침 개정 안내」, 중
「2. 비대면진료 시범사업 의료기관용 지침 개정내용」, 보건복지부 공고 제2023-611호.
보건복지부(2023.12.6.), 「비대면진료 시범사업 지침 개정안 공고」, 중 「4. 비대면진료 시범사업 약
국용 지침 개정내용」, 보건복지부 공고 제2023-827호.

보건복지부(2023.12.15), 「비대면진료 시범사업 보완방안 시행」, 보도참고자료.

보건복지부(2024.2.23.), 「비대면진료 시범사업 지침 개정안 공고」, 중 「4. 비대면진료 시범사업 약
국용 지침 개정내용」, 보건복지부 공고 제2024-134호.

보건복지부(2024.4.3.), 「비대면진료 시범사업 지침 개정안 공고」, 중 「비대면진료 시범사업 약국용
지침 개정본」, 보건복지부 공고 제2024-239호.

신현영 의원 대표 발의(2023), 「의료법 일부개정법률안」, 의안번호 2120760과 2121007, 국회 의안
정보시스템.

심재철 의원 대표 발의(2013), 「의료법 일부개정법률안」, 의안번호 1905383, 국회 의안정보시스템.

유기준 의원 대표 발의(2018), 「의료법 일부개정법률안」, 의안번호 2011704, 국회 의안정보시스템.

윤효영(2021.3), 「비대면 시대 원격의료의 정착을 위한 법제도 개선 방안」, 『법학논총』 제45권 제1호,
단국대학교 법학연구소.

이종성 의원 대표 발의(2022), 「의료법 일부개정법률안」, 의안번호 2118012, 국회 의안정보시스템.

이준명·곽동철(2020.9), 「디지털 헬스케어 활성화를 위한 산업·통상전략 -원격의료 서비스를 중심으로」,
TRADE FOCUS 2020년 35호, 한국무역협회 국제무역통상연구원.

이창진(2022.05.26.), 「원격의료 시범사업 20년 동안 효과성 검증 부실했다」, 『MedicalTimes』,
(<https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1147527>).

임지연·김진숙(2022), 「원격의료 관련 입법 논의 현황과 향후 과제」, 『인하대학교 법학연구』 제25집
제2호, 인하대학교 법학전문대학원.

정부(2010.4.8.), 「의료법 일부개정 법률안」 (의안번호 1808132호).

정부(2014.4.2.), 「의료법 일부개정 법률안」 (의안번호 1909995호).

정부(2016.6.22.), 「의료법 일부개정 법률안」 (의안번호 2000397호).

최혜영 의원 대표 발의(2018), 「의료법 일부개정법률안」, 의안번호 2112870, 국회 의안정보시스템.

코로나바이러스감염증-19중앙사고수습본부(2020.2.23.), 「코로나바이러스감염증-19 관련 전화상담·처방 및 대리처방 한시적 허용방안 안내」.

한국원격의료학회(2023.8.23.), 「비대면진료 가이드라인」.

総務省(2022.4), 『遠隔医療モデル参考書 -医師対医師 (DtoD) の遠隔医療版-』.

総務省(2024.5), 『遠隔医療モデル参考書 -オンライン診療版- 改訂版』, 別添.

総務省(2024.5), 『遠隔医療モデル参考書 -オンライン診療版- 改訂版』, 本編.

厚生省(1997.12), 「情報通信機器を用いた診療 (いわゆる「遠隔診療」) について」.

厚生労働省(2003.3), 「「情報通信機器を用いた診療 (いわゆる「遠隔診療」) について」の一部改正について」.

厚生労働省(2011.3), 「「情報通信機器を用いた診療 (いわゆる「遠隔診療」) について」の一部改正について」.

厚生労働省(2015.8), 「「情報通信機器を用いた診療 (いわゆる「遠隔診療」) について」の一部改正について」.

厚生労働省(2018), 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」.

厚生労働省(2019.7), 「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について」.

厚生労働省(2020.4.10.), 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」.

厚生労働省(2022.4), 「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について」.

厚生労働省(2023.3), 「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について」.

厚生労働省(2023.6), 「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」.

Aizenberg, M.(2022), *Regulatory Framework for Telemedicine: Current Status and Next Steps*, Inter-American Development Bank.

AMA(American Medical Association)(2022), *Telehealth Implementation Playbook*.

Sørensen, T.(2003), *Guidelines for a Country feasibility Study on Telemedicine*, Norwegian Centre for Telemedicine.

WHO(2021), *Global strategy on digital health 2020-2025*.

WHO(2022.11), *Consolidated Telemedicine Implementation Guide*.

제5장 유전자검사 가이드라인

경기도경제과학진흥원(2019), DTC 유전자 검사 서비스 동향 및 시사점, GBSA 산업기술동향, Vol.13
국가생명윤리정책연구원(2022.07.18.), DTC 유전자검사 서비스를 위한 가이드라인(유전자검사기관용)
(ver.1.0)

국가생명윤리정책원(2024.03.28.), DTC 유전자검사 서비스를 위한 가이드라인(유전자검사기관용) (ver.2.0)

국가생명윤리정책원(2024.06.28.), DTC 유전자검사 서비스를 위한 항목 신청 가이드라인(유전자검사기관용) (ver.2.0)

김명신(2021), DTC 유전자검사 항목 적절성 검토 연구

김훈기(2024), 한국 DTC 유전자검사 규제의 추이와 특성 - 2015년 생명윤리법 개정의 배경과 영향, 문화와융합 VOL.46 NO.01 PP.343-357

보건복지부(2020), 일반 소비자용 DTC 유전자검사 가이드라인(1차)

보건복지부·국가생명윤리정책원(2024.6.28.), 2024년도 하반기 DTC 유전자검사기관 검사역량인증 사업 설명회

임지숙(2024), 소비자직접의료(Direct-to-Consumer) 유전자검사의 현황과 전망, Laboratory Medicine Online, 2024, 14.3: 191-200.

정진화(2020), DTC (Direct-to-Consumer) 유전자 검사에 대한 효용성 관점의 한계와 정치적 대안 모색, 정치사상연구, 26(2), 137-164.

조소희(2020), 생명윤리관련 정책연구과제 자유공모 결과보고서- 유전적 계보학의 활용에서 유전 정보 보호에 대한 연구, 국가생명윤리정책원

MEDICAL WORLD NEWS, <https://www.medicalworldnews.co.kr/>

데일리한국 홈페이지, <https://daily.hankooki.com>

약사공론 홈페이지, <https://www.kpanews.co.kr>

전자신문 홈페이지, <https://www.etnews.com/>

제6장 디지털 치료기기 가이드라인

심보람, 주진한, 김현정, 김병수(2022), 『디지털 치료기기의 건강보험 적용방안』, 건강보험심사평가원 pp. 1-153.

유성희, 이상욱(2024), 「디지털 치료기기 규제 현황 분석 및 규제정책 개선방향」, 『과학기술법연구』, 30(2), pp. 139-176.

유소미(2024), 「디지털의료제품 정책 동향과 소비자 관점에서의 시사점」, 『소비자정책동향』, 제137호, pp. 1-27.

이성희, 배민호(2024), 「디지털 치료기기의 현황 및 개발 동향과 시사점」, 『전자통신동향분석』, 제39권 제4호

정준화(2023), 「디지털 치료기기의 안전하고 효과적인 활용을 위한 정보통신기술(ICT)의 과제」, 『이슈와논점』, 제2170호 pp. 1-4.

정지민, 신재용, 류규하(2023), 「국내 디지털치료기기 시장 활성화를 위한 정책 제언: 해외 주요국 제도 분석을 중심으로」, 『HIRA Research』3(2). pp. 130-141.

데일리팜 <https://www.dailypharm.com/>

메디파나뉴스 <https://www.medipana.com/>

바이오타임즈 <https://www.biotimes.co.kr/>

의사신문 <http://www.doctorstimes.com/>

의학신문 <http://www.bosa.co.kr/>

팜뉴스 <https://www.pharmnews.com/>